

중독 정신건강 표준 사례관리 매뉴얼

(2025년 개정판)



보건복지부
국립정신건강센터

중독정신건강 표준 사례관리 매뉴얼 2025년 개정판 머리말

국립정신건강센터는 국민의 정신건강 증진과 중독 문제를 경험한 대상자의 삶의 질 향상을 위해 지역사회 기반의 정신건강 전달체계를 강화하고, 이를 지원하는 정책 및 실무 사업을 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 중독관리통합지원센터, 정신건강복지센터 등에서 사례관리를 수행하는 실무자들이 보다 전문적이고 체계적인 서비스를 제공할 수 있도록 실무 중심의 지원 자료 개발에 힘써왔습니다.

이러한 노력의 일환으로 개발된 『중독정신건강 표준 사례관리 매뉴얼』은 중독 및 정신건강 전달체계 내 실무자들에게 실질적인 업무 가이드를 제공하고, 서비스 과정에서 표준화된 방식으로 사례관리 업무를 수행할 수 있도록 지원하기 위해 마련되었습니다. 특히 서비스 흐름을 기반으로 내용을 재구성하여 현장에서 바로 적용 가능한 실용성과 활용성을 높였습니다.



이번 2025년 개정판은 다음과 같은 방향으로 개선하였습니다.

첫째

사례관리 서비스 과정을 '대상자 발견 → 초기상담/단기개입(SBIRT) → 등록 → 초기 사정평가 → 개별 서비스 계획(ISP 수립) → 개입 → 점검 → 평가 → 퇴록'의 흐름으로 재정리하였고, 각 단계별 개입 방법을 명확히 제시하여 실무자가 실제 사례관리 과정에 쉽게 적용할 수 있도록 구성하였습니다.

둘째

단기개입(SBIRT) 영역은 최신내용을 반영하여 보완하였으며, 개입 대상에 따라 청소년과 성인으로 구분하여 사례관리자가 보다 효과적으로 접근할 수 있도록 구성하였습니다.

셋째

중독 문제에 대한 실무적 이해를 돕기 위해 중독의 특징을 알코올 중독, 기타 물질중독, 행위중독으로 구분하여 서술하였으며, 각 중독유형별 특성과 증상을 정리하였습니다.

각 센터에서 이를 지역 및 기관의 여건에 맞게 유연하게 적용하여 효과적이고 전문적인 사례관리를 수행할 수 있기를 기대합니다.



중독 정신건강 표준 사례관리 매뉴얼
(2025년 개정판)

Contents (목차)

Part 1

I. 중독 정신건강 사례관리 서비스의 이해	8
1. 중독 정신건강 사례관리의 개념	8
2. 중독 정신건강 사례관리의 특징	8
3. 중독 정신건강 사례관리의 원칙	9

Part 2

II. 중독 정신건강 사례관리 체계	12
1. 중독 정신건강 사례관리 서비스의 과정	12
2. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 서비스의 흐름	13
3. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 과정	14

Part 3

III. 서비스 과정	18
1. 대상자 발견 및 의뢰접수	18
2-1. 초기상담(Intake)	22
2-2. 단기개입(SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)	26
3. 초기사정(Initial Assessment, 사정평가)	27
4. 개별서비스계획(ISP: Individualized Service Plan 수립)	54
5. 개입	63
6. 점검 및 평가	70
7. 퇴록	73

Part 4

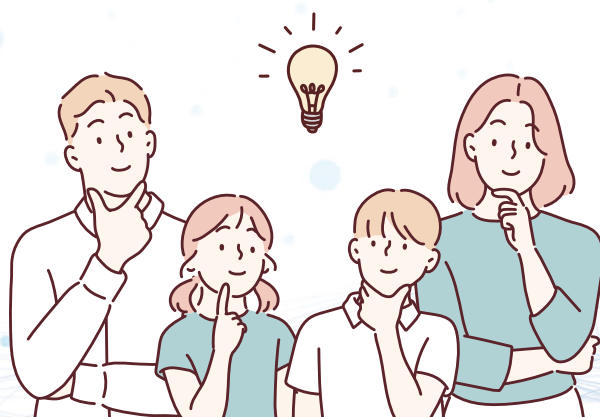
IV. 부록

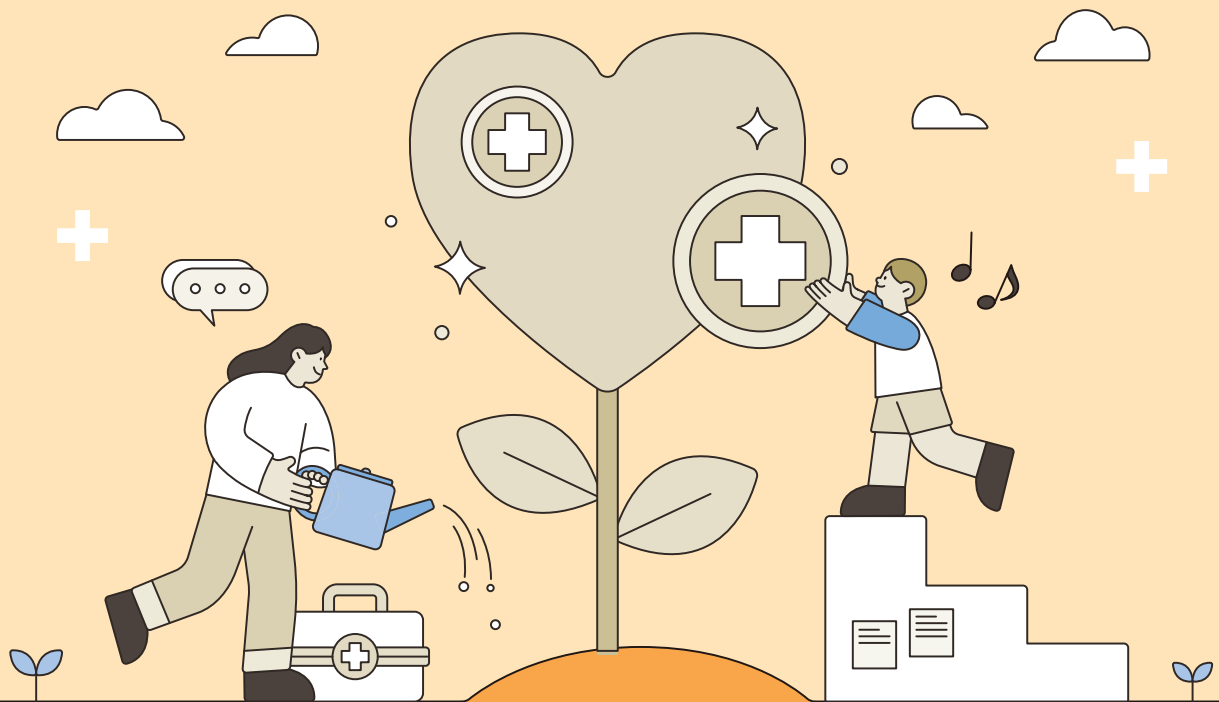
1. 중독의 이해	76
2. 중독의 특징	77
3. 정신심리·사회문화적 원인과 정신사회적 치료	86
4. 단기개입(SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)	92
5. 중독관련 정신건강 검진도구 및 사용	104
6. 중독 정신건강 사업 수행기관	118
7. 사례관리 서비스 모니터링 체계 및 슈퍼비전	119
8. 사례관리 윤리와 대상자 관리	121

Part 5

V. 참고문헌

124



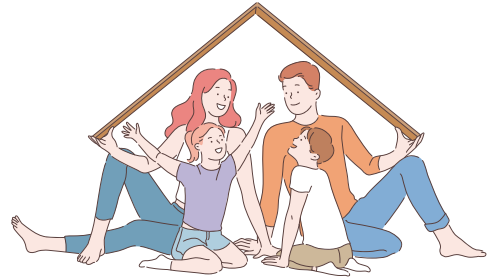


I

중독 정신건강 사례관리 서비스의 이해

1. 중독 정신건강 사례관리의 개념
2. 중독 정신건강 사례관리의 특징
3. 중독 정신건강 사례관리의 원칙

I 중독 정신건강 사례관리 서비스의 이해



1. 중독 정신건강 사례관리의 개념

- ▶ 중독정신건강 사례관리란 지역사회에서 중독 관련 문제 및 질환을 가진 대상자 또는 그의 가족이 건강한 삶을 유지하고 안정적으로 정착하기 위해 제공되는 모든 서비스를 의미한다.
- ▶ 사정평가를 통해 대상자 및 가족의 욕구를 파악하고 개별서비스계획(ISP: Individualized Service Plan) 수립에 따라 서비스를 통합, 조정, 제공하는 것이며 대상자는 지역사회 내에서 지속적인 서비스를 받을 수 있어야 한다.
- 정신건강 사례관리 서비스를 제공하는 방법
 - 심리사회적 상담서비스 및 가족지원
 - 대상자 욕구 및 필요에 따른 지역사회 자원을 탐색
 - 타 서비스 연계 및 행정절차 지원
 - 기관 간의 유기적 협력체계 유지 및 자원조정
 - 사회복귀 및 회복을 위한 재활프로그램 참여
 - 기타 교육 및 훈련 서비스

2. 중독 정신건강 사례관리의 특징

- ▶ 대상자의 회복을 위한 정신건강 상담서비스 및 내·외부 자원을 활용한 교육 및 훈련 등 포괄적인 재활서비스를 제공하는 것이다.
- ▶ 중독질환은 만성적이고 진행적인 특성을 가지며 재발을 반복하는 질환이므로 치료의 연속성을 유지하기 위한 지역사회 중심의 관리가 매우 중요하다. (한국중독정신의학회, 『중독정신의학 2nd EDITION』, 2019)
- 중독 관련 질환 외에도 복합적인 문제를 가지고 있기 때문에 통합적인 보건·복지 관련 서비스를 직접적으로 제공
- 정확한 욕구사정 및 개별화된 계획을 수립하고 제공된 서비스에 대한 적절한 점검과 정기적인 평가가 이뤄져야 함으로 사례관리자의 전문적인 역량 필수

3. 중독 정신건강 사례관리의 원칙

가. 포괄적 서비스 제공

- ▶ 대상자의 중독문제 및 신체적, 사회적 상황 또는 대상자, 가족 욕구에 맞게 개별화된 서비스를 제공한다.
- ▶ 중독질환은 다양한 생물학적, 심리사회적 요인이 복합적으로 작용하고 진단, 치료 및 돌봄과 교육, 상담, 고용, 가족 지원을 함께 고려 하여 다학제로 구성된 팀에 의한 서비스 제공이 필요하다.

나. 지속적인 서비스 제공

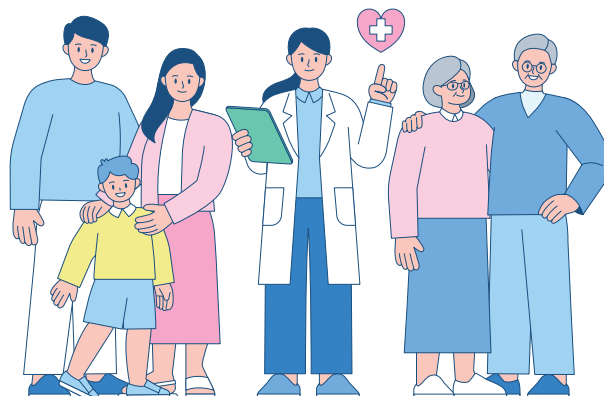
- ▶ 중독문제 및 질환은 단편적 개입 또는 단기적 치료만으로 회복되는 것이 아니며 지속적인 관리와 관찰을 해야 하는 만성질환임으로 대상별, 중독문제 수준에 따라 적합한 서비스를 지속적으로 제공한다.

다. 제공되는 서비스 간의 연계성

- ▶ 통합적 보건·복지서비스 및 필요한 정신건강서비스 제공 기관에 연계함으로 서비스 분산을 막고 유기적으로 서비스를 제공한다.
- ▶ 사례관리 담당자는 다양한 정신건강 서비스 전달체계 간 중개자 혹은 권익옹호자 역할을 수행한다.

라. 중독 사례관리 서비스의 유연성

- ▶ 대상자 및 가족은 지역사회 내 다양한 내·외적 요인의 영향을 받아 중독문제의 심각도가 달라질 수 있으므로, 이에 따라 개입 역시 유동적으로 조정되어야 하며, 수립된 계획 또한 변화된 상황과 상태를 반영하여 탄력적으로 수정·보완될 필요가 있다.



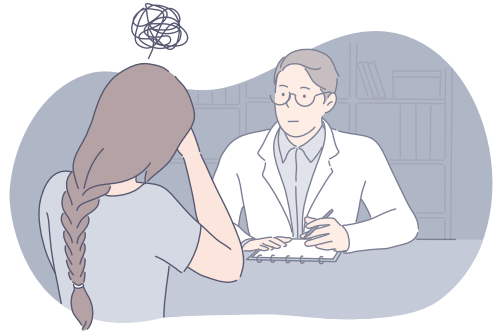


II

중독 정신건강 사례관리 체계

1. 중독 정신건강 사례관리 서비스의 과정
2. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 서비스의 흐름
3. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 과정

II 중독 정신건강 사례관리 체계

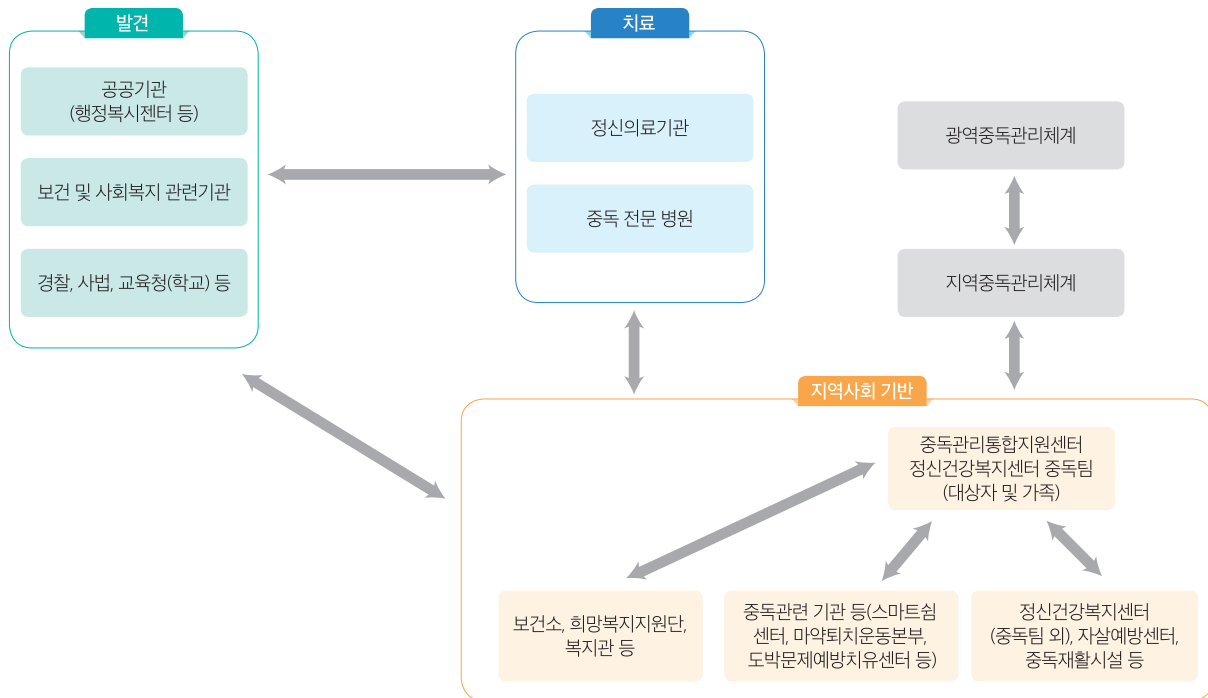


1. 중독 정신건강 사례관리 서비스의 과정

사례관리 단계별 기능		주요 사례관리 활동
초기상담 (Intake)	• 제공서비스 소개 • 서비스의 결정 • 사례등록 여부 결정	• 서비스의 목적과 과정에 대한 설명 • 일반적 정보 및 정신적 문제와 관련된 주 호소 등 정보 습득
사정	• 사례관리 확정 및 등록 • 대상자의 욕구사정 및 강점, 한계점 파악 • 자원사정 및 장애물 파악 • 가족의 정보 및 욕구 파악	• 대상자 및 가족의 신체적 정신적 건강상태에 대한 전반적 정보 수집 • 등록관리 중 정기적 재평가와 재사정 수행 및 기록
계획	• 욕구영역에 대한 특정화 • 명확한 목적·목표 설정, 달성 기간별 구분 구체화 • 수행자 선정 및 시간 분배 • 기대되는 변화 진술	• 욕구사정 도구를 이용한 관리구분 • 대상자의 능력 및 기술의 개선을 위한 목표의 우선순위와 장단기 구분 • 관리 등급에 따른 구체적 계획 작성
개입	• 직접 서비스(개별 및 가족상담, 그룹 프로그램, 자원조정 등) • 간접서비스(외부교육, 행사참여 등)	• 관리구분에 따른 직·간접적 사례관리 서비스 제공 • 대상자의 기본자원 점검 및 활용
점검	• 계획, 수행 결과의 질적, 양적 점검 • 사례회의 및 슈퍼비전을 통한 점검	• 대상자의 사회적 기능에 대한 평가 • 사례관리 계획의 이행 정도 점검
평가	• 계획에 대한 평가 • 서비스 목적 달성 평가 • 전반적 효과성 평가 • 대상자 만족도 평가	• 대상자의 기능수준 및 삶의 질 • 서비스에 대한 만족도 개선 여부 평가 • 수행과정 및 목표달성 분석 • 장애요인 분석 • 정기적인 재평가 및 재사정 수행 후 계획 재수립



2. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 서비스의 흐름



- ▶ 지역사회 내에서 발생하는 중독 정신건강 사례관리 서비스는 중독관리통합지원센터(또는 정신건강복지센터 내 중독팀)를 중심으로 지역정신보건체계 내에서 효율적인 사례관리를 제공하는 것을 목표로 한다.
- ▶ 중독관리통합지원센터는 정신보건체계와의 긴밀한 협조 아래 지역 내 의료기관, 정신건강복지센터, 정신재활시설, 기타 복지서비스 체계와 긴밀히 협조하여 대상자에게 필요한 서비스를 제공하고 대상자 유입 경로로 활용한다.

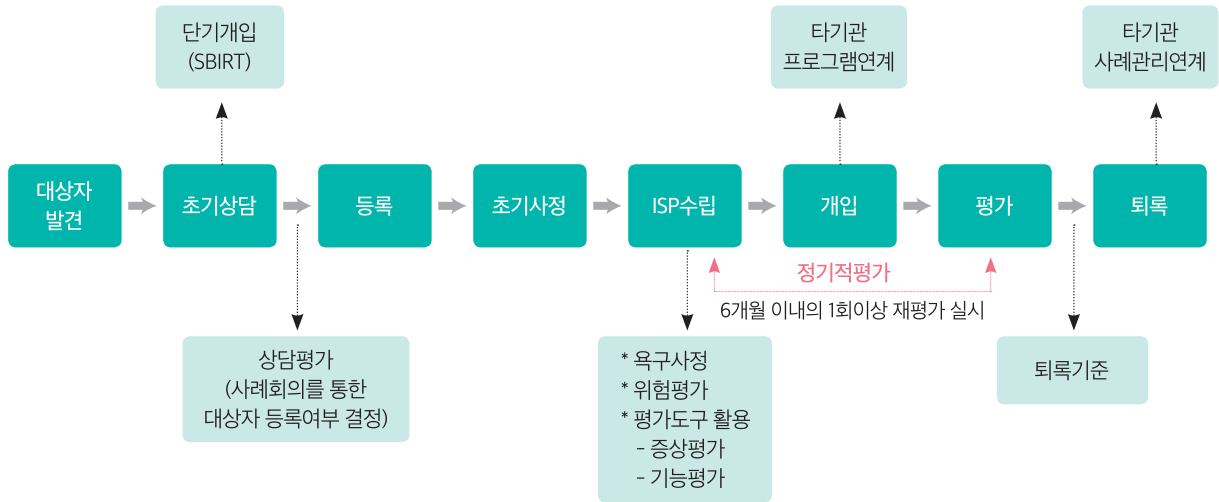
참고

기초정신건강복지센터의 중독관리업무 기준

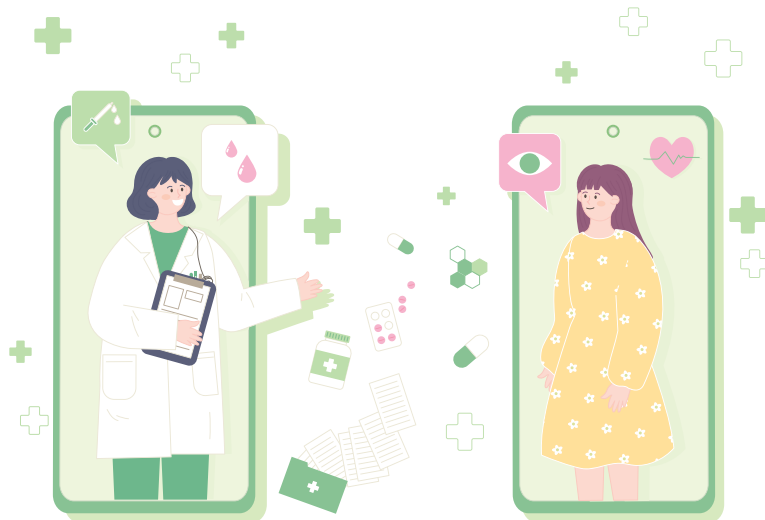
- 관내 중독관리통합지원센터 운영 시
 - 중독관리를 위한 협력체계로서 중독대상자 조기발견 및 의뢰
- 관내 중독관리통합지원센터가 없는 경우
 - 지역사회 네트워크 구축을 통한 중독사업 대상자 의뢰연계, 관리체계 활성화
 - 적절한 평가도구에 대한 전문적 이해와 경험을 통한 사정평가
 - 치료연계 및 모니터링
 - 사례관리 서비스 실시
 - 지역 네트워크를 통한 연속적 관리체계 구축 운영

(보건복지부, 『2025년 정신건강사업안내』, 2025)

3. 지역사회 내 중독 정신건강 사례관리 과정



- ▶ 지역 내 의료기관, 정신건강복지센터, 정신재활시설 등 복지서비스 체계를 통해 대상자가 유입이 되면 대면 상담을 시행하고 직접적인 평가를 시행한다.
- ▶ 상담 이후 기관 내 사례회의를 통해 대상자에 대한 등록 관리의 필요여부를 판단하고 대상자 및 가족의 동의를 받아 센터에 등록할 수 있으며 이때 욕구 사정과 평가를 실시한다.
- ▶ 욕구사정 결과를 바탕으로 관리 수준이 구분(위기/집중/유지/일시) 되고 이에 따라 개별서비스계획(ISP)이 수립된다.
- ▶ 일정 기간 서비스 제공 후 퇴록 기준을 검토하고 부합하면, 퇴록 시키거나 관리 구분을 변경할 수 있다.



MEMO





III

서비스 과정

1. 대상자 발견 및 의뢰접수

2-1. 초기상담(Intake)

2-2. 단기개입

(SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)

3. 초기사정(Initial Assessment, 사정평가)

4. 개별서비스계획(ISP: Individualized Service Plan 수립)

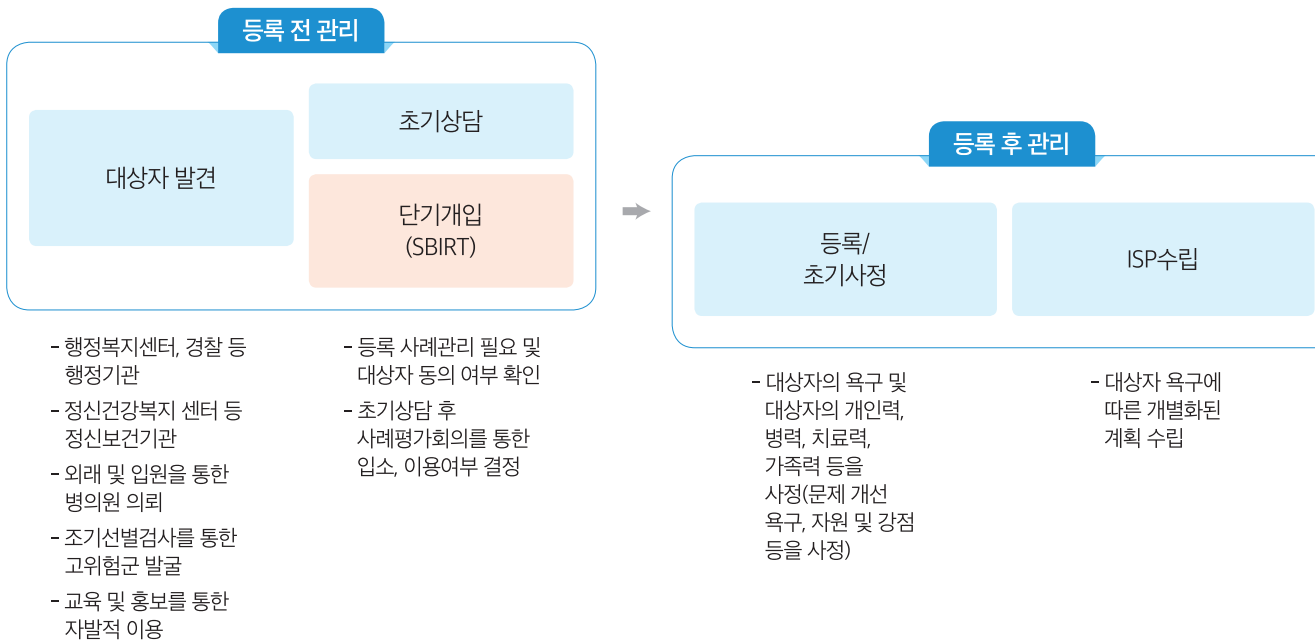
5. 개입

6. 점검 및 평가

7. 퇴록

III 서비스 과정

사례관리의 '대상자발견 -> 초기상담/단기개입(SBIRT) -> 등록/초기사정 -> 계획(ISP수립) -> 개입 -> 점검 -> 평가'의 과정에서 이뤄져야하는 단계별 수행과제는 다음과 같다.

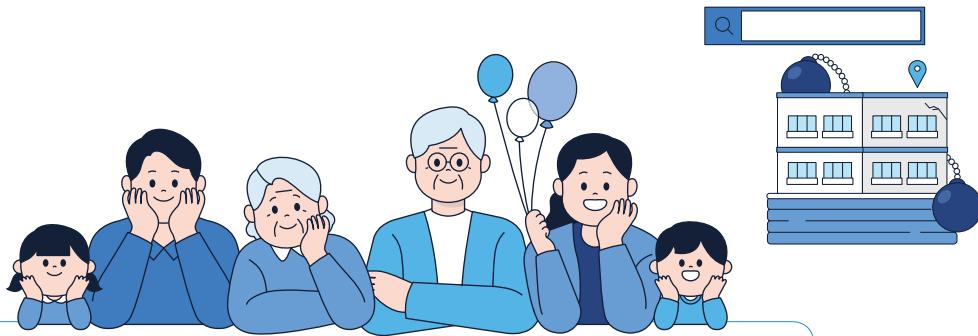


1. 대상자 발견 및 의뢰접수

- ▶ 지역사회 내에서 중독질환을 가지고 있는 대상자를 다양한 경로를 통해 발견하고, 지속적 사례관리가 필요한 대상인지를 평가한다.

가. 대상자 발견

- 중독 정신건강에 관심이 있거나 도움을 필요로 하는 대상자(중독자, 중독 위험군, 가족 등)가 직접 요청
- 지역사회 정신건강증진사업 시 조기선별검사를 통한 기관 자체 발굴
- 정신건강 관련 기관, 보건·복지기관, 학교, 행정기관 등을 통한 의뢰
- 의료기관 등의 퇴원(퇴소) 사실 통지를 통한 의뢰



개입

- 개별 및 가족상담
- 자원관리 및 조정
- 자회재활 프로그램
- 직업재활
- 대상자 욕구에 따른 타기관 서비스 연계 등

점검

- 사례회의를 통한 점검 및 수퍼비전
- 개별 서비스 계획에 따른 수행과정 및 결과에 대한 평가

평가

- 정기적 평가를 통한 서비스 지속여부 평가, 관리 구분 재배치 및 계획 재수립
- 퇴록여부 결정 등

퇴록

- 타 기관 사례관리 서비스 연계
- 퇴소 후 사후관리 실시

나. 의뢰접수

- ▶ 중독 사례관리에서 '의뢰'란 타 기관에서 본 기관으로 대상자에 대한 사례관리 서비스를 요청한 것을 의미하며, 의뢰대상자 및 가족의 동의가 있어야 한다.
- ▶ 의뢰접수는 본 기관에서 서비스 제공을 결정한 대상자를 접수하는 것으로 의뢰 받은 대상자의 의뢰 동의 여부, 의뢰하는 이유 등을 서면 또는 정신건강사례관리시스템을 통해 수신시 성립된다.

참고 의뢰서 양식(예시)

의뢰서					
의뢰기관		의뢰유형			
의뢰자		의뢰일자			
접수기관		응급여부	☐ 응급	☐ 비응급	
성명		성별	☐ 남	☐ 여	
생년월일		연락처			
주소					
진단		의료보장			
보호자(관계)		보호자연락처			
요청서비스	☐ 사례관리 ☐ 프로그램() ☐ 기 타()	회신요청	☐ 예	☐ 아니오	
의뢰사유					
년 월 일 OOO중독관리통합지원센터					
접수일자		접수자		프로그램 종료일자	

참고

중독관리통합지원센터 연계기준(알코올 중독)

- 알코올중독으로 인해 자타해의 위험성이 의심된다.
- 알코올중독에 대한 사정평가 및 치료기관 의뢰가 필요하다.
- 알코올중독의 문제점을 인식하고 도움을 요청한다.
- 알코올중독의 잦은 재발로 입·퇴원을 반복한다.
- 알코올중독으로 인한 퇴원 이후 지역사회 적응에 지속적인 지원이 필요하다.

(한국사회보장정보원, 『통합사례관리 실천가이드』, 2023)

다. 등록대상(중독 정신건강 사례관리 등록기준)

- ▶ 지역사회 내 중독문제가 있어 고위험군 이상으로 선별된 대상자 및 가족을 말한다.
- ▶ 의료기관 또는 정신요양시설 등에서 퇴원(소)한 중독자로 사회적응 훈련을 필요로 하는 자를 포함한다.
- ▶ 대상자의 존재여부는 파악되었으나 퇴원 여부가 불확실하여 당장의 구체화된 서비스 계획수립 및 서비스 제공이 어려울 것으로 판단되는 경우에는 지속적으로 정신의료기관의 사례담당자와 소통을 통해 퇴원 계획이 수립될 수 있도록 노력해야 한다.

1) 알코올 사용 장애

- 알코올 사용장애 선별검사(AUDIT-K) 결과, 고위험 음주 이상의 문제가 있는 경우
- 알코올 사용장애, 음주로 인한 신체적·법적·직업적·사회적 기능 수행의 문제 발생
- 음주로 인한 가족 갈등 및 해체 등의 문제
- 알코올 문제와 공존정신질환이 존재하는 경우

2) 마약(약물) 사용자

- 마약(약물)으로 인한 신체적·법적·직업적·사회적 기능 수행의 문제가 발생한 경우
- 마약(약물)으로 인한 가족 갈등이나 해체 등의 문제가 발생한 경우
- 마약(약물) 사용자에게 공존 정신질환이 존재하는 경우
- 기존 사례대상자 혹은 선별대상자 관리 과정에서, 마약(약물) 사용 관련 이력이 확인되는 경우

3) 도박중독

- 도박관련 평가척도 결과, 중위험군 이상의 도박문제를 가지고 있는 경우
- 도박문제와 공존 정신질환이 존재하는 경우
- 도박문제로 인해 가족 갈등이나 해체 등의 문제가 발생한 경우
- 도박으로 인한 경제적·법적·직업적·사회적 기능 수행의 문제가 발생한 경우

4) 인터넷 중독

- 인터넷 중독 선별검사(IGUESS) 결과, 잠재적 위험 사용자 이상으로 나타난 경우
- 19세 미만의 아동·청소년은 정신건강증진센터에 연계하며, 중독의 심각성에 따라 타 기관과 협력하여 사례관리 진행
- 인터넷 중독 문제와 공존 정신질환이 존재하는 경우
- 인터넷 사용으로 인한 신체적·법적·직업적·사회적 기능 수행의 문제가 발생한 경우

5) 가족대상자의 등록

- 중독질환자의 가족이 중독문제를 가진 고위험군 이상의 중독질환자로 인해 가족해체 및 갈등을 겪고 있거나 신체적, 정신적, 사회적인 면에서 문제나 역기능의 발생으로 전문적 서비스 제공이 필요한 경우
- 중독질환자의 서비스 거부를 전제로 하여 가족을 대상자로 등록

6) 사회적 취약계층을 우선순위로 등록관리

- 사회적 취약계층: 국민기초생활보장 수급권자 및 차상위 계층, 이주여성 및 자녀, 북한이탈주민 등

2-1. 초기상담(Intake)

- ▶ 초기상담은 등록 전 과정으로 대상자가 센터로 내소하거나 사례관리자가 대상자가 있는 곳으로 방문하여 진행한다.
- ▶ 대상자에게 사례관리에 대한 목적과 과정을 안내하고, 대상자의 기본적인 인적사항, 의뢰 경로, 주요 중독문제, 현재 치료여부, 지지체계, 자살위험성 등을 파악하여 이후의 사례관리 과정이 진행될 수 있는 공간을 마련한다.
- 등록관리에 대한 대상자(중독자 또는 가족)의 동의 여부 확인
- 초기상담 이후에는 사례회의를 통해 등록관리 서비스가 적합한지를 평가
 - 평가 결과상 등록관리가 적합하지 않은 경우 단기상담(SBIRT), 단순 서비스 제공 또는 종결
 - 평가 결과상 타 영역의 서비스 제공이 필요한 경우 타 기관 정보제공 또는 대상자 동의 후 연계한 뒤 종결
- 초기상담 구성 내용
 - 기본 정보: 성명, 성별, 나이, 연락처, 주소, 보호자 정보, 의료보장 및 장애등록 정보, 진단명, 치료병원, 주치의, 의뢰경로 등
 - 상담 내용: 주 호소(Chief Complaint) 및 주요중독양상, 중독관련 과거력 및 치료력, 정신 및 신체질환 정보, 중독으로 인해 발생 되는 일상생활문제, 지지체계(가족, 친척, 학교) 등
 - 중독문제 사정: 금단현상, 다른 중독문제, 중독문제경험(중독문제 회복 시도횟수, 최장 중독문제기간, 회복 노력 방법) 등
 - 자살위험성: 자살시도로 인한 치료이력, 당시 음주여부, 기타 자살시도력, 횟수, 자살계획, 주변인 자살유무, (과거) 자살시도방법, (계획) 자살시도방법 등
 - 상담결과: 상담자 의견, 개입계획(등록여부, 관련기관 연계, 단기개입 시행 여부) 등
 - 기타: 타해 위험성, 선별검사를 활용한 등록 전 사정평가 등
- 위험사정과 이후의 위기개입계획은 위험을 최소화하기 위해 필수적인 것으로 초기상담 및 사정뿐만 아니라 이후에 정기적인 평가 시에도 함께 이루어져야 함
 - 폭력에 대한 과거력
 - 분노조절장애
 - 폭력이나 공격성과 관련된 알코올 및 약물 사용
 - 가정폭력 상황 파악
 - 치료·약물 순응도, 재발 및 폭력과 관련된 요인들
 - 주거 불안정
 - 대상자에게 위험이 될 수 있는 가족관계, 대상자가 위험을 줄 수 있는 가족관계
 - 주요 정신건강상태 지표(예를 들어, 폭력행동을 조장하는 환경이나 예기치 못한 행동을 일으킬 수 있는 피해망상)
 - 최근 정신건강상태 변화와 이로 인한 서비스 이용 감소
 - 위기평가도구의 활용
 - * 위험 사정 후 입원치료의 필요성을 사정할 때 상황의 긴급성에 대한 판단이 우선
 - * 정신질환으로 인해 긴급한 상황이 야기되었거나 자해 및 타해 위험으로 보호조치가 필요한 경우에는 응급입원을 최우선
 - * 긴박한 상황이 아니면 대상자에게 입원치료가 필요한지, 대상자가 입원 의사가 있는지, 보호의무자가 있는지 등을 자세히 평가하고 이에 따라 입원절차 관련 개입 필요

참고

초기상담 기록지(각색가례 예시)

초기상담 기록지(Intake sheet)

대상자	성명	엠센터		성별/나이	남/55세
	전화	010-0000-0000		의료보장	의료급여 1종
	장애등록	없음		진단명	알코올 사용장애
	치료병원	국립정신건강센터		주치의	Dr. 사업과
	내과 및 기타질환	고혈압, 당뇨		의뢰경로	가족(모)
	주소	서울시 광진구 용마산로 00길			
상담 내용	<상담 기록 내용> ·주호소(Chief Complaint) 및 주요 증독 양상: ·중독관련 과거력 및 치료력: ·정신 및 신체질환 유무: ·중독으로 인해 발생하는 일상생활 문제: ·지지체계:				
중독 문제 사정	금단현상	☒ 손떨림 ☒ 오심 · 구토 ☐ 초조 ☐ 환각()	☐ 맥박증가 ☐ 설사 ☒ 불안 ☐ 진전섬망	☒ 발한 ☐ 두통 ☒ 우울 ☐ 기억상실	☐ 기운없음 ☐ 통증 ☒ 불면증 ☐ 기타()
	다른 중독문제	☒ 알코올 ☐ 도박	☒ 담배(15개피/일) ☐ 인터넷	☐ 향정신성 약물() ☐ 기타()	
	중독 문제 회복 경험	1) 회복시도: 1회 2) 최장 회복기간: 3) 회복 노력 방법:			
자살 세부 항목	치료력	☒ 있음 ☐ 없음	음주여부	☐ 있음 ☒ 없음	
	과거자살시도력	☒ 있음 ☐ 없음	시도 횟수	(1)회	
	자살계획	☐ 있음 ☒ 없음	주변인 자살		
	(과거)시도방법 (중복가능)	☐ 음독(농약, 청산가리, 수면제) ☒ 운수사고(자동차, 기차 등) ☐ 질식(목매, 가스)	☐ 추락(건물, 강 등) ☐ 홍기(칼 등) ☐ 정보없음	☐ 화상 ☐ 기타 ☐ 없음	
	시도계획방법	☐ 음독(농약, 청산가리, 수면제) ☐ 운수사고(자동차, 기차 등) ☐ 추락(건물, 강 등)	☐ 질식(목매, 가스) ☐ 홍기(칼 등) ☐ 정보없음	☐ 화상 ☐ 기타 ☒ 없음	
상담 결과	* 정신건강의학과 치료 권유하고 등록 서비스 권유 - 음주문제로 인한 금단증상, 불면, 영양 불균형, 일상생활 문제 발생으로 정신과적 치료 필요성 설득 - 신체적 상태 평가 및 개입을 위한 보건소/병의원 방문하여 신체적 질환 진료 권유 - 센터 서비스 안내하고 등록할 수 있도록 설득, 단회기 SBIRT 계획				

참고

초기상담 내용 및 상담결과(각색사례 예시)

상담내용

• 주 호소(Chief Complaint)

- 대상자: 매일 술을 마시지 않고는 하루가 힘들고, 잠을 잘 수도 없어요
- 보호자(형): 회사도 그만두고 집에서 밥도 먹지 않고 술만 마셔요, 몇 달 사이에 살도 많이 빠지고 밤에 잠도 못 자요

• 중독관련 과거력 및 치료력

- 과거 사업 실패와 직장에서 오는 스트레스를 술로 푸는 등의 행동으로 음주 문제 시작, 아내와의 이혼, 거둬진 사업 실패로 조절되지 않는 음주, 금단, 신체건강의 문제(Weight loss, 고혈압) 심각, 현재 무직으로 혼자 거주하다 2달 전 대상자의 사정을 알게 된 형의 권유로 형의 집에서 함께 살고 있음
- 생활비는 형에게 받으며 그 외에 보험 대출금으로 생활하고 있음, 정신과 병력 없으며 형의 말에 의하면 대상자 음주 문제로 식사하지 않고 집에만 있어 상담을 위해 내소했다고 함
- 치료력: 단기간 전문상담, 자조모임 참여한 적 있음, 정신과적 치료력 없음

• 정신 및 신체질환 유무

- 주요 중독 양상: Alcohol(소주, 막걸리 2~3병, Daily)
: 조절되지 않는 음주 문제, 금단증상(손 떨림, 초조, 불안, 오심·구토)

1) 최초 중독시기(45세)/빈도 및 양(소주 1~2병/주2~3회)

운전면허 학원을 운영 하면서 자신보다 어린 사람들이 자신에게 막말하는 등의 일이 있을 때는 일에 대한 회의를 느끼며 스트레스를 많이 받아 퇴근 후 혼자 음주하는 일이 많아짐

2) 문제발생 시작시점(52세)/빈도 및 양(소주 1~2병/Daily)

이혼 후 원룸 생활을 하며 호프집을 시작하였으나 적자가 나면서 대출이자를 제때 상환하지 못하게 되고 빚이 늘어나게 되자 매일 술을 마시게 됨

3) 마지막 시기(55세)/빈도 및 양(소주 2~3병/Daily)

아파트 경비일을 하면서 사람들에게 무시 받거나 불규칙한 근무시간으로 인한 스트레스가 높아지게 되면서 매일밤 마시는 술로 인해 다음날 출근을 하지 못하는 상황이 되풀이 되어 일을 그만두게 됨

- 정신질환: 우울감 및 불면증, 충동성, 정서적 불안정, 자존감 저하
- 신체질환 및 문제: 고혈압·당뇨(약물복용), 불규칙적 식습관 및 체중 감량
- 사회·경제적 문제: 최근 3달 동안 무직 상태로 혼자 지내며 지지체계가 부족한 상황
- 가족력: 없음

• 중독으로 인해 발생하는 일상생활 문제

- 과거 계속된 사업실패와 이혼(5년 전)·경제적 어려움 등으로 음주 문제 발생, 음주문제로 최근 5개월 전 회사 측에서 권고사직으로 퇴사(아파트 경비)
- 주취 및 법적문제: 계속된 음주로 고성방가, 난동의 문제행동으로 이어져 민원 신고(112) 다수 발생

• 지지체계(가족사항, 도움을 받을 수 있는 자원)

- 형(60세): 미혼, 대상자와 함께 거주하며, 사이가 좋은 편으로 주 보호자 잦은 해외 출장으로 인해 집에 거주하는 시간이 적은 편
- 아들(22세): 현재 군 복무 중으로 대상자와 전화 통화로 가끔 연락, 대상자의 건강이 악화된 이후로 만난 적 없음

• 중독문제 사정

- 금단증상: 손떨림, 오심, 구토, 식은땀
- 다른중독문제: 흡연
- 중독문제경험: 1년 전, 1회, 1주일 유지(음주문제에 대한 인식으로 단주하였으나 금단증상으로 재음주)

상담내용	• 자살사고/시도/계획 - 자살사고(-), 계획(-) - 자살시도(+): 충동적으로 차길에 뛰어들었으나 사고는 없었음 • 등록 전 사정평가<table><tr><th>척도명</th><th>검사일시</th><th>결과 및 소견</th></tr><tr><td>AUDIT-K</td><td>5/14</td><td>24점 위험 음주군: 고위험 음주자</td></tr><tr><td>CES-D</td><td>5/14</td><td>20점 경미한 우울</td></tr><tr><td>HAIS</td><td>5/14</td><td>-10점 부정병식</td></tr></table>	척도명	검사일시	결과 및 소견	AUDIT-K	5/14	24점 위험 음주군: 고위험 음주자	CES-D	5/14	20점 경미한 우울	HAIS	5/14	-10점 부정병식
척도명	검사일시	결과 및 소견											
AUDIT-K	5/14	24점 위험 음주군: 고위험 음주자											
CES-D	5/14	20점 경미한 우울											
HAIS	5/14	-10점 부정병식											
상담결과	• 정신건강의학과 치료 권유하고 등록 서비스 권유 - 음주문제로 인한 금단증상, 불면, 영양 불균형, 일상생활 문제 발생 -> 이에 정신과적 치료 필요성 설득 - 신체적 상태 평가 및 개입을 위한 보건소/병의원 방문하여 신체적 질환 진료 권유 - 센터 서비스 안내하고 등록할 수 있도록 설득, 단회기 SBIRT 계획												



2-2. 단기개입(SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)

- ▶ 초기상담 이후 중독문제가 위험수준 이상인 대상자에게 집중단기개입(3회기)을 제공한다.
 - 중독 정신건강 사례관리를 수행하는 기관이 아니라도 대상자의 중독문제사정, 등록유도 등 필요시 단기개입(SBIRT) 진행 가능
- ▶ 단기개입을 통해 중독자의 중독문제중단 동기를 확립하고 절중독 또는 중독문제중단 목표를 설정할 수 있도록 지원한다.
- ▶ 집중단기개입서비스는 반드시 대면상담으로 수행하며, 각 회기별로 20분 이상 상담한다.

- 중독문제에 대한 선별과 1회기 단기개입(알코올/약물/담배/도박/인터넷)
- 음주·흡연 및 약물사용 선별과 단기개입(SBIRT-ASSIST)
- 문제성 음주의 선별과 단기개입(SBIRT-AC)
- 문제성 도박의 선별과 단기개입(SBIRT-PG)
- 청소년 음주의 선별과 단기개입(SBIRT-AC for adolescent)
- 청소년용 인터넷/게임 중독 선별과 단기개입(SBIRT-IAD)
- 청소년 온라인 도박의 선별과 단기개입(K-SBIRT-AG)

참고

초기상담시 정신건강 표준사례관리시스템 입력기준

- 기관에서 첫 대면하여 상담하는 대상자의 경우 접수상담 상담이력에 '최초상담' 표기 필수
 - 기초센터에서 의뢰받은 대상자 A가, B 중독관리통합지원센터에 첫 대면 하는 경우 -> B 중독센터에서는 '최초상담' 표기해야 함
- 의뢰받은 기관에서는 초기상담 중 필요에 따라 단기개입(SBIRT) 회기를 진행할 수 있음, 이 경우에는 상담유형에 접수상담기록과 단기개입 기록을 각각 입력하지 않고, 접수상담 상담유형을 '(중독) 단기개입(SBIRT)'로 표기한 후 단기개입(SBIRT) 회기 기록을 중심으로 기록함
- 중독 정신건강 사례관리 미시행기관에서 초기상담 이후 등록유도, 기관연계를 위해 단기개입(SBIRT)를 수행하고 연계된 경우
 - 사례를 연계하는 기관에서는 의뢰서에 단기개입(SBIRT) 수행일시, 내용 등을 기록하여야 함, 의뢰를 받은 중독 정신건강 사례관리 기관에서는 의뢰한 기관의 단기개입(SBIRT) 내용을 근거로 이후 회기부터 서비스를 제공할 수 있음
 - 예시) A 기초센터에서 단기개입(SBIRT) 2회 진행한 대상자 -> 의뢰받은 B 중독센터에서 3회기만 진행 가능: A 기관에서 단기개입 2회기에 대해 사례관리시스템 상담내용에 기록이 있어야 하며, A 기관에서 B 기관에 제출하는 의뢰서에도 단기개입 2회기까지 했음을 전달해야 함

3. 초기사정(Initial Assessment, 사정평가)

- ▶ 단기개입(SBIRT) 또는 초기상담 이후 등록기준에 적합한 대상자에게 사례관리를 제공하기 위해 초기사정 평가를 실시한다. 사정평가는 대상자 상태에 대해 광범위하고 포괄적인 사정(Assessment)을 시행하고 구조화된 평가가 이뤄지는 과정이다. 또한 사정평가의 결과는 대상자의 서비스 개입 계획(ISP) 수립 시 반영된다. 사정 평가는 인적정보, 병력정보, 치료정보, 재활정보, 정신건강상태평가(MSE)로 이루어져 있다.

구분	내용
1. 인적정보	
2. 병력정보	발달력
	병력
	자살시도력
	가족력
3. 치료정보	진단력
	치료력
	치료약물
	신체질환
	입원력
4. 재활정보	중독문제/중독문제 중단 경험
	정신보건서비스 이용경험
	직업력
5. 정신건강상태평가(MSE)	외관
	태도
	행동
	언어
	기분
	지각
	사고
	인지
	판단력
	병식(insight)

참고

초기사정평가기록지(Initial Assessment)(예시)

초기사정평가기록지(Initial Assessment)

상담일시		대상자	
정보제공자	성명 /성별 /나이	연락처	
	의뢰경로 ☐ 행정기관 ☐ 의료기관 ☐ 정신보건기관 ☐ 본인 ☐ 지역사회기관 ☐ 기타()	상담유형	☐ 전화 ☐ 내소 ☐ 방문 ☐ 기타()
	이용경로 예) 홍보, 기관홈페이지, 인터넷, 유관기관연계 등	의뢰내용	
중독문제사정	성명 /성별 /나이	연락처	
	주민등록 번호		
	주소 (실거주지)	거주형태	☐ 독립주거지 ☐ 임대주거지 ☐ 시설거주 ☐ 주거지 없음 ☐ 자가 ☐ 전세 ☐ 월세 ☐ 일세(쪽방) ☐ 쉼터 ☐ 기타
	가족형태 ☐ 부부와 양(편)친 ☐ 부부 ☐ 부부와 미혼자녀 ☐ 독거 ☐ 편부모와 미혼자녀 ☐ 부부와 양(편)친과 자녀 ☐ 기타가족(3세대, 4세대, 기타)	결혼여부	☐ 미혼 ☐ 결혼 ☐ 동거 ☐ 별거 ☐ 이혼 ☐ 사별
	정신장애 등록여부 (급수)	의료보장	☐ 건강보험 ☐ 차상위 ☐ 의료급여1종 ☐ 미가입 ☐ 의료급여2종 ☐ 미상
	결혼상태 ☐ 미혼 ☐ 결혼 ☐ 동거 ☐ 별거 ☐ 이혼 ☐ 사별	진단명	
	최종학력 ☐ 무학 ☐ 초등학교 ☐ 중학교 ☐ 고등학교 ☐ 대학교 ☐ 대학원 ☐ 기타()	경제상태	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하
중독문제사정	주호소 C,C	문제자각	대상자: ☐ 예 ☐ 아니오 가족: ☐ 예 ☐ 아니오
	중독문제 ① 첫 중독문제 ② 문제발생 ③ 마지막 중독문제	④ 현재 중독 문제 ⑤ 기타	

정보 제공자	중독질환 과거력 및 치료 (입원)력		복용약물 및 관리	☐ 유 ☐ 무
	정신질환 과거력 및 치료 (입원)력	① 우울장애 ② 불안장애 ③ 양극성장애 ④ 섭식장애 ⑤ 기타()		
			복용약물 및 관리	☐ 유 ☐ 무
	신체질환 과거력 및 치료력	☐ 고혈압 ☐ 갑상선 ☐ 당뇨 ☐ 에이즈 ☐ 간경화 ☐ 간염 ☐ 신부전 ☐ 결핵 ☐ 비만 ☐ 뇌혈관질환 ☐ 암() ☐ 골다공증 ☐ 기타()	복용약물 및 관리	☐ 유 ☐ 무
		혈압: 맥박: 체온: 혈당:		
	중독으로 인한 문제 발생	☐ 지인과의 갈등 ☐ 가족의 가출 ☐ 건강악화 ☐ 의심증 ☐ 타인에게 실수 ☐ 신뢰를 잃음 ☐ 정신질환 ☐ 이혼 ☐ 자녀와의 갈등 ☐ 개인위생문제 ☐ 신체질환 ☐ 별거 ☐ 주거위생문제 ☐ 타해 및 폭력 ☐ 가정불화 ☐ 부부싸움 ☐ 자녀의 학교 부적응 ☐ 학업문제 ☐ 물건, 소지품 유실 ☐ 통증여부(발생시기, 이유) ☐ 기타() ☐ 경제적 손실(술값, 신용카드 빚, 벌금, 합의금 등) ☐ 가족에게 폭력(언어, 정서, 신체, 성폭력) ☐ 식사상태: 식욕(좋음, 보통, 나쁨)/체중변화(있음, 없음)/영양상태(좋음, 보통, 나쁨) ☐ 수면상태: 잠잠, 잠들기 힘들, 자주 깼, 전혀 못잠 ☐ 직업문제(지각, 결근, 조퇴, 직무수행차질, 업무능력저하, 동료와의 갈등, 해고 등) ☐ 음주운전(횟수: 법적조치:) ☐ 법적문제(폭행, 사기, 갈취, 성범죄, 빚, 살인, 공갈/협박, 주거침입)		
	지지체계	☐ 가족() ☐ 지인() ☐ 기관() ☐ 기타()	가족력	
	타중독문제	☐ 담배(개피/일) ☐ 알코올 ☐ 항정신성약물 ☐ 도박 ☐ 인터넷/게임 ☐ 기타		
중독문제 회복경험	1) 회복경험: ① 예 기간() 시도횟수() ② 아니오 2) 최장 회복기간: 3) 회복 노력 방법과 이유: 4) 중독문제 모임 참여여부: ① 아니오 ② 예: 종류() 5) 회복노력 실패이유:			

자 · 타 해 위 험 성	자살/ 자해력	□무 □유(시도 : 회)	자살방법		주변인자살	
		구체적인 자살/자해사고 언제 : 어디서 : 무엇으로 : 어떻게 :	※ 자살/자해방법 참고(중복가능)			
	시도계획 방법		1) 음독(약물) 2) 질식(목매,가스) 3) 운수사고 4) 추락(건물, 강 등) 5) 홍기 6) 화상 7) 정보없음 8) 기타			
			폭력피해 이력	언제 : 어디서 : 누구를 : 무엇으로 : 어떻게 : 왜 : 음주 : □ 무 □ 유(종류/양 :)		
	타해력	언제 : 어디서 : 누구를 : 무엇으로 : 어떻게 : 왜 : 음주 : □ 무 □ 유(종류/양 :)		변화단계 (RCQ)	□ 숙고전 □ 숙고 □ 준비 □ 실행 □ 유지 □ 재발	
병식수준 (HAIS)			□ 병식부정 □ 병식부분형성군 □ 병식형성			
평가	□ 중독 : □ 정신 : □ 우울 : □ SBQ-R : □ CIWA □ 기타 :	MSE				
발 달 력	영유아기 (0~3세)	1) 임신 □ planned □ unplanned □ 기타 2) 출생시상태 □ 자연분만(순/난산) □ 재왕절개 □ 기타 3) 발육상태 □ 정상발달 □ 발육이상 4) 주양육자 □ 부 □ 모 □ (외)조부모 □ 기타				
	아동기 (3~11세)	1) 훈육방식 □ 지지적 □ 엄격함 □ 무관심 2) 학습태도 □ 근면 □ 보통 □ 열등 □ 기타 3) 대인관계 □ 주도적 □ 적응적 □ 회피적 □ 기타 4) 기타				
	청소년기 (11~19세)	1) 학습태도 □ 근면 □ 보통 □ 열등 □ 기타 2) 대인관계 □ 주도적 □ 적응적 □ 회피적 □ 기타 3) 특이사항 □ 전학 □ 가출 □ 음주 □ 이성문제 □ 써클활동 □ 흡연 □ 폭력 □ 기타				
	성인기 (19세 이상)	1) 대인관계 □ 주도적 □ 적응적 □ 회피적 □ 기타 2) 이성교제 □ 없음 □ 있음				
병 력	가족력					
	치료비 지원정보	□ 지원여부 □ 지원시작 및 종료(예정)일 □ 지원금액				
재 활 정 보	정신보건 서비스 이용경험					
	직업력					

상 담 결 과	욕구파악	① 일회상담 □ 중독관련 정보제공 □ 중독전문가의 방문상담 □ 중독사례관리이용 □ 외래약물치료	② 파악 □ 타기관연계 □ 치료비지원 □ 중독재활프로그램이용 □ 가족상담서비스이용	③ 등록 □ 중독으로 인한 신체질환치료 □ 단기개입서비스이용 □ 병원입원치료 □ 자조모임
	파악된 문제점	정신질환 :		
		신체질환 :		
		사회·경제적 문제 :		
	타 기관 의뢰 계획	□ 행정복지센터 □ 한결음센터 □ 노인보호전문기관 □ 성폭력피해상담소 □ 고용복지안심플러스센터 □ 도박문제예방치유센터 □ 마약퇴치운동본부	□ 정신건강복지센터 □ 아동보호전문기관 □ 청소년상담복지센터 □ 가정폭력상담소 □ 건강가정지원센터 □ 자원봉사센터 □ 기타	□ 자살예방센터 □ 경찰서 □ 치매안심센터 □ 여성의전화 □ 지역자활센터 □ 스마트쉼센터
	면담진행 기록			
	계획	장기목표 1) 2) 단기목표 1) 2)		

가. 인적정보

- ▶ 기본정보(성명, 연락처, 나이, 성별, 주소), 진단명, 학력, 종교, 결혼여부, 가족정보, 의뢰경로, 의료보장, 장애여부, 보호자정보, 가계도 등을 의미한다.
- ▶ 가족정보는 구성원의 일반적 사항(나이, 직업, 동거 여부, 경제력 수준, 정신질환 유무 등)을 사정하며, 가족구성원과 대상자의 관계 및 가족 역동을 평가한다.

- 가족구성원이 대상자의 질환 및 치료에 관한 생각
 - 대상자의 중독문제 및 질환, 치료에 대해 이해하는지
 - 대상자의 질환과 관련하여 부담감을 느끼는지
 - 대상자에 대한 감정이 어떠한지
 - 대상자의 질환이 가족 구성원에게 어떤 영향을 미치는지
- 가족 구성원이 대상자의 질환에 미치는 영향
 - 대상자의 중독문제로 인한 2차적인 문제(가족갈등, 법률, 경제 등) 발생 시 위기대처 방법

참고

32

- ▶ 주거지 파악 시 현주소지와 주민등록상의 주소가 상이할 경우 구분하며, 주거의 환경 및 비용 안정성, 위생, 안정 등을 포함하여 포괄적으로 사정한다.

사정방법	• 주거의 환경: 거주 환경 심각성 및 개선 필요 여부 • 주거비용의 안정성: 자가 소유 여부, 전세일 경우 이사에 대한 부담이나 두려움, 불안 없이 거주 가능한 상태인지, 월세라면 지불능력이 있는지 등을 사정 • 주거의 위생: 지하 또는 옥탑, 쪽방 등 주거 취약지로 위생이 불량한지, 집에 곰팡이 또는 벽이나 천장의 누수가 있는지, 해충(쥐, 벌레 등)이 있는지 사정 • 주거의 안전성: 주거 환경 및 파손으로 인한 건강의 위해 여부를 평가, 출입문의 개폐에 문제가 없는지, 잠금장치에 문제가 없는지, 타인 침입 우려가 있는지, 전기 누전 및 화재의 위험, 소음과 분진 등으로부터의 안전 여부
기록예시	• 주거지: ☒ 독립주거지(☐ 자가 ☐ 전세 ☒ 월세 ☐ 일세 또는 쪽방) ☐ 임시주거지(쉼터, 기타) ☐ 시설 거주 • 주거위생: ☐ normal ☒ poor(상세내용: 방안에 쓰레기가 쌓여져 있고 악취 남) • 주거안전: ☒ 유(상세내용: 보일러에서 큰 소음이 있음, 점검이 필요함), ☐ 무

나. 병력정보(발달력, 병력, 자살시도력, 가족력 등)

1) 발달력

- ▶ 대상자를 평가하는 데 필요한 개인력으로 발달과정 중 특히 대상자에게 중요한 영향을 미쳤던 시기의 사건과 그 당시 느낀 감정 및 대처방법, 이후 그 사건에 부여하는 의미와 동기, 영향을 미치는 요소들이 무엇인지 평가한다.
- ▶ 대상자의 병전 성격과 발병 또는 반복되는 재발 이후의 성격까지 파악한다.

사정방법	• 발달력에 대한 정보는 대상자뿐만 아니라 가족과의 면담을 통해서도 정보를 사정할 수 있음, 특히 대상자와의 의사소통 어려움이 있을 때 가족이 제공하는 정보는 중요하고, 면담을 통해 가족 간의 역동도 파악할 수 있음 • 면담 내용을 각색하여 기록하지 말고 명확히 주요 상황을 기록하는 것이 중요
------	---

참고

발달단계에 따른 사정방법 및 기록(각색사례 예시)

구 분		상세내용
임신기간	사정방법	• 부모가 계획된 임신이었는지 • 임신기 중 모의 감정 상태나 영양상태, 생활환경 • 임신 전 임신기, 출산 중 신체적·정신적 문제 또는 질환 유무 • 임신 중 모의 알코올이나 약물 문제 사정
	기록예시	1. 체크형식의 기록 • planned baby(+, -)/☒ planned 또는 ☐ unplanned • 자연분만(순산, 난산) 또는 ☒ 자연분만/☐ 제왕절개 2. 서술형 기술 • planned baby로 정상만기 분만이었음, 재태기간 중이나 분만 시 모의 신체 및 정신적 문제없었고 대상자 신체 손상과 기형은 관찰되지 않음
영유아기 (0~3세)	사정방법	• 대상자의 수유 및 수면상태, 배변훈련 • 초기 운동 및 언어발달 등 신체적 발달적 특이사항 • 주 양육자와의 애착상태(분리불안, 모성 박탈) 평가
	기록예시	1. 체크형식의 기록 • 정상발달/발육이상 • 주 양육자(조부모, 주로 조모가 care) 2. 서술형 기술 • 정상적인 성장과 발달을 보였으며 맞벌이 부모 대신 조부모가 주 양육자가 되어 키웠기 때문에 부모와의 정상적인 애착관계를 형성할 수 없었음
아동기 (3~11세)	사정방법	• 양육자의 훈육상태 • 놀이 활동 및 또래 관계, 학교에서의 대인관계 • 인지적·신체적·정서적 발달 정도 사정
	기록예시	1. 체크형식의 기록 • 양육자 훈육방식: ☒ 지지적/☐ 엄격한/☐ 무관심 • 학습태도 및 학교생활: ☐ 근면/☐ 보통/☒ 열등 • 대인관계: ☐ 주도적/☐ 적응적/☒ 회피적 • 기타: 큰 키와 통통한 체형, 4학년 초에 초경 시작 2. 서술형 기술 • 조부모가 초등학교 졸업까지 같이 생활, 맞벌이로 부모는 항상 바빴고 대화를 하는 일이 거의 없었음, 대상자가 잘못했을 때 부가 많이 화를 냈는데 그때 생각을 하면 무서운 생각이 든다고 함, 학교 다닐 때 공부에 흥미가 없었고 조리 있게 말을 못해 친구관계에서 스트레스가 많았고 혼자 집에서 음악을 듣거나 멍하게 앉아 있는 것이 좋았다고 함

구 분		상세내용
청소년기 (11~19세)	사정방법	• 자아정체성, 사회적 관계 형성 사정 • 가족관계 및 문제 여부 파악 • 학업달성정도, 진로희망 등을 사정 • 또래관계, 사춘기 시작시기, 이성에 대한 태도 등을 파악 • 중독관련 문제를 포함한 기타 문제 행동 등을 사정
	기록예시	1. 체크형식의 기록 • 학습태도 및 학교생활: ☐ 근면/☐ 보통/☒ 열등 • 대인관계: ☐ 주도적/☐ 적응적/☒ 회피적 2. 서술형 기술 • 학업성적은 하위권이며 무관심하고 특별한 이유 없이 학교를 결석하는 일이 잦았음, 또한 학교 내에서 친밀한 친구가 없었음 • 가족들은 따돌림을 당하는 것을 의심 외부 활동 없으며 집에 있을 때 항상 자신의 방에 들어가 문을 닫고 컴퓨터로 채팅을 하며 지냈음
성인기 (20~64세)	사정방법	• 직업력 및 사회생활(직장)에서의 대인관계 • 이성과의 관계 및 교재경험, 부부관계, sexual history • 학력, 종교 · 사회활동, 경제활동 등을 사정 • 중독문제로 인한 법적문제 • 남자의 경우 군 적응, 여자의 경우 임신으로 인한 변화 등을 사정
	기록예시	1. 체크형식의 기록 • 직업력: ☒ 있음(3개월)/☐ 없음 • 대인관계: ☐ 주도적/☐ 적응적/☒ 회피적 • 이성교제: ☐ 있음/☒ 없음 2. 서술형 기술 • 고등학교 졸업 이후 미취업, 집에서 있는 시간이 많아지면서 가족이 자신을 무시한다는 생각이 들었고 방 안에서 컴퓨터 게임이나 채팅을 하며 밖으로 나오지 않음, 23세경 부모님의 지인 소개로 공장에 취업을 하게 되었으나 3개월 만에 일을 그만 둬, 대상자는 많은 사람들과 일을 하는 게 힘들었다고 하며 자신을 이상하게 보는 직장동료들이 싫었다고 함
노년기 (65세 이상)	사정방법	• 신체건강, 인지기능 상태 사정 • 사별경험, 노년기에 따른 심리적 변화, 죽음에 대한 태도 등을 사정

2) 병력

- ▶ 대상자의 과거 중독 관련 병력, 주요 중독문제 및 양상을 사정한다.
 - 중독문제 최초 사용시기 및 습관적 사용시기, 첫 문제발생 등
 - 중독문제의 사용(섭취)량, 시간 등
 - 지난 한 달간 사용 평균 빈도 및 양을 주 단위, 일 단위 등으로 파악
 - 사용 장소, 시간, 사람, 식사 유무, blackout 여부 등
 - 신체·정신질환
 - 사고, 상해 등 일반 건강 악화
 - 신체·주거의 위생문제
 - 경제적 문제(술/마약(약물)/담배/인터넷/도박 값, 신용카드 빚, 벌금, 합의금 등)
 - 직업·학업 문제
 - 가정불화 및 갈등, 가족의 가출, 가족에게 폭언, 폭행, 별거, 이혼 등의 문제
 - 대인관계 상의 문제
 - 법적 문제(폭력사건 연루, 마약범죄, 음주운전 등)
- ▶ 재발한 대상자의 경우 관해기 때의 대상자의 사회기능에 초점을 둔다.
- ▶ 재발당시 특별한 사건이나 에피소드가 무엇인지를 파악한다.(재발에 대한 유발요인, 반복요인을 분석하여 재발예방 전략에 반영, 입원력 평가 시 입원기간, 입원병원, 입원방법, 입원당시 대상자의 반응, 치료 순응도를 구체적으로 평가)
- ▶ 대상자의 중독문제에 영향을 미치는 생활환경 및 성격, 인지기능 등 부분에서의 역기능 정도를 사정한다.

사정방법	• 발병 시기는 입원치료를 받기 시작한 시점이 아니라 증상이 나타나기 시작한 시점을 의미 • 대상자의 첫 중독 시기부터 현재 시점까지의 중독문제 변화와 문제행동, 환경적 요인, 증상이 생활에 미치는 영향 등을 전반적으로 사정하는 단계, 첫 경험으로부터 중독문제가 나타나기 시작한 시점부터 시간차대로 질문하여 사정
기록예시	• 발병 시기: 만 35세(0000년) • 35세(0000년) 실직 후 방안에서 자주 불을 꺼놓고 멍하니 무기력하게 있는 모습이 자주 관찰되다가 혼자 방에서 술을 먹기 시작함, 어느날부터인지 방에 술병이 하루 4병 이상 나오기 시작했고, 가족들이 음주량 조절을 이야기하자 베란다에 숨겨놓고 먹거나, 수퍼에서 소주를 산 뒤 안주 없이 모두 비우고 집에 들어오기 시작함, 이후에는 술을 먹지 못하게 하면 심하게 손을 떨고, 횡설수설하는 모습보여 위기감을 느낀 누나의 권유를 받아 외래 치료를 시작 • 36세(0000년) 외래를 이용하며 단주교육, 약물치료 하였음에도 음주양상에 큰 변화가 없고 입이 마르거나 변비가 생기는 등 부작용이 발생하자 스스로 약물을 중단, 이후에는 절주를 권하는 가족들에게 공격적인 모습으로 큰소리로 대들거나 밀치는 모습이 보이기도 하였으며, 술을 마시지 않았는데도 취한 것처럼 얼굴이 빨갛고 술냄새가 나며, 혼잣말 하고 횡설수설하는 등으로 입원치료 • 40세(0000년) 집에서 care가 불가능할 정도로 금단증상이 심해지고, 음주를 말리는 모에게 물건을 던지는 등 폭력적인 행동을 보여 5개월간 입원 치료를 받게 됨, 입원 3개월 후 증상이 호전, 본인의 요청으로 퇴원을 하였지만, 퇴원 일주일 후부터 약물관리가 잘되지 않고, 몰래 술을 마시기 시작하며 자의로 외래 중단

3) 자살시도력

- ▶ 대상자의 자살관련 과거력 및 현재 자살의도 등을 사정한다.
- ▶ 과거 자살시도 유무, 횟수 및 방법, 시도 후 대처방법 파악한다.
- ▶ 현재 자살위험성 평가를 실시(자살사고·계획, 자살위험성, 지지체계 등) 한다.

기록예시	<자살과거력: 청소년기부터 반복으로 자살시도> 1st • 시도시기 및 사유: 16세, 중학교 시절 친구들과의 갈등관계로 인하여 자살시도 실시 • 시도방법: 커터칼로 wrist cutting • 시도 이후 대처: 가족들이 알아 걱정하였으나 특별한 치료(-) 2nd • 시도시기 및 사유: 18세, 학교생활이 싫고 어머니와의 갈등, 반항심 • 시도방법: 반복적으로 커터칼로 wrist cutting • 시도 이후 대처: 동생이 이후 알고 가족들에게 알려 치료 권유하였으나 거부 3rd • 시도시기 및 사유: 19세, 관계갈등, 우울증문제로 인하여 <죽고 싶다> 호소 • 시도방법: 욕실에서 음주 후 hanging 시도하였으나 줄이 끊어짐 <현재 자살위험성 평가> 현재 나이 30세 • 자살사고(+): 우울감, 대인관계 문제 호소 '죽어버리면 모든 게 해결될 것이다' • 자살계획(-): 과거 충동적 자살시도 현재는 뚜렷한 계획 확인되지 않음 • 자살위험성(-): 음주 이후 충동적으로 실시, 정신과적 문제 • 지지체계: 여동생이 지지적인 편, 성격적 문제로 인하여 지지체계 미약한 편
------	--

4) 가족력

- ▶ 대상자의 가족 중 중독문제, 정신질환으로 인해 진단이나 치료를 받았거나, 자살로 사망한 경우 등 가족의 병력을 사정한다.

기록예시	• 큰고모(만61세): 23세에 발병하여 지속적으로 약물치료 중 3년 전 퇴원하여 현재 혼자 생활 중, 000정신건강복지센터 등록회원, 환청과 관계망상 등 지속적인 증상 있음 • 부(만58세): 23세 의가사 제대하며 집에서 매일 혼자 소주 1병 이상을 마시며 조모와 갈등 빈번했다고 함, 음주문제로 계속 가족갈등 보이다가 40세경 배우자(pt 모) 권유로 수원의 00병원에서 첫 외래치료 시작, 입원경험 없으며, 가족 갈등 심화될 시 간헐적 외래방문, 약물치료+
------	--

다. 치료정보(진단력, 치료력, 치료약물, 신체질환, 입원력, 중독문제 등)

1) 진단력

- ▶ 대상자의 진단(ICD-10기준)을 받은 내용을 사정한다.
- ▶ 이중진단이 있는 경우 주진단(1순위 진단)이 중독문제일 경우 중독사례관리 대상에 해당한다.

2) 치료력(진료내용)

- ▶ 대상자의 치료받은 이력 및 치료비지원 여부를 사정, 대상자의 정신, 신체적인 질환이 현저하나 치료를 하지 않은 경우는 병력정보에서 파악한다.
 - 치료비지원여부, 지원기관(보건소, 복지관, 보험회사 등), 전체 치료비 중 치료비지원받는 비율(금액), 치료비 지원시작일-종료일, 치료비 지원내용(전액지원 또는 내과 비급여 한정, 정신과 검사비 등)
- ▶ 정신건강의학과 위주로 사정하나 대상자의 신체적 질환이 중독문제와 밀접한 관계를 맺고 있거나, 사례관리 과정에서 대상자에 대한 이해 및 지원이 필요한 경우 타과의 진료내용도 파악한다.
 - 정신건강의학과, 내과, 외과, 치과, 신경과, 안과, 피부과, 비뇨기과, 산부인과, 기타 등

사정방법	• 접수상담(Intake) 시 파악하는 내용과 기록에 차이를 둠 • 접수상담: 나이/연도/발현증상/치료방법 및 기간/치료결과/기타 • 초기사정: 진료사유/진료내용/외래결과 등 대상자의 치료에 대한 이력사항 기록
초기상담(Intake) 기록예시	• 25세(0000년): 고등학교 졸업 이후 친구들과 음주 시작함, 잦은 blackout로 소지품을 잃어버리거나, 귀가하지 못하고 길거리 벤치나 비상구 계단에서 잠이 드는 일이 발생, 술을 많이 마시고 나면 1-2일 가량은 음식을 소화하지 못하는 문제로 내과 치료 받기도 함, 당시 특별한 진단은 없이 염증소견으로 치료했다고 함 • 28세(0000년): 반복되는 음주와 음주 후 신체적인 문제로 인해 사회생활 하지 못하고 지냄, 얼굴이 노랗고 잦은 피곤감 호소, 건강검진을 통한 결과에서 간수치 높게 나왔으나 치료하지는 않음, 신체적으로 활력 없고, 사회생활 어려움 등의 문제로 가족이 정신과 병원입원치료 시작, 이후 10년간 3차례 입·퇴원 반복 • 38세(0000년): 2018년 7월 1일 퇴원 후 중독자정신재활시설에 입소, 단주모임에 참여하며 사례관리자의 도움 받아 정기적으로 외래 방문하여 치료
초기사정 (Initial Assessment, 사정평가) 기록예시	• 외래사유: (정신과) 정기적인 외래 치료 • 진료내용: 한 달간의 증상변화 및 단주 관련하여 면담, 약물 미복용 일자 파악(-), 증상의 변화 없음, 약물부작용(-) • 외래결과: 1개월 약물 처방, 약물변경 없음, 1개월 후 F/U예정

3) 치료약물

- ▶ 대상자가 현재 복용하고 있는 약물의 정보, 부작용 유무를 사정한다.
- ▶ 대상자 복용 중인 약물의 주치의, 외래기관명, 약물관리방법(본인, 가족 등), 순응도(처방대로 복용/임의 조정/ 거의 복용하지 않음 등), 부작용 경험여부 및 부작용 종류, 복용횟수 및 양(mg)을 파악한다.
- ▶ 대상자의 치료를 위해 복용하는 약물명, 정보 등 세부사항도 숙지한다.

사정방법	• 약물 종류 체크 시 약물을 직접 확인하여 정보 수집, 이후에는 대상자에게 약물 변경이 있을 시 약물정보가 적혀있는 약 봉투를 보관하게 하거나 처방전을 받아올 수 있도록 권유 • 약물명(성분명)은 약자가 아닌 전체 약물명(성분명)을 수집하고 기록 • 약 용량은 정확한 양을 기록하고 일일 총량을 기록 • 약물 복용에 있어 부작용을 기록하는 것은 매우 중요하며 대상자에게 심각한 부작용을 일으킬 수 있는 약물은 미리 사정하여 기록
기록예시	• 아캄프로세이트정 333mg, 날트렉손정 25mg 등 • 하루 두 번 투약, 현재 자가 투약 유지 중

4) 신체질환

- ▶ 대상자의 신체질환 유무와 복용약물에 대한 사정, 대상자의 신체적 질환이 중독문제와 밀접한 관련을 맺고 있거나, 중독문제로 인해 발생한 질환인 경우 사정한다.
 - 고혈압, 간염, 당뇨, 결핵, 에이즈, 비만, 암, 뇌혈관질환, 갑상선, 간경화, 골다공증, 신부전, 기타 등
 - 중독자의 단주여부, 금단증상 등을 파악할 수 있는 혈압, 간수치, 혈중알코올농도 등

기록예시	• 키/몸무게: 160cm/65kg • 혈압: 140/80 • 간수치: 정상범위 • 신체질환: ☒ 유(고혈압), ☐ 무 - 치료병원: 000병원 - 복용약물: 아캄프로세이트정 333mg, 아모디핀 2.5mg - 주의사항 및 가족력: 없음
------	---

5) 입원력

- ▶ 대상자의 정신병력으로 인한 첫 입원부터 최근 입원까지의 정보를 사정한다.
 - 입원일, 퇴원일, 입원기관(병원명), 입원유형(자의입원, 동의입원, 보호입원, 행정입원, 응급입원), 진단명, 치료결과 등

사정방법	• 입원기간, 입원병원, 입원방법(유형), 입원 당시 대상자 반응 등을 사정 • 진단명, 치료 순응도, 치료결과 사정 • 대상자 또는 가족이 과거 입원 정보를 정확하게 기억하지 않을 시 의뢰한 정신의료기관이나 지역사회기관에 정보를 참고하거나 없으면 상담 내용을 추정하여 기록
기록예시	• 00정신병원/알코올 사용 장애/0000년 00월 00일~00월 00일(3개월)/발병 • 00정신병원/알코올 사용 장애/0000년 00월 00일~00월 00일(1개월)/재발, 주취소동으로 가족에 의해 입원

참고

입원유형

자의입원	정신건강복지법(제41조)
입원대상자	1. 정신질환자 2. 정신건강상 문제가 있는 사람
입원신청 등 주체	환자 본인의 입원 신청
입원 절차 및 입원 기간	1. (자의입원 개시) 환자 본인의 퇴원요청시까지 입원유지 가능 2. (2개월 이내) 퇴원의사 확인: 입원할 날부터 2개월 마다 - 퇴원의사 있음: 지체 없이 퇴원 - 퇴원의사 없고, 계속 입원 원함: 입원 유지 ※ 최초의 확인은 입원한 날부터 2개월 이내, 그 다음 확인은 '퇴원의사 마지막 확인일'로부터 2개월 이내에 처리 3. (퇴원) 입원 기간 중 환자가 퇴원을 신청하는 경우 지체없이 퇴원
동의입원	정신건강복지법(제42조)
입원대상자	정신질환자
입원신청 등 주체	환자 본인의 입원 신청 + 보호의무자 1인 동의
입원 절차 및 입원 기간	1. (동의입원 개시) 환자 본인의 퇴원요청시까지 입원유지 가능 2. (2개월 이내) 퇴원의사 확인: 입원할 날부터 2개월 마다 - 퇴원의사 있음: 지체 없이 퇴원 - 퇴원의사 없고, 계속 입원 원함: 입원 유지 ※ 최초의 확인은 입원한 날부터 2개월 이내, 그 다음 확인은 '퇴원의사 마지막 확인일'로부터 2개월 이내에 처리 3. (퇴원) 입원 기간 중 환자가 퇴원을 신청하는 경우 지체없이 퇴원 ※ 이때, 보호의무자가 환자의 퇴원에 동의하지 않고, 전문의 진단 결과 치료와 보호의 필요성이 있는 경우 72시간(주말 및 공휴일 포함) 동안 퇴원 제한 가능, 퇴원 제한 기간 동안 보호입원이나 행정입원으로 전환할 수 있음
보호입원	정신건강복지법(제43조)
입원대상자	아래 1, 2, 3의 입원요건을 모두 충족하여야 함 1. 정신질환자 2. 입원치료 또는 요양을 받을 만한 정도 또는 성질의 정신질환 3. 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험(보건복지부령으로 정함)
입원신청 등 주체	보호의무자 2인 이상 신청(단, 보호의무자가 1인만 있는 경우 1인으로 함) ※ 법 제39조에 따라 후견인을 우선으로 함, '보호의무자가 될 수 없는 사람'은 본법 제39조에 규정
입원 절차 및 입원 기간	1. (보호입원 개시) 전문의 대면진단 후 2주의 범위에서 기간을 정하여 입원 가능 2. (2주 이내) 추가진단 전문의의 입원 필요성 진단: 입원이 필요하다는 2인 이상 전문의의 일치된 소견이 있는 경우에 한하여 2주의 범위에서 정한 기간 이상(3개월 이내) 입원 유지 가능 3. (1개월 이내) 입원적합성심사위원회의 심사: 입원 적합('입원등 유지') 통지가 있어야만 입원 유지 가능, '퇴원 등' 통보 시 지체없이 퇴원

입원 절차 및 입원 기간	4. (3개월 이내) 입원 기간 만료 시 즉시 퇴원, 계속 입원이 필요한 경우 정신건강 심사위원회에 연장심사 청구 5. (퇴원) 입원 기간 중 환자 또는 보호의무자가 퇴원신청 시 지체없이 퇴원: 다만, 보호입원 요건(입원 필요성 및 자·타해위험성) 지속 시 퇴원 거부 가능
입원기간 연장 심사	1. 청구요건: '입원기간을 연장하여 치료가 필요하다'는 2인 이상 전문의의 일치된 소견 + 보호의무자 2인 이상 동의 2. 청구기간: 입원기간 만료일 전 2개월이 되는 날부터 만료일 전 1개월이 되는 날까지 ※ 연장심사에 따른 입원기간: (최초 보호입원) 3개월 이내 -> (1차 연장 심사) 3개월 이내 -> (이후 연장 심사) 6개월 주기
행정입원	정신건강복지법(제44조, 제62조)
입원대상자	정신질환으로 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있다고 의심되는 자
입원신청 등 주체	지자체장의 행정입원 의뢰 ※ 진단을 위한 행정입원(2주 이내) 및 치료를 위한 행정입원(3개월 이내)
입원 절차 및 입원 기간	- 행정입원 전 - 1. 전문의 또는 정신건강요원이 지자체장에게 진단 및 보호 신청: 경찰관이 전문의 또는 정신건강전문요원에게 '진단 및 보호 신청' 요청 가능 2. 지자체장이 전문의에게 진단 의뢰 3. 전문의가 해당 대상자를 대면 진단 후 지자체장에게 결과 통지 4. 지자체장이 지정정신의료기관에 진단을 위한(2주 이내) 행정입원 의뢰: 지자체장은 보호의무자의 유무나 환자의 입원에 대한 보호의무자의 의사와 관계없이 행정입원 의뢰 가능 ※ 전문의가 진단 및 보호신청을 하는 경우 2.의 절차 없이 1.의 '진단 및 보호 신청서'와 3.의 '진단 결과서'를 한번에 제출할 수 있음 - 행정입원 - 1. (행정입원 개시) 지정정신의료기관에 2주의 범위에서 기간을 정하여 입원 가능 2. (2주 이내) 추가진단 전문의의 입원 필요성 진단 -> 입원 필요성에 대한 전문의 2인 소견의 일치 여부 지자체장에게 통지 -> 입원이 필요하다는 일치된 소견을 통지받은 지자체장은 치료를 위한 행정입원(3개월 이내) 의뢰 -> 치료를 위한 행정입원 ※ 치료를 위한 행정입원 기간: 진단을 위한 행정입원일로부터 3개월 이내 3. (1개월 이내) 입원적합성심사위원회의 심사: 입원 적합('입원등 유지') 통지가 있어야만 입원 유지 가능, '퇴원등' 통보 시 지체없이 퇴원 4. (3개월 이내) 입원 기간 만료 시 즉시 퇴원, 계속 입원이 필요한 경우 정신건강 심사위원회에 연장심사 및 승인 5. (퇴원) 지자체장의 입원 해제 통지 또는 입원 기간 만료 등의 경우: 입원 기간 중 환자 또는 보호의무자가 퇴원 신청 시 퇴원 등 심사청구 가능
입원기간 연장 심사	1. 청구요건: 2인 이상 전문의의 진단 2. 청구기간: 입원기간 만료 전 ※ 연장심사에 따른 입원기간: (최초 행정입원) 3개월 이내 -> (1차 연장 심사) 3개월 이내 -> (이후 연장 심사) 6개월 주기

응급입원	정신건강복지법(제50조)
입원대상자	정신질환자로 추정되는 사람으로서 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 큰 사람
입원신청 등 주체	입원대상자를 발견한 사람이 의사*와 경찰관의 동의를 받아 의뢰 (* 정신건강의학과전문의일 필요 없음)
입원 절차 및 입원 기간	- 응급입원 전 - 1. 상황이 매우 급박하여 다른 입원을 시킬 시간적 여유가 없을 때 누구든지 발견 한 사람이 의사와 경찰관의 동의를 받아 정신의료기관에 응급입원 의뢰 2. 경찰관 또는 구급대원이 입원대상자를 정신의료기관에 호송 - 응급입원 - 1. (응급입원 개시) 3일 이내(공휴일 제외) 입원 가능 2. (공휴일 제외 3일 이내) 지체 없이 전문의 진단 - 계속 입원할 필요 없을 시 즉시 퇴원 - 계속입원 필요시 입원 유형 전환(모든 입원유형 중 하나로 전환 가능) ※ 기한 내에 전환하지 못한 경우 입원 기간 만료로 퇴원

(국립정신건강센터, 『2025 정신건강복지법에 따른 입·퇴원절차 안내』, 2025)

6) 중독문제

- ▶ 대상자의 중독문제의 유형과 사용동기, 사용형태 등을 사정한다.
- ▶ 중독 물질 또는 행위를 중단한 경험여부를 파악하고 중단기간과 회복을 위한 대상자 및 가족의 노력 등을 사정한다.

참고 개발경고 신호

행동의 변화	• 뚜렷한 이유 없이 다른 사람들과 논쟁하거나 싸우는 횟수 증가 • 처방된 약을 거르거나 중단 • 중독문제 모임, 상담, 교육에 참석하지 않음 • 사고와 친목을 위한 술 모임에 가서 음료를 마심 • 스트레스 증상(평소보다 더 많은 흡연, 과식 등)이 나타남 • 거짓말이 늘어남
생각과 태도의 변화	• 단주/단약/단도박에 관해 별로 경계하지 않거나 조심하지 않음 • 무슨 일이 일어날지에 대해 별 관심 없음 • 삶에 대해서 미래에 대해서 몹시 비관적임 • 혼자 힘으로 단주/단약/단도박 회복할 수 있다고 자신감을 느끼고 믿음(모임 불참, 투약 중지) • 몇 달 동안 단주/단약/단도박 한두 잔 마셔도 된다고 생각 • 자신의 중독문제는 이제 치료되었다고 생각
기분 혹은 감정의 변화	• 갑자기 침울, 우울, 불안해지거나 함 • 자신이나 다른 사람에 대해 강한 분노를 느낌 • 지루하고 따분하다는 느낌 증가 • 갑자기 행복감에 젖기도 함

라. 재활정보(지역사회서비스 이용경험, 직업력 등)

1) 지역사회서비스 이용경험

- ▶ 대상자의 보건·복지 등 지역사회 서비스 이용 경험에 대해 사정한다.

기록예시	(00중독자재활센터) • 이용계기: 병원에서 퇴원 후 의사의 권유에 따라 집으로 복귀하기 전에 증상과 약물관리에 대해 훈련받기위해 이용 • 이용프로그램: 정신건강교육 및 일상생활훈련 받음, 프로그램 이용에 어려움 없었으며 독립생활기술에 필요한 기술을 습득할 수 있었다고 함 • 이용기간: 총4개월 • 퇴소사유: 이용기간 종료, 집으로 복귀 (00복지관) • 모의 요양보호사를 통해 알게되어 18년부터 현재까지(약 5년) 주1회 도시락 배달서비스 이용 중, 0000년부터는 낮시간에 복지관 문화센터 간헐적 이용한다고 함
------	--

2) 직업력

- ▶ 대상자의 과거 직업 및 현재 직업 상태를 사정한다.
- ▶ 고용형태(정규직, 임시직, 기타), 취업형태(임시취업, 지지취업, 독립취업), 직업군(농업, 어업, 서비스업 등), 취업계기, 퇴사사유, 일일근무시간, 업무내용 등이 해당된다.
- ▶ 중독·정신건강문제와 관련하여 직장에서 대장자의 치료여부를 알고 있는지, 직장 스트레스가 대상자의 중독·정신건강문제에 영향을 미치는지 등을 파악한다.

기록예시	(예시1) • 취업계기: 여동생의 소개로 동네 편의점에서 아르바이트 시작 • 근무시간: 6시간(9:00~15:00) • 업무: 판매, 청소, 물건 정리 등 • 근무환경 및 스트레스: 가끔 무례한 손님들 때문에 스트레스를 받게 되어 예민해지거나, 약물 부작용(손떨림)을 손님이나 사장님이 알게 될까봐 불안해 함 (예시2) • 취업계기: 보호자가 운영하고 있는 회사에 정규직으로 취업 • 취업기간: 총 3년 • 근무시간: 8시간(9:00~18:00) • 업무: 서류정리, 복사 • 퇴사사유: 증상악화로 인해 입원하여 퇴사
------	--

마. 정신건강상태평가(MSE)

- ▶ 대상자와의 상담을 통해 정서, 사고내용, 지각기능, 인지기능, 치료를 위한 요구와 동기 등을 종합적으로 관찰하는 것으로, 시간에 따라 대상자의 진전 상태를 추적하고 비교하기 위한 근거 자료가 된다.
- 일반적 외모, 태도, 정신운동행동, 기분 및 정동, 언어, 지각장애, 사고, 인지, 판단력과 병식(insight)

참고

정신상태평가 양식(예시)

정신상태평가(MSE)

일반적인 외모					
태도	☐ 장난스러운 ☐ 조심스러운	☐ 순응적 ☐ 경청	☐ 방어적 ☐ 협조적	☐ 회피적 ☐ 적대적인	☐ 무관심 ☐ 빈정대는
행동	☐ 상동증 ☐ 틱 ☐ 거부증	☐ 매너리즘 ☐ 지체 ☐ 자동증	☐ 과활동 ☐ 활동저조 ☐ 보속증	☐ 긴장증 ☐ 강박행위 ☐ 동작모방	☐ 안절부절못함 ☐ 특이사항없음
언어	의사소통태도	☐ 자발적 ☐ 비자발적			
	언어생산성	☐ 정상 ☐ 증가 ☐ 감소 ☐ 압박	☐ 언어빈곤		
	속도	☐ 정상 ☐ 빠름	☐ 느림		
	음의 고저	☐ 정상 ☐ 높음	☐ 낮음		
	톤	☐ 정상 ☐ 속삭임 ☐ 시끄러운 ☐ 단조로움	☐ 중얼거림		
	언어장애	☐ 말더듬 ☐ 속화증 ☐ 실어증 ☐ 구음장애	☐ 반향언어증		
기분	기분(mood)	☐ 걱정하는 ☐ 화 ☐ 슬픔	☐ 우울한 ☐ 다행감 ☐ 긴장한	☐ 의기양양 ☐ 황홀감 ☐ 안정	☐ 절망적인 ☐ 불쾌감
	정서(affect)	☐ 부적절한 ☐ 적절한	☐ 둔마, 무딘 ☐ 불안정 ☐ 두려움	☐ 무미건조 ☐ 제한적인 ☐ 초조	
지각	☐ 환청	☐ 환시	☐ 환후	☐ 환촉	☐ 환미
사고	사고형태 및 과정	☐ 부적절한 ☐ 적절한	☐ 논리적 ☐ 연상이완 ☐ 내용의 일관성 ☐ 사고차단 ☐ 우회적인	☐ 비논리적 ☐ 사고비약 ☐ 지리멸렬 ☐ 사고지연 ☐ 사고의 이탈	
			☐ 자폐적 ☐ 공포증 ☐ 과대	☐ 양가적 ☐ 피해 ☐ 애정, 색정	☐ 마술적 ☐ 관계사고 ☐ 특이사항없음
	사고내용	☐ 망상	☐ 피해망상 ☐ 과대망상	☐ 관계망상 ☐ 신체망상	
		☐ 자타해사고	☐ 유	☐ 무	
		☐ 기타			
인지	지남력	시간	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
		장소	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
		사람	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
	기억력	과거기억	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
		최근기억	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
		즉각저장 및 회상	☐ 정상 ☐ 이상(손상)		
	주의집중	☐ 정상 ☐ 이상(손상)			
추상적인사고	☐ 정상 ☐ 이상(손상)				
판단력	☐ 정상 ☐ 이상(손상)				

병식	I. 질병의 전적인 부정 II. 병들었으나 도움이 필요한 상태라는 인식이 조금 있으며, 동시에 그렇지 않다고 생각(부정) III. 병들었음을 인정하나 그 원인이 기질적 요인이나 외적 요인 혹은 타인에게 있다고 봄 IV. 병들었으나 그 원인이 환자 자신 속에 있는 무엇인가 알 수 없는 것 때문이라고 여김 V. 지적통찰: 자기가 병들었음을 인정하고 증상과 적응실패가 자신의 비합리적인 정서와 심리적 장애 때문임을 알지만 그러나 이해나 지식이 행동화되지 않음 VI. 진실된 감정적 통찰: 환자 자신과 자신의 일생에 중요한 인물들의 동기와 느낌을 잘 알고 그러한 앎이 행동으로 옮겨져서 행동에 근본적인 변화가 일어남
----	--

년 월 일
000중독관리통합지원센터

평가일자		접수자	
------	--	-----	--

1) 일반적인 외모(General Appearance)

- ▶ 자세, 몸가짐, 의복, 청결상태 등에서 관찰되는 대상자의 외양, 전반적 인상을 사정한다.

사정방법	• 관찰사항을 기록 - 대상자의 외양에 대한 전반적인 인상 외에도 대상자가 병에 들어 보이는지 실제의 나이에 맞게 보이는지 더 어리게 보이는지 불안해 보이는지에 대한 기술도 포함 • 자세는 바르고(X)/어깨를 구부리고 앉아 있고(O) • 불안한 모습을 보였고(X)/손과 다리를 지속해서 떨고 있고(O)
기록예시	• 165cm 정도의 키에 보통 체격이나 마르고 긴 얼굴형으로 인해 전체적으로 말라 보이는 인상, 안경착용, 단발에 파마를 했으며 가운데 가르마를 하고 있음, 새치 머리카락 많고 잠 오는 듯 반쯤 감긴 눈으로 피로해보임, 맨발에 운동화 신고 티셔츠가 들려 배가 살짝 보이며 바지 사이즈가 맞지 않은 듯 살이 빠져나옴

2) 태도(Attitude)

- ▶ 사례관리자에 대한 대상자의 태도가 협조적인 태도인지, 경청하는지, 적대적인지, 방어적인지 등 전반적인 태도와 반응을 사정한다.

사정방법	• 검사를 위한 요구에 협조적인지, 말투나 행동거지에서 달라진 점이 없는지를 파악
기록예시	• 체크형식의 기록 ☐ 협조적 ☐ 순응적 ☐ 방어적 ☐ 회피적 ☐ 경청 ☐ 조심스러운 ☐ 무관심 ☐ 적대적인 ☐ 장난스러운 ☐ 빈정대는 • 서술형 기록 - 상담 시 협조적이고 순응적인 태도이고 상담자의 질문에 차분한 목소리로 대답함, 단 자신의 증상에 대해 이야기할 땐 조심스러운 모습임

3) 정신운동행동(Psychomotor Behavior)

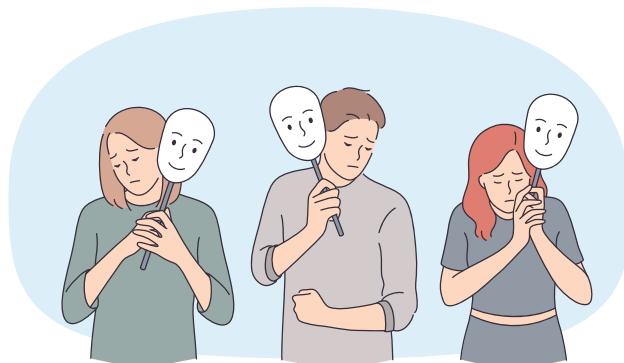
- ▶ 대상자의 운동 행동의 질적, 양적양상을 관찰한다.

사정방법	• 계속 움직이거나, 손을 가만히 두지 못하는가 등의 여러가지 신체의 움직임을 기술하고 정신운동성 지연이나 신체 움직임의 전반적인 저조, 목적 없는 행동은 없는지를 평가
기록예시	• 체크형식의 기록 ☐ 상동증 ☐ 매너리즘 ☐ 과활동 ☐ 긴장증 ☐ 거부증 ☐ 동작모방 ☐ 지체 ☐ 활동저조 ☐ 강박행위 ☐ 틱 ☐ 안절부절못함 ☐ 자동증 ☐ 보속증 ☐ 특이사항없음 • 서술형 기록 - 상담 시 양팔을 옆구리에 붙인 자세를 유지, 돌발적 상황에 반응 없고 의자에 앉고 일어나는 등 움직임이 매우 느림

4) 언어(Speech)

- ▶ 말의 속도, 리듬, 분량, 크기 등을 평가한다.

사정방법	• 속도: 빠른 혹은 느린가? • 음량: 소리치듯 큰소리로 말하는가 혹은 부드러운가? • 양: 결핍, 함구, 압박을 받아 말하는 듯한 모습인가? • 특성: 더듬는가, 발음이 분명하지 않은가, 보통 쓰지 않는 엑센트를 사용하는가?
기록예시	• 체크형식의 기록 - 의사소통 태도: ☐ 자발적 ☐ 비자발적 - 언어생산성: ☐ 정상 ☐ 증가 ☐ 감소 ☐ 언어빈곤 ☐ 압박 - 속도: ☐ 정상 ☐ 빠름 ☐ 느림 - 음의 고저: ☐ 정상 ☐ 높음 ☐ 낮음 - 톤: ☐ 정상 ☐ 시끄러운 ☐ 속삭임 ☐ 단조로움 ☐ 중얼거림 - 언어장애: ☐ 구음장애 ☐ 속화증 ☐ 실어증 ☐ 말더듬 ☐ 반향언어증 • 서술형 기록 - 말소리가 낮고 작으며 느림, 중얼거리듯 말하며 질문에 대한 대답 외에는 말이 없음



5) 기분 및 정동(Mood and Affect)

- ▶ 대상자의 행동, 표정이 표현하는 자신의 감정 상태와 일치하는가를 관찰, 또한 대상자가 진술한 내용을 바탕으로 기분의 깊이와 강도, 지속시간과 기복 사정, 정서의 부적합성, 무감동, 양가감정 등을 분석한다.

사정방법	• 관찰 시 유의 사항 - 기분과 정동 평가에 있어 우선 기분과 정동을 구별하는 것이 중요 - 대상자가 주관적으로 느끼는 기분은 무엇이고 객관적으로 관찰되는 정동이 무엇인지를 파악, 감정의 변화 관찰 • 주요 질의사항 - 기분은 어떻습니까? - 감정이 쉽게 변합니까? - 감정이 변하는 이유는 무엇이라 생각합니까?
기록예시	• 체크형식의 기록 - 기분(mood): ☐ 걱정하는 ☐ 우울한 ☐ 의기양양 ☐ 절망적인 ☐ 화 ☐ 다행감 ☐ 황홀감 ☐ 불쾌감 ☐ 슬픔 ☐ 긴장한 ☐ 안정 - 정서(affect): ☐ 둔마, 무딘 ☐ 무미건조 ☐ 불안정 ☐ 제한적인 ☐ 두려움 ☐ 초조 • 서술형 기록 - 문) 기분은 어떻습니까? 답) 가슴이 쿵덕거리면서 불안해요 - 문) 감정이 쉽게 변합니까? 답) 괜찮다가도 불안해지고 불안하다가도 갑자기 괜찮아요, 언제 또 불안해질까 걱정돼요 - 문) 감정이 변하는 이유는 무엇이라 생각합니까? 답) 잘 모르겠어요

6) 지각장애(Perceptual Disturbance)

- ▶ 환각(환청·환시·환촉·환후·환미 등)에 대해 파악, 환각의 구체적인 내용이나 대상자가 그것을 어떻게 받아들이는지에 대해 질문하며 사정한다.

사정방법	• 무슨 소리가 들리시나요? • 들리는 소리가 사람의 목소리인가요? • 무슨 냄새가 납니까? • 무엇이 보이나요?(헛것이 보이십니까?) • 무엇이 몸에 기어 다니는 느낌이 있습니까? • 무슨 맛을 느끼시나요? • 무슨 소리가 들리시나요?
기록예시	• 체크형식의 기록 ☐ 환청 ☐ 환시 ☐ 환후 ☐ 환촉 ☐ 환미 • 서술형 기록 - 문) 무슨 소리가 들리시나요? 답) 귀에서 웅웅거리고 여자가아이가 이야기해 줍니다

7) 사고(Thought)

- ▶ 사고과정, 사고내용, 망상의 종류 및 내용을 파악하여 기록한다.

사정방법	• 사고형태 및 과정: 사고전파, 사고철수, 사고이입 등 - 당신의 생각이 소리로 되어 들린 적이 있습니까? - 당신의 생각이 방송이 되어 남들이 그것을 듣는다고 느낀 일이 있습니까? - 바깥의 어떤 무엇이나 사람이 당신의 머릿속에 생각을 주입시킨다고 느낀 일이 있습니까? - 혹은 그들이 당신의 머리에서 생각을 뺏어간다고 느낀 일이 있습니까? • 사고내용 - 당신은 자신만이 특별히 주목받고 있다고 생각합니까? - 다른 사람들이 특별히 당신만을 피하고 있다고 생각합니까? - 당신의 과거 행동에 대해 어떻게 생각합니까? - 당신의 건강에 대해 어떻게 생각합니까? • 망상 ① 피해망상 - 사람들과 같이 지내는데 특별한 어려움이 있습니까? - 사람들이 당신을 적대시 하는 것 같습니까? - 누가 당신을 괴롭히거나 해치려는 사람이 있습니까? ② 과대망상 - 당신은 특별한 능력이나 재주가 있습니까? - 당신은 큰일을 이룰 것으로 보십니까? ③ 관계망상 - 사람들이 당신 이야기를 하거나 당신을 비웃는다고 여겨진 일이 있습니까? - 잡지나 TV에서 당신에 대한 언급이나 당신에게 특별히 의미 있는 것을 본 일이 있습니까? - 다른 방법으로 무슨 특별한 메시지를 받는 일이 있습니까? ④ 신체망상 - 당신의 신체 기능이 어딘가 잘못되었습니까? - 당신의 모습에 무슨 변화가 생겼습니까?
기록예시	• 체크형식의 기록 - 사고과정 및 형태 1-1 ☐ 적절한 ☐ 부적절한 1-2 ☐ 논리적 ☐ 비논리적 ☐ 연상이완 ☐ 사고비약 ☐ 내용의 일관성 ☐ 지리멸렬 ☐ 사고차단 ☐ 사고지연 ☐ 우회적인 ☐ 사고의 이탈 - 사고내용 ☐ 자폐적 ☐ 양가적 ☐ 마술적 ☐ 강박 ☐ 건강염려증 ☐ 공포증 ☐ 관계사고 ☐ 피해 ☐ 과대 ☐ 애정, 색정 ☐ 망상(☐ 피해망상, ☐ 관계망상, ☐ 과대망상, ☐ 신체망상) ☐ 자타해사고(☐ 유, ☐ 무) ☐ 기타() • 서술형 기록 - 사고 형태 및 과정: 해당사항 없음 - 사고 내용: 밤마다 허리가 아파서 죽겠어요, 병원에서 아무 이상이 없다는데 답답해요, 허리에 좋다는 약초를 먹는데 효과가 없어요 - 망상: 주변의 CCTV가 나만을 감시하고 있어요 - 자타해사고: 해당사항 없음

8) 인지(Cognition)

- ▶ 대상자의 의식상태, 섬망, 지남력, 기억력, 주의력, 추상적 사고 등 평가한다.

가) 지남력(orientation)

사정방법	• 시간, 사람, 장소와 관련된 질문을 하고 평가 • 주요 질의사항 - 오늘은 몇 년도 몇 월 며칠입니까? - 지금은 어느 계절입니까? - 당신이 사는 곳은 어디입니까? - 이곳이 어디인지 아십니까? - 이곳은 무엇을 하는 곳입니까?
기록예시	• 체크형식의 기록 ☐ 정상 ☐ 이상(손상) • 서술형 기록 - 문) 지금 몇 시입니까? 답) 2025.10.31.이예요. - 문) 여기는 어디죠? 답) 광진구 중곡동 - 문) 저는 누구입니까? 답) 00 정신재활시설의 선생님 000

나) 기억력(memory)

사정방법	• 과거 기억 - '초등학교 시절에 친구들은 어떠했습니까?'라고 물은 후 나중에 확인 • 최근기억 - 식사는 어떻습니까? - 아침식사로 무엇을 드셨습니까? • 즉각저장 및 회상 기능 - 숫자 여섯 개를 불러 주고 따라하게 함 - 사과, 책상, 동전을 말하고 따라 하게 함 - 삼천리 강산을 거꾸로 말해 보게 함
기록예시	• 체크형식의 기록 ☐ 정상 ☐ 이상(손상) • 서술형 기록 - 과거 기억: 문) 초등학교 시절에 친구들과 어땠습니까? 답) 친구들이 나를 많이 싫어했다 - 최근 기억: 문) 아침 식사로 무엇을 드셨습니까? 답) 아침에 사과를 먹었습니다 문) 따라해보세요. 5, 8, 7, 10, 15, 17 답) 5, 8, 7, 10, 15, 17

다) 주의집중(Concentration & attention)

사정방법	- 계산능력의 평가가 아니라 평가에 집중하는 능력을 파악하고자 함 - 따라서 학력 수준에 따라 5빠기로도 시행가능 100에서 7을 빼 보세요?(7 빼기를 5번 반복) '가'로 시작하는 단어 5개를 말해 보세요 2+3+7은 얼마입니까?
기록예시	- 체크형식의 기록 □ 정상 □ 이상(손상) - 서술형 기록 - 특이사항 없음(질문: 2+3+7=?/답: 12)

라) 추상적인 사고(Abstract thinking)

사정방법	속담을 설명해보라고 함으로써 개념화, 추상화 할 수 있는 능력을 검사
기록예시	- 체크형식의 기록 □ 정상 □ 이상(손상) - 서술형 기록 - 문) 소 잃고 외양간 고친다 답) 일이 일어난 후에 대비하는 거 아니에요

9) 판단력(Judgement)

- ▶ 건설적이고 적응적인 의사결정을 하는 것이고 사실을 이해할 수 있는 능력을 말한다.
- ▶ 관계로부터 결론을 도출하는 능력을 평가한다.

사정방법	- 극장에서 영화 관람 도중 연기 냄새가 날 때 무엇을 어떻게 할 것인가? - 길에서 남의 주민등록증을 발견했을 때 어떻게 합니까? - 당신이 가려는 장소를 찾지 못하고 있을 때 어떻게 합니까?
기록예시	- 체크형식의 기록 □ 정상 □ 이상(손상) - 서술형 기록 - 문) 길에서 지갑을 주우면 어떻게 합니까? 답) 경찰서에 가져다줘요/우체통에 넣어요.

10) 병식(Insight)

- ▶ 자신의 문제나 질병의 특성을 이해할 수 있는 능력을 평가한다.

• 병식구분

- ① 질병의 전적인 부정
- ② 병들었으나 도움이 필요한 상태라는 인식이 조금 있으며 동시에 그렇지 않다고 생각함
- ③ 병들었음을 인정하나 그 원인이 기질적 요인이나 외적 요인 혹은 타인에게 있다고 함
- ④ 병들었으나 그 원인이 환자 자신 속에 있는 무엇인가 알 수 없는 것 때문이라고 여김
- ⑤ 지적통찰: 자기가 병들었음을 인정하고 증상과 적응 실패가 자신의 비합리적인 정서와 심리적 장애 때문임을 알지만 이해나 지식이 행동화되지 않음
- ⑥ 진실된 감정적 통찰: 환자 자신과 자신의 일생에 중요한 인물들의 동기와 느낌을 잘 알고 그러한 앎이 행동으로 옮겨져서 행동에 근본적인 변화가 일어남

사정방법	• 당신은 정신적으로 문제가 있다고 봅니까? • 당신의 병을 어떻게 이해하고 있습니까? • 당신이 치료받아야 하는(혹은 치료를 받는) 이유를 아십니까? • 현재 상황에 대해 어떻게 생각하나요? • 다른 사람들이 자신의 상황에 대해서 어떻게 해주기를 원하나요?
기록예시	• 예시1) - 문) 당신은 정신적으로 문제가 있다고 봅니까? 답) 잘 모르겠어요, 의사 선생님은 제가 조현병에 걸렸다고 하는데 저는 잠을 못 자는 것 말고는 다른 문제가 없거든요 - 병식) 질병의 전적인 부정① • 예시2) - 문) 당신은 치료받아야 하는 이유를 아십니까? 답) 의사 선생님이 약을 먹으라고 하셔서 약을 빠지지 않고 먹고 있어요, 그런데 술을 끊는데 약을 꼭 먹어야 하는지 모르겠어요 - 병식) 병들었으나 도움이 필요한 상태라는 인식이 조금 있으며 동시에 그렇지 않다고 생각함(부정)②

바. 평가도구

- ▶ 신규 등록대상자와 기존대상자의 병력, 기능, 증상과 관련한 상태를 사정(assessment)을 위해 표준화된 도구를 사용한다. 기존 대상자 등록 했을 때 평가도구 활용하여 평가를 시행하고 그 이후에는 6개월 이내 1회 이상 실시하여야 한다.
- ▶ 정신건강사례관리시스템에 평가도구는 저작권 허용을 받은 표준화된 도구가 탑재되어 있으며 대상자에게 적절한 평가도구를 자율적으로 선택하여 활용할 수 있다.(116p 참조)

사정방법	• 사업 영역별로 평가도구를 선택 • 척도의 저작권 승인 범위에 따라 활용범위 내에서 사용 • 도구 명, 출처, 결과해석, 저작권은 '정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침'을 참고 (자료 다운로드: 국립정신건강센터 사업부 자료실) 그 외 도구의 경우 각 기관에서 사용권 및 저작권을 별도로 획득하여야 함
기록예시	• GAF 40점 • 알코올로 유발된 섬망으로 현실적인 판단력이 부족한 상태(환청이 지시하는 대로 행동하는 경우가 잦음) • 정신과적 증상(음주조절안됨, 금단증상으로 인한 환각호소)으로 인하여 사회생활이 불가

참고

평가도구 () 정신건강사례관리시스템(MHIS) 평가문항 미 탑재

중증정신질환	아동청소년	자살예방	중독관리	최대입력점수
CESD-10-D	CESD-10-D	CESD-10-D	CESD-10-D	10
CES-D	CES-D	CES-D	CES-D	60
GDS-SF(SGDS-K)	-	GDS-SF(SGDS-K)	GDS-SF(SGDS-K)	15
GDS	GDS	GDS	GDS	30
PHQ-9	PHQ-9	PHQ-9	PHQ-9	27
GAD-7	GAD-7	GAD-7	GAD-7	21
PSWQ-CK	PSWQ-CK	PSWQ-CK	PSWQ-CK	42
ISI-K	ISI-K	ISI-K	ISI-K	28
BPRS	-	BPRS	BPRS	126
PSS-10	PSS-10	PSS-10	PSS-10	40
IES-R	IES-R	IES-R	IES-R	88
C-GAS	C-GAS	C-GAS	C-GAS	100
GAF	-	GAF	GAF	100
HONOS	-	HONOS	HONOS	48
HONOS 65+	-	HONOS 65+	HONOS 65+	48
SDQ(청소년용)	SDQ(청소년용)	SDQ(청소년용)	SDQ(청소년용)	50
SDQ(보호자용)	SDQ(보호자용)	SDQ(보호자용)	SDQ(보호자용)	50
RSES	RSES	RSES	RSES	50
WHOQOL-B	WHOQOL-B	WHOQOL-B	WHOQOL-B	130
KBIS-11	KBIS-11	KBIS-11	KBIS-11	120
BPAQ	BPAQ	BPAQ	BPAQ	135
AUDIT-K	AUDIT-K	AUDIT-K	AUDIT-K	40
RCQ	-	RCQ	RCQ	-24~+24
RCQ-TV	-	RCQ-TV	RCQ-TV	-24~+24
b-KAAPi	b-KAAPi	b-KAAPi	b-KAAPi	40
KAAPi	KAAPi	KAAPi	KAAPi	68
NAST	-	NAST	NAST	24

중증정신질환	아동청소년	자살예방	중독관리	최대입력점수
HAIS	-	HAIS	HAIS	-20~+20
HSI	HSI	HSI	HSI	4
FTND	FTND	FTND	FTND	10
HSI	HSI	HSI	HSI	6
S-척도(청소년)	S-척도(청소년)	S-척도(청소년)	S-척도(청소년)	60
S-척도(성인)	-	S-척도(성인)	S-척도(성인)	60
KS-11	KS-11	KS-11	KS-11	60
KS-A	-	KS-A	KS-A	60
IGUESS	IGUESS	IGUESS	IGUESS	27
K-NODS-SA	K-NODS-SA	K-NODS-SA	K-NODS-SA	10
K-NODS-CLIP	K-NODS-CLIP	K-NODS-CLIP	K-NODS-CLIP	3
K-NODS-R	K-NODS-R	K-NODS-R	K-NODS-R	10
K-NODS	K-NODS	K-NODS	K-NODS	10
KGBS-L	-	KGBS-L	KGBS-L	30
KGBS-H	-	KGBS-H	KGBS-H	30
KG-SAS	KG-SAS	KG-SAS	KG-SAS	48
DAST-10	DAST-10	DAST-10	DAST-10	10
K6	K6	K6	K6	8
K10	K10	K10	K10	1
KPQ-16	KPQ-16	KPQ-16	KPQ-16	1단계: 16 2단계: 48
mKPQ-16	mKPQ-16	mKPQ-16	mKPQ-16	1단계: 19 2단계: 57
CAPE-15	CAPE-15	CAPE-15	CAPE-15	45
simple-CRI	simple-CRI	simple-CRI	simple-CRI	17
-	-	K-HGRC(신규)	-	120
ESI	ESI	ESI	ESI	120
CAGE	CAGE	CAGE	CAGE	4
K-ASRS	-	K-ASRS	K-ASRS	15
SBQ-R	SBQ-R	SBQ-R	SBQ-R	18

4. 개별서비스계획(ISP: Individualized Service Plan 수립)

- ▶ 개별서비스계획(Individualized Service Plan)은 등록대상자의 욕구파악을 통해 사례관리서비스 계획을 수립하기 위한 과정이며, 이 과정을 통해 사례관리 대상자의 관리구분이 정해진다.
- ▶ 통합적 정신보건체계의 사례관리 계획은 정신의료기관과 지역사회를 포괄적으로 다루면서 대상자, 가족, 사례관리자, 기타 서비스 제공자와의 네트워크를 통해 계획 수립에 폭넓게 참여하게 된다.
- ▶ 또한 전체 서비스 계획을 크게 세 영역으로 나눠 수립하고 서비스의 연속성과 지속성을 최대한 확보하려는 노력을 기울여야 한다.

• 정신의료기관과의 협업을 통한 계획 수립

- 정신의료기관은 정해진 서식을 기반으로 적극적인 퇴원계획 수립을 하고 대상자가 지역사회 정신건강 서비스 이용에 대한 욕구가 있거나 동의한 경우 이에 대한 정보를 중독관리통합지원센터와 공유
- 각 지역별 중독관리통합지원센터는 정신의료기관에 입원하고 있는 대상자의 퇴원 계획에 적극적으로 동참
- 사례관리 대상자의 재활계획 및 수행결과, 증상 및 약물복용 상태를 주치의와 정기적으로 의사소통해야 하며, 이를 통해 재발을 최대한 예방하고 성공적인 재활을 도모

• 지역사회 내에서의 계획 수립

- 개별서비스계획은 최소 6개월에 1회 이상 대상자 및 가족과 함께 욕구사정 도구를 활용하여 수립
- 사례관리자는 대상자 이용기간 중 사례회의를 통해 정기적으로 계획 및 제공서비스를 점검하고 그 결과를 바탕으로 재수립해야 함
- 재평가를 통해 사례관리 대상자의 서비스 관리구분이 변경될 수 있음

• 개별 서비스 계획 수립 시 고려사항

- 대상자의 목표와 변화에 대한 기대
- 대상자가 회복과정에서 해야 할 일과 의지 여부
- 가족이 대상자의 회복에 어떤 노력을 할 수 있는가?
- 기관의 내·외부 자원 활용 가능 여부
- 대상자에게 제공할 수 있는 복지서비스 확인

가. 개별서비스계획 과정

- ▶ 정신건강사례관리시스템에서는 정신건강 통합서비스 평가척도를 활용하여 욕구사정 및 심각도를 측정하도록 구성되어 있고 3단계 과정을 통해 개별서비스 계획을 수립할 수 있다.



1) 1단계. 욕구사정 및 평가

- ▶ 정신건강 통합서비스 평가 척도를 활용하여 각 영역별로 욕구사정을 실시하고 심각도를 평가한다.
- ▶ 각 영역별로 제시된 문항에 따라 사정하고 필요에 따라 보충 질문을 한다.

사정방법	• 일대일 면접 또는 토론의 형태로 실시될 수 있음 • 면접대상자에는 치료진, 가족 및 대상자가 모두 해당이 됨 • 대상자, 치료진, 가족이 지각하는 욕구는 서로 다를 수 있기 때문에 각각 별도의 양식에 기록되어야 함 • 제시되어 있는 각 문항에 대해 질문을 하며 필요에 따라 문항의 목적과 관련하여 보충질문을 함 • 서비스 욕구를 포괄적으로 사정하기 위해 지난 2주에서 1개월을 기준으로 현재 또는 최근 상황을 평가함 • 면접대상자의 새로운 문제가 발생 시 기간과 상관없이 최근 상황을 평가함
------	---

• 심각도 점수의 해석

- '0'점: 없음 또는 안정, 문제없음 등
- '1~4점': 점수가 높을수록 심각도가 높아 위기 및 응급개입이 필요한 상황임
(예: 1점/낮은 위험, 2점/중증도의 위험, 3점/심각한 위기, 4점/극도의 위기)
- '9점': 확인/파악되지 않음



중독 사례관리 욕구사정 영역

영역	문항	
상태평가	1	자해 및 타해 위험
	2	정신과적 증상
	3	정신약물관리
	4	스트레스 상태
	5	신체질환
	6	알코올사용문제
	7	약물사용문제
	8	인터넷사용문제
	9	도박문제
기본생활관리영역	10	개인위생관리
	11	일상생활관리
사회적기능평가	12	가족지원
	13	가족관계
	14	사회적 관계
	15	공공서비스 활용능력
사회서비스 평가	16	주거
	17	경제활동 지원
	18	취업 및 학업욕구
	19	고용 및 교육가능성
	20	벌금 및 법률적 문제

참고

중독 사례관리 욕구조사 항목

문항		내용
1	자해 및 타해 위험	- 자살위험성 평가: 죽음에 대한 모호한 생각, 자살생각, 자살계획, 과거 자살시도 경험 등을 질문하여 현재 행동화 가능성에 대해 평가 - 타해위험성 평가: 타인에게 직접적인 욕설, 폭언, 위협, 폭력 등으로 위험에 처하게 하는 행동이 있는지를 평가, 또한 직접적인 물리적 충돌 외에 물건 던지기, 밀치기, 걷어차기 등 간접적 폭력 행동이 있는지를 평가
2	정신과적 증상	대상자의 증상의 심각도를 평가하고 약물복용을 통해 증상완화 및 행동조절이 가능한지를 평가, 이때 증상이 대상자의 일상생활 및 사회적 기능에 영향을 미치는지를 사정하고 현재 상태가 모니터링 단계인지 외래방문을 통한 증상 및 약물 조절이 필요한 상태인지 입원치료 등 긴급을 요하는 상태인지를 평가하는 것이 필요
3	정신약물관리	대상자의 약물관리 상태를 전반적으로 평가하는 항목, 외래 일정 및 방문 유무, 복용약물에 대한 정보를 인지하고 있는지, 복용 시 타인의 도움을 받는지, 자가 투약이 가능하다면 선택적 투약 행위 및 임의 중단 경험에 있는지 등을 확인하고 평가
4	스트레스 상태	- 대상자의 자기보고, 행동양상 관찰, 보호자나 친지, 이웃, 유관기관 종사자 등 주변의 정보를 종합하여 평가 - 심리적 압박감을 주는 요인을 구체적으로 평가
5	신체질환	신체질환 및 신체적 장애를 평가
6	알코올사용문제	- 물질(알코올, 약물) 및 행위중독(도박, 인터넷 중독 등) 여부를 파악 - 현재 중독질환 및 중독문제가 스스로 관리가 잘되고 있는지, 집중적인 관리가 필요한 상태인지, 입원 치료가 필요한지를 확인 - 중독문제로 인해 발생한 사회적, 법적, 대인관계 및 가족 문제가 있는지를 확인하고 과거 중독문제로 신체적, 정신적 치료를 받은 적이 있는지 확인
7	약물사용문제	
8	인터넷사용문제	
9	도박문제	
10	개인위생관리	(예: 옷 입기, 세수하기, 목욕, 식사하기, 이동, 화장실 사용, 대소변 조절) - 기본적인 개인위생관리 수행 시 타인의 도움 여부 및 필요성을 평가 - 대상자의 전반적인 외모상태 등을 관찰하거나 가정방문을 통해 실제 수행과정을 평가할 수 있음
11	일상생활관리	(예: 몸단장, 집안일, 식사 준비, 빨래하기, 근거리 외출, 교통수단 이용, 물품구매, 금전관리, 전화사용, 약 챙겨먹기) 수단 및 도구를 활용할 수 있는 일상생활의 수행 정도를 평가
12	가족지원	- 법적 보호의무자의 유무를 확인 - 생계비, 외래 및 입원 치료비 등을 가족이 지원하는지 확인 - 법적 보호 의무자가 아니라고 역할을 대신할 수 인적 자원이 있는지를 확인
13	가족관계	가족과의 의사소통, 가족 구성원으로서의 역할참여 여부, 가족 간의 문제 등을 파악

문항		내용
14	사회적 관계	• 대인관계 형성 및 유지에 대해 평가 • 친하게 지내는 친구, 이웃 등이 있는지를 확인하고 이들과 건강한 관계를 유지하는지 또는 문제는 없는지를 파악
15	공공서비스 활용능력	(예: 기초수급, 산정특례, 장애인 등록, 공공요금 감면, 긴급의료지원 등 공공서비스 포함) • 기초수급, 산정특례, 장애인 등록, 공공요금 감면 등 공공서비스를 신청하고 활용하는지를 평가, 신청 시 스스로 관련 서류를 발급하고 해당 기관에 제출하는 능력이 있는지도 같이 포함하여 평가
16	주거	(주거의 환경 및 비용의 안정성, 위생, 안전을 포함하여 평가) • 주거의 환경에 대한 전반적인 상태에 대한 평가내용을 참조하여 심각도를 체크
17	경제활동 지원	• 연령, 학력에 적합한 경제활동이 스스로 가능한지, 지원이 필요한지, 도움이 필요한지를 평가
18	취업 및 학업욕구	• 연령, 학력에 적합한 경제활동이 스스로 가능한지, 지원이 필요한지, 도움이 필요한지를 평가
19	고용 및 교육가능성	• 정신건강상태가 현저하게 좋지 않아 고용 및 교육의 어려움이 상당한지, 교육 및 고용을 전혀 할 수 없는지, 고용의 가능성이 희박한지를 평가
20	벌금 및 법률적 문제	• 현재 중독 또는 정신과적 문제로 인한 법적 문제가 있는지에 대한 유무 파악 - 음주운전 및 기타 법적 문제, 합의금 유무, 신용카드 빚 또는 벌금, 성관련추행 및 폭행 등 • 사건의 시기, 내용, 진행 상황에 대한 정확한 사정 필요 • 사회적 응급상황에 대처할 수 있는 지원체계가 구축되어 있는지 파악 • 도움 및 지원의 수준을 결정 - 일시적인 수준에 그쳐도 되는지, 더욱 장기적인 도움이 필요한지, 긴급성을 요하는지 등 평가



2) 2단계. 서비스 계획수립 및 연계

- ▶ 1단계 평가 후 심각도 점수가 부여된 문제영역에 대해 제공할 서비스를 계획한다.
- ▶ 개별서비스 계획 수립은 욕구 사정상 항목의 심각도 평가 점수에 따라 개입해야 할 문제에 우선순위를 설정하고, 이에 대한 개입계획을 수립한다.
- ▶ 대상자의 사정 내용과 자원 및 강점, 가족의 욕구 및 협조 등이 계획 수립에 반영되어야 한다.
- ▶ 서비스 계획은 서비스 제공 주체와 제공방법을 포함해서 수립한다.
- ▶ 대상자의 욕구에 맞는 포괄적 서비스 제공을 위해 지역사회 네트워크를 구축해야 하며 욕구사정 결과에 따라 필요시 연계계획을 수립하여 적용해야 한다.
- ▶ 이때 연계 기관 및 연계 시기, 연계 사유 등을 포함한 계획을 수립한다.

• 수립방법

- 사례회의를 통해 논의하고 공유해야하며 포괄적이고 연속성이 보장되어야 함
- 대상자의 임상적 상태 변화에 신속히 반응해야 하며 충분히 실행 가능해야 함
- 개별화된 재발예방 계획이 수립되어야하고 주치의 및 다른 관계자들과 공유되어야 함
- 재발 취약요인을 규명하고 이를 감소시키기 위해 노력해야 함
- 증상 모니터링과 재발 예방을 위해 정기적으로 주치의와 의사소통해야 함

• 서비스 제공주체

- ISP수립에서 서비스 주체기관이란 ‘실제로 서비스를 수행(제공)하는 기관’을 이야기함
- 자체기관에서 제공: 담당사례관리자 또는 팀 접근을 통해 서비스 제공
- 타 기관에서의 서비스 일부 제공: 사례관리는 본 기관에서 제공하고 타 기관의 특정 프로그램을 연계
- 타 기관 사례관리 연계: 타 센터로 사례관리 책임 전체를 연계하는 경우 퇴락을 의미

• 서비스 제공방법

- 개별상담: 대상자 또는 가족에게 방문, 내소, 전화상담 등의 1:1 서비스 제공
- 교육 훈련: 개별 및 그룹프로그램 등의 활동
- 그룹프로그램: 그룹 활동을 통한 서비스 제공(교육 훈련)
- 자원조정: 서비스 제공을 위해 외부 자원을 활용하기 위한 모든 활동
- 정신과 치료 지원(외래방문, 치료비지원 등), 취업장 관리, 복지서비스 연계 및 자문 등 대상자 사례관리를 위해 관련 있는 기관과의 협력 및 관리를 위해 사례관리자가 하는 활동
- 연계: 서비스 제공을 위해 외부 자원을 활용하는 활동

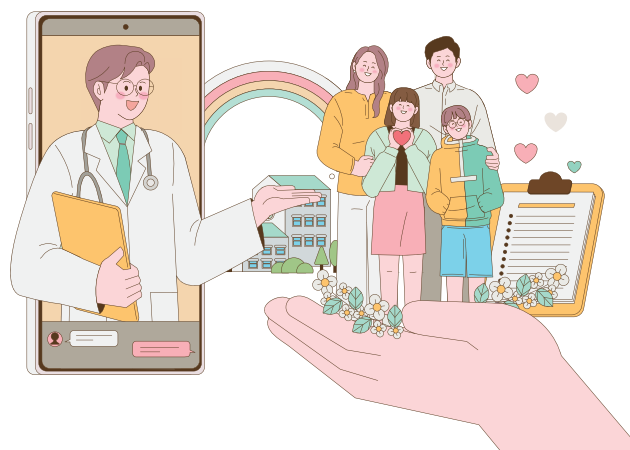
* 연계는 계획적으로 이뤄져야 하며 사전에 대상자, 가족 및 연계기관의 담당자와 서비스 제공 계획에 대해 합의한 후 처리해야 함

기록예시	• 알코올 사용 문제 1. 단주 유지하기 ① 정기적인 외래방문 지원 ② 중독문제 및 일상생활 등 그 외 문제에 대해 정기적 개별상담 실시 ③ 주1회 센터 내 단주 관련 프로그램 참석 ④ 주1회 AA모임 참석 • 정신병적 증상 2. 신체건강 회복하기 ① 정기적인 외래 방문 지원 ② 약물복용법 확인, 복용여부 점검 ③ 치료비 지원 등 신체건강 관련 서비스 연계
------	--

3) 3단계. ISP결과요약 및 장단기 목표수립

- ▶ 1단계에서 심각도 점수가 2점 이상으로 평가된 항목을 바탕으로, 대상자 관리 구분을 설정한다.
 - 관리구분은 사례회의 및 재평가를 통해 변경될 수 있음
- ▶ 평가내용에 대한 사례관리자 소견과 대상자 및 가족의 욕구 사정 결과를 요약하고, 2단계 서비스 계획을 바탕으로 장단기 목표를 수립하여 기록한다.

사정방법	• ISP 결과 - 심각도 점수가 2점 이상 평가된 항목을 기록하고 점수 및 그에 대한 소견을 기록 - 가족의 욕구 파악 결과 기록 • 장단기 목표 수립 - 장기목표, 단기목표로 구분하여 기록
기록예시	• ISP결과 - 알코올 사용 문제(심각도3): 퇴원하고 한 달 경과, 단주 유지 중이나 재발 가능성 있어 집중적인 관리가 필요함 - 신체질환(심각도2): 오랜 술 섭취로 인해 고혈압 등 신체질환 발생, 처방된 약물은 있으나 불규칙적으로 약물 복용함 - 가족의 욕구: 상담 및 단주 프로그램 참석 원함 • 장단기 목표 수립 - 장기목표 1. 단주 유지 2. 신체건강 회복하기(규칙적인 약물복용으로 고혈압 증상 완화 시키기) - 단기목표 1. 2개월 단주하기 2. 주 1회 센터 내 증상관리프로그램 참여 3. 주 1회 센터 내 사회기술훈련프로그램 참여 4. 주 1회 개별상담 진행(증상 및 약물교육, 대인관계 형성 관련) 5. 가족 상담을 실시하여 대상자에 대한 이해 증진, 치료적 관계 형성 도모



참고

관리구분에 따른 계획

- ▶ 등록관리 대상의 기준이 충족되는 경우 중독관리영역별 욕구평가 결과에 따라 위기관리(Crisis Intervention), 집중관리(Intensive Care), 유지관리(Continuing Care), 일시관리, 파악관리로 구분한다.
- ▶ 관리구분은 사례회의 및 재평가를 통해 변경될 수 있다.
 - 위기관리: 즉각적인 위기개입이 없고 자·타해 위험이 심각하다고 판단되는 경우, 위험평가도구 결과 고위험 상황이 확인된 경우, 당장 입원치료가 필요한 경우 등 24시간 이내에 긴급하게 서비스가 제공되어야 하는 대상자 (단, 술이나 약에 취해있는 상태는 해당되지 않음)
 - 집중관리: 집중적 관리가 필요한 대상자, 평가 결과 중독 고위험자이거나 중독자 및 가족
 - 유지관리: 지역사회에서 지속적인 사례관리를 제공 받을 필요가 있는 대상자, 정기적인 외래치료를 통해 단주, 단약, 단도박, 금연을 유지하거나 인터넷이나 다른 중독에서 조절이 유지되고 있는 대상자
 - 일시관리: 집중, 유지관리를 받을 정도는 아니지만, 정기적인 평가나 점검의 필요가 있는 경우
 - 파악관리: 기존 서비스 대상자로서 정신과 병의원 혹은 정신건강복지센터, 정신재활시설과의 대상자 관리에 대한 연계가 결정된 경우/사례관리 대상자로 등록되었으나 지속 사례관리 제공이 어려운 경우 (정기적으로 서비스 제공 가능 여부 파악하여 현실적인 여건에 따라 관리구분 전환이 가능)

[중증정신질환, 중독, 아동청소년 관리구분]

구분	위기관리	집중관리	유지관리	일시관리
기준	• 대상자의 욕구도 평가결과 심각도가 하나 이상 4로 체크된 대상자	• 대상자의 욕구도 평가결과 심각도가 하나 이상 3로 체크된 대상자	• 대상자의 욕구도 평가결과 심각도가 하나 이상 2로 체크된 대상자	• 대상자 욕구도 평가결과 심각도가 모두 1로 체크된 대상자
대상	1) 즉각적인 위기개입이 없으면서 자타해의 위험이 심각하다고 판단되는 경우 2) 당장 입원치료가 필요한 경우 3) 24시간 이내에 긴급하게 서비스가 제공되어야 하는 대상자 4) 다음의 경우는 해당되지 않음 - 경미한 우울장애 - 술에 만취되어 있는 경우 - 기질적 정신장애가 주문제인 경우 - 최근 자해한 적이 있지만 정신질환과 연관성이 희박한 경우	1) 초기 정신질환 상태에서 재발예방을 위해 집중적 관리가 필요한 대상자 2) 다음의 사항을 포함하는 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자 - (중상으로 인한)폭력 혹은 지속적인 범죄의 과거력 - 지속적인 자해 혹은 방치의 심각한 위험 - 치료 순응도가 낮아서 잦은 재발을 하는 경우 - 물질 사용 장애와 정신질환의 이중진단(dual diagnosis)	• 지역사회에서 지속적인 사례관리를 제공받을 필요가 있는 대상자	• 집중, 유지관리를 받을 정도는 아니지만 정기적인 평가나 점검의 필요가 있는 경우

[중증정신질환, 중독, 아동청소년 관리구분]

구분	위기관리	집중관리	유지관리	일시관리
빈도	24시간 이내에 긴급하게 서비스가 제공	매주 혹은 월 4회 이상 집중 서비스 제공	매월 혹은 월 1회 이상	3개월에서 6개월에 1회 이상
ISP 수립		최소 3개월에 1회 이상 ISP(개별서비스 계획) 조정을 필요로 하는 대상자	최소 6개월의 1회 이상 수립	
제공 서비스	일일접촉 (상황 종료 시까지): 입원개입	- 대면상담 (주1회 이상) - 필요에 따라 전화상담 시행 - 일일 투약관리 부작용 및 증상관리 - 치료에 대한 적극적 지원 (단기입원, 의료보장상태 지원 등) - 사회재활 프로그램 의뢰 - 질환별 증상 및 약물관리교육, 훈련 시행 - 개별욕구를 고려한 활동 계획(직장, 대인관계, 생계 등 자립 지원)	- 월1회 이상 대면상담 진행 - 필요에 따라 전화상담 시행 - 사회재활 프로그램 의뢰 - 개별 욕구에 따른 활동계획(직장, 대인관계, 생계 등 자립 지원)	내소 또는 방문 1회/3개월~6개월
참조	파악관리 대상군이란? 센터 등록이후 개별 서비스계획(ISP) 수립 이력이 전혀 없거나 180일을 경과한 경우			

[자살예방 관리구분]

구분	응급	고위험	중위험	저위험
기준	정신상태위험성(1영역) 3점 그리고 자살사고/자살시도(2영역) 3점 그리고 성찰적 실천(6영역) 3점, 기타이슈 해당 없음	정신상태위험성(1영역) 1점 이상 그리고 자살사고/자살시도(2영역) 3점 그리고 기타이슈(3~6영역) 1점 이상 (단, 정신상태위험성(1영역) 3점, 자살사고/자살시도(2영역) 3점, 성찰적 실천(6영역) 3점은 제외)	정신상태위험성(1영역) 1점 이상 그리고 자살사고/자살시도(2영역) 2점 그리고 기타이슈(3~6영역) 1점 이상	정신상태위험성(1영역) 1점 이상 그리고 자살사고/자살시도(2영역) 2점 그리고 기타이슈(3~6영역) 1점 이상
개입횟수	1시간 이내	3일 1회 이상	5일에 1회 이상	7일에 1회 이상
참조	위기개입 대상 아님: 정신상태 위험성 또는 자살사고/자살시도 점수를 부여할 수준이 아닐 경우			

(국립정신건강센터, 『정신건강사례관리시스템(MHIS) 매뉴얼』, 2024)

5. 개입

- ▶ 사정과 개별서비스계획이 끝나면 수립된 계획을 바탕으로 관리구분에 따른 사례관리 서비스를 제공한다.
- ▶ 서비스 제공 방법에 따라 개별상담, 자원조정, 그룹프로그램, 가족지원으로 구분되며, 중독관리 서비스 제공 대상에 따라 직접서비스와 간접서비스로 구분한다.

가-1. 개별상담

- ▶ 대상자 및 가족을 대상으로 1:1 개별상담(대면, 비대면), 개별프로그램 제공한다.
- ▶ 전화상담, 방문상담, 내소상담, 사이버상담, 기타상담 등이 있다.
- ▶ 집중, 유지관리 대상자의 중독문제 및 기능의 향상을 위하여 집중적인 심리 사회적 상담을 지속적으로 수행하고 기록한다.
- ▶ 집중관리 대상자에 대해서는 문제영역에 따라 충분히 적극적인 형태와 빈도의 서비스를 제공해야 한다.
- ▶ 50% 이상의 비대면상담(전화, 사이버 등) 비율은 권장되지 않는다.
- ▶ 병식 유지와 재발 예방 및 위기상황 대처를 위하여 대상자 및 가족을 대상으로 적절한 교육 활동을 수행해야 한다.

• 도움말

SOAP 형식으로 기록하는 방식

- S(subjective): 주관적 정보, 대상자가 자신의 상황이나 문제에 대해 호소하는 내용에 대한 기록
- O(objective): 객관적 정보, 대상자의 태도나 행동에 대한 관찰내용 또는 주거, 건강, 경제 상태에 대한 객관적인 관찰사항에 대한 기록
- A(assessment): 주관적 호소와 객관적 관찰 내용을 기반으로 확인된 문제 기록
- P(plan): 확인된 문제에 대한 계획 및 수행 내용 기록

정해진 형식에 따라 서술형으로 기록하는 방식

- 상담 기록 안에는 대상자의 주 호소 내용과 관찰내용, 주요 문제, 문제 해결을 위한 수행 내용이나 추후 계획 등의 내용을 기록

기록예시	• SOAP 형식 - S: 낮에는 거의 집에서만 있어요, 가끔 운동 삼아서 공원을 걷기도 하는데 금방 들어와요, AA요? 생각 없어요, 일거리가 생기면 일 나갈 생각이예요, 어제 병원에 가서 약 받아왔어요, 잘 챙겨먹고 있어요 - O: 면담 중 손 떨림 관찰, 퇴원 후 한 달간 단주 유지 중, 전일 내과에서 아침 1회 1T 약물 처방 받음 - A: 1. 중독문제 재발 가능성 높음 2. 외부 출입 및 활동량 부족 - P: 1. 규칙적인 내과 약물복용의 필요성에 대해 상담 실시 2. AA모임 및 센터 내 프로그램 참석 지속 권유
	• 주 호소 및 관찰 내용 - 퇴원 이후 현재까지 단주 중 가정에서 외부 출입 없이 지냄, 활동량 저조 - 신체질환(+, 고혈압), 전일 내과 방문하여 약물 처방 받음 - 일에 대한 욕구 보임 • 주요 문제 - 단주 의지 부족 및 재활서비스 거부 - 외부 출입 및 활동량 부족 • 상담 결과 및 추후 계획 - 규칙적인 내과 약물복용의 필요성에 대해 상담 실시 - A.A.모임 및 센터 내 프로그램 참석 지속 권유

가-2. 개별상담(가족)

- ▶ 대상자의 가족과 개별 서비스 계획(ISP) 수립 내용 및 실행결과를 공유하고 센터 이용 중 관찰되는 중독문제 및 기타 정신과적 문제를 상의함으로써 대상자의 재활치료 참여·협조 할 수 있도록 한다.
- ▶ 중독문제 유지와 재발 예방, 위기상황 대처를 위해 가족을 대상으로 적절한 교육활동을 수행해야 한다.
- ▶ 대상자와 가족은 기본적으로 다음의 정보를 제공받을 수 있어야 한다.
 - 사례관리자의 이름
 - 사례관리에 대한 설명(사례관리를 통해 받을 수 있는 도움의 범위와 정도)
 - 위기상황 발생 시 연락 할 수 있는 방법
 - 개별 서비스 계획과 재발예방 계획 및 위기대응 계획
 - 치료에 대한 전반적인 정보
 - 사례관리 전반에 대한 의사표시 방법

1) 전화

- ▶ 대상자 또는 가족을 대상으로 개별서비스계획(ISP)에 근거해 전화 통화를 이용한 서비스 제공한다.
단순공지 및 안내는 전화상담에 해당하지 않으며, 개입내용에 따라 자원조정 또는 기타상담에 해당한다.

2) 방문

- ▶ 대상자 또는 가족을 대면하기 위해 상담대상이 있는 센터 외부의 장소(중독자 가정, 학교, 기타 상담을 위한 외부기관 등)로 방문하여 개별서비스계획(ISP)에 근거해 서비스를 제공하는 것을 의미한다.
- ▶ 중독자 대면상담 시 대상 가구의 특성 및 안전문제 등을 감안 하여 2인 1조 방문을 권장하며, 내소상담을 권하였으나 이유 없이 방문을 고집하거나 자·타해의 위험성이 높은 대상자 등* 을 방문상담하게 될때에는 경찰과 동행을 권장한다.

*「국립정신건강센터, 지역사회 정신건강기관종사자 안전 및 권익 보호 매뉴얼」참고

- ▶ 대상자 및 가족을 대면하기 위해 방문하였으나 대상자를 만나지 못하고 주변인(이웃, 교사, 의사 등)을 만나 상담하는 경우는 개입내용에 따라 자원조정 또는 기타상담에 해당한다.
- ▶ 대상자 및 가족을 대면하기 위해 방문하였으나 부재하여 대면하지 못하거나, 우연한 짧은 만남의 경우는 방문상담에 포함하지 않는다.

3) 내소

- ▶ 대상자 또는 가족이 사례관리기관으로 내소하여 진행된 서비스를 의미하며, 그룹프로그램을 위한 내소 및 단순내방은 개별내소상담에 포함하지 않는다.

4) 사이버

- ▶ 인터넷 채팅, 메일 등을 이용해 개별서비스계획(ISP)에 근거해 서비스를 제공하는 것을 의미한다.

5) 기타

- ▶ 개별서비스계획(ISP)에 근거하여 대상자 및 가족에게 전화, 방문, 내소, 사이버 외의 상담형태로 서비스를 제공하는 경우에 해당한다.

나. 자원조정

- ▶ 개별서비스 계획(ISP)에 근거하여 정신건강서비스를 제공하기 위해 치료연계 및 유지, 복지서비스 연계 및 자문, 취업장 관리 등 사례관리에 있어 대상자와 직접 관련이 있는 기관 혹은 종사자와의 모든 조정 내역을 의미한다.
- ▶ 자원조정에는 대상자가 이용 중인 자원의 유지 및 새로운 자원연계를 위한 탐색을 포함한다.
 - 의학적 치료와 조율을 위한 주치의와의 정기적인 의사소통
 - 복지서비스 연계를 위한 지역사회기관 탐색
 - 정신건강서비스 및 복지서비스 연계 후 관련 기관과의 협력활동 및 서비스 담당자와의 정기적인 의사소통 등

기록예시	• 상담주제: 약물 복용시간 조정을 위한 주치의 면담 요청 - 대상자 경과 및 주요문제: 병원에서 퇴원 후 외부 활동 없이 집에서 생활, 증상이 간헐적으로 발현되나 일상생활을 유지하는데 어려움 없음, 스스로 약물 복용하는 것에 대한 걱정이 있으며 점심 약을 한차례 잊어버린 이후 불안 호소하는 등 스트레스 있음을 전달 - 결과 및 계획: 대상자 외래방문 시 약물 복용시간 변경과 관련하여 면담을 예정 • 상담주제: 약물 조정을 위한 주치의 면담 실시/대상자동행 - 면담내용: 센터 사례관리 및 주간재활프로그램 서비스를 받고 있음(약물 및 증상교육, 미술치료, 행사참여 등) 약물부작용(체중증가)으로 인해 1~2개월 전부터 약물 임의복용 시작, 최근 수면문제, 환청 등 증상이 발현되어 생활이 불안정해지고 대인관계의 문제 발생, 이와 관련하여 대상자 상태 전달하고 면담, 약물조정 요청 - 결과: 대상자 면담실시, 약물조정 - 계획: 외래진료 일을 1주 단위로 조정하고 지속관찰, 응급상황 발생 시 관련 사항 개입을 위한 의사소통 유지 • 상담 주제: 대상자의 단주 유지상태 공유 - 대상자 경과 및 주요문제: 퇴원 이후 현재 단주 유지 중이며 센터 상담서비스 받고 있음, 지속적으로 A.A.모임 참석을 권유하고 있으나 거부하고 있으며 외부활동 부족함을 알림 - 결과 및 요청사항: 대상자 외래 방문 시 외부 활동관련 상담 요청
------	--

1) 전화

- ▶ 사례관리대상자의 개별서비스계획(ISP)에 따라 대상자와 관련한 기관 혹은 지역사회 관계자와 전화 통화를 이용한 의사소통, 대상자를 위한 간접서비스를 수행한 경우를 말한다.

2) 방문

- ▶ 사례관리대상자의 개별서비스계획(ISP)에 따라 대상자와 관련한 기관 혹은 지역사회 관계자를 대면하기 위해 방문하여, 대상자를 위한 간접서비스를 수행한 경우를 말한다.
- ▶ 대상자의 서비스 계획과 무관한 단순 방문, 지역사회 기관의 교육이나 회의를 참여하기 위한 방문의 경우 사례관리 자원조정(방문)에 해당하지 않는다.

3) 내소

- ▶ 사례관리대상자의 개별서비스계획(ISP)에 따라 대상자와 관련한 기관 혹은 지역사회 관계자가 센터로 방문하여, 대상자를 위한 간접서비스를 수행한 경우를 말한다.
- ▶ 대상자의 서비스 계획과 무관한 센터 내소, 센터에서 주관하는 교육이나 회의를 참여하기 위한 내소의 경우는 사례관리 자원조정(내소)에 해당하지 않는다.

4) 사이버

- ▶ 인터넷 채팅, 메일 등을 이용해 사례관리대상자의 개별서비스계획(ISP)을 수행하기 위해 대상자 및 대상자의 가족 외의 기관 또는 지역사회 관계자와 의사소통하거나 서비스를 수행한 경우를 말한다.

5) 기타

- ▶ 사례관리대상자의 개별서비스계획(ISP)에 근거하여 대상자와 관련한 기관 혹은 지역사회 관계자에게 전화, 방문, 내소, 사이버 외의 상담형태로 서비스를 제공하는 경우를 말한다.

다. 그룹프로그램

- ▶ 대상자의 회복을 위해 개별 또는 집단으로 운영되는 프로그램을 말한다.
- ▶ 개별사례관리계획(ISP)에 근거하여 교육·일상생활 훈련·여가활동과 관련한 그룹프로그램을 제공하고, 대상자의 참여 행동 관찰 및 평가를 진행한다.

참고

중독 사례관리 욕구사정

재활프로그램
기타재활
가족프로그램
직업프로그램

대분류	중분류	소분류
중독프로그램	가족교육	
	사회기술훈련	
	스트레스 및 긴장완화	
	신체건강관리	
	약물 및 증상관리훈련	약물 및 증상관리 프로그램
		알코올 중독관련 프로그램
		약물 중독관련 프로그램
		인터넷 중독관련 프로그램
		도박 중독관련 프로그램
	동기강화프로그램	
	여가 및 문화활동	
	예술치료	
	인지재활	
	일상생활훈련	
	자조모임	
	지역사회적응훈련	
	직업재활활동	취업전프로그램
		보호작업장
		직업훈련
		취업적응훈련
	행사참여	
	자치운영활동	
	기타	

참고 그룹프로그램 일지 양식(예시)

프로그램 일지			
프로그램명		프로그램 분류	프로그램 대분류
담당자 (주진행자)		구분	
실시일자			
참석인원			
내용			

개인별 기록				
이름	진단코드	사례관리자	출석여부	내용

참고

그룹프로그램 일지 작성(예시)

- 프로그램 기록 시 입력항목
 - 프로그램명
 - 운영 차수(1차, 2차 등), 각 회기별 주제
 - 프로그램 목표
 - 프로그램 시작과 종료시간, 진행 총 시간
 - 참여 대상자 이름, 참여자 수
 - 프로그램 내용(진행순서 및 세부 내용)
 - 프로그램 평가

<프로그램 기록예시: 동기강화프로그램>

- 계획
 - 목표: 회복을 위해 자발적 단주를 강화
 - 진행기간 및 횟수: 3분기(총 10회기)
 - 회기별 내용: 1회기~10회기 프로그램 제목 입력
 - 평가: 프로그램 만족도 평가 방법 기술
- 회기운영
 - 주제: 오리엔테이션 및 집단규칙 설정(1회기)
 - 목표: <동기강화프로그램> 프로그램에 대한 이해 및 참여규칙 설정
 - 프로그램 내용:
 - ① 프로그램 안내 및 진행자 소개
 - ② 위밍업: 옆 사람 칭찬 하나씩 하며 소개해주기, 간단한 게임
 - ③ 프로그램 참여 집단규칙 만들기
 - ④ 동기강화치료의 필요성
 - ⑤ 소감 나누기
 - 다음 회기 공지
 - 진행자 및 보조진행자 프로그램 평가
- 평가
 - 목표: 회복을 위해 자발적 단주를 강화
 - 결과
 - ① 진행기간: 2025.1.2.~3.31.(매주 화요일 오후 13:00~14:00)
 - ② 진행장소: 센터 내 재활프로그램실
 - ③ 진행횟수: 10회기
 - ④ 참석자: 000중독관리통합지원센터 주간재활 이용대상자 6명
 - 평가 요약: 만족도 평가 내용, 프로그램 총평(성과 및 환류)

<개인별 기록 작성예시>

- 방법
 - 참석 대상자별 프로그램 평가를 진행하고 기록, 프로그램 중 관찰된 내용이나 반응, 프로그램에 대한 만족도를 파악한 후 기록
 - 평가 결과를 바탕으로 차후 계획을 수립

- 기록예시
 - 관찰 및 상담 내용
 - > 프로그램 시작시간을 준수하여 참여
 - > 프로그램 중반에 멍하게 앉아 있거나 진행자가 설명을 할 때 주의집중 하지 않는 모습 관찰
 - > 이에 대상자에게 직접 질문을 하고 대답을 유도하여 프로그램에 주의 집중 하도록 함(대상자의 프로그램 참여에 대한 느낌에 대해 “사람들을 만나는 기회가 있어 좋았다.”라고 평가)
 - > 평가 및 계획: 담당 사례관리자에게 사항 전달하고 프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 독려할 예정

라. 가족지원

- ▶ 대상자의 가족과 개별서비스 계획(ISP) 수립 내용 및 실행결과를 공유하고 센터 이용 중 관찰되는 중독문제 및 기타 정신과적 문제를 상의함으로써 대상자의 재활치료 참여·협조할 수 있도록 한다.
- ▶ 중독문제 유지와 재발 예방, 위기상황 대처를 위해 가족을 대상으로 적절한 교육 활동을 수행해야 한다.
- ▶ 대상자와 가족은 기본적으로 다음의 정보를 제공받을 수 있어야 한다.
 - 사례관리자의 이름, 사례관리에 대한 설명, 사례관리를 통해 받을 수 있는 도움의 범위와 정도, 위기상황 발생 시 도움을 받을 수 있는 방법, 개별 서비스 계획과 재발 예방 계획 및 위기대응 계획, 치료에 대한 전반적인 정보, 사례 관리 전반에 대한 의사표시 방법
- ▶ 대상자 개별서비스 개입목표와 관련한 가족의 신체질환, 중독 및 정신과적 문제에 대한 사정 및 자원조정, 치료연계를 할 수 있다.
 - 가족의 중독문제에 별도 개입이 필요할 것으로 평가되는 경우 사례관리대상자로 등록하여 관리할 수 있음
- ▶ 대상자 개별서비스개입계획과 관련된 가족의 욕구사정 및 자원조정, 복지서비스 연계서비스를 제공할 수 있다.

6. 점검 및 평가

- ▶ 서비스 제공의 적절성 및 팀 접근을 통한 포괄적 사례관리 서비스 제공을 위해 대상자의 기능 수준 및 삶의 질에 대한 만족도가 개선되고 있는지 평가하고 이에 대한 성공요인, 장애요인에 대한 분석을 통해 대상자의 재사정, 계획의 재수립 단계를 거친다.
- ▶ 이 단계를 통해 대상자는 사례관리 서비스 관리 구분에 변화가 발생할 수 있으며, 앞서 제시된 기준들에 의거하여 퇴록과 서비스 유예 등을 결정할 수 있다.
- ▶ 대상자의 사회적 기능에 해당하는 상태를 점검할 수 있도록 치료계획 회의, 사례검토회의를 통해 점검한다.

사정방법	• 사례관리 계획에서의 진행과정 및 결과 검토 - 사례개입 목표달성도 - 욕구 충족 정도 - 대상자 문제나 증상의 완화 및 회복 정도 - 사회적응 능력 증진 여부 • 표준화된 검진도구를 활용한 사전·사후 평가
------	---

- ▶ 점검 및 평가를 위해 사례회의(일일·주간·월간)를 통한 팀 접근, 사례운영회의, 유관기관 사례회의를 진행한다.

1) 사례회의

- ▶ 대상자에 대한 서비스 목표설정 및 ISP 수립을 위한 개입 수준과 범위, 방향성 등이 공유되거나 논의하는 회의로 대상자 등록 여부 결정, ISP 수행과정 및 점검, 평가 및 종결 결정 등을 위해 필요한 경우 사례회의를 수시로 개최한다.
- 일일사례회의(Brief daily review meeting)
 - 중독관리통합지원센터 이용 중 대상자의 특이사항이나 팀 접근을 통한 개입이 필요한 경우 일일 사례회의를 통해 논의할 수 있음
 - 위기개입이나 즉각적인 개입이 필요한 대상자 및 문제가 발생한 사례에 대한 개입 방향을 논의함
- 주간사례회의(Weekly review meeting)
 - 특정 요일을 정하여 정기적으로 수행하고 위기관리 및 집중관리 대상자에 대한 개별서비스 계획 수립내용을 팀원들과 공유하며, 특히 신규 등록자에 대한 팀 차원의 평가를 통해 초기 서비스 계획을 수립할 수 있도록 함
- 월례사례회의(Monthly review meeting)
 - 초기사정이 완료되어 개별 서비스 계획(ISP)이 수립된 대상자 중 문제 사례를 중심으로 심층적 사례분석을 수행함

2) 사례운영회의

- ▶ 상반기와 하반기에 각각 1회씩 사례운영회의를 실시한다.
- ▶ 사례운영회의를 통하여 모든 등록관리 대상자에 대한 사례관리 계획과 경과 및 결과가 정기적으로 점검되어야 한다.

3) 유관기관 사례회의

- ▶ 지역사회 차원에서의 포괄적 서비스 제공을 위해 지역사회 유관기관과의 사례회의를 진행하거나 참여할 수 있다.



참고

정신건강 사례관리 서비스 과정 요약

구분	주요 개입방법 및 수집 정보
초기상담 intake	• 인적정보(이름, 성별, 나이, 진단명, 주소, 간략한 치료내용, 의뢰경로 등) • 주요병력 및 주 호소, 문제 상황 • 가족력, 신체질환 여부 확인 • 대상자 및 가족욕구 사정 • 이용/입소 동의여부 확인 및 등록과정/서비스 내용/비용안내
초기사정	• 생애주기별 발달력 • 구체적인 치료력 및 입원력 • 주 호소 및 주요문제 • 약물정보 및 부작용 • 사회적 조사(대상자의 일상생활, 사회적 자원 활용, 대인관계기능, 직업 기능, 여가기능에 대한 사정) • 가족의 인적정보 및 가족병력 • 대상자 및 가족의 욕구 파악 • 대상자의 강점, 한계점 파악 • 평가도구 활용 및 결과 기록
계획	• 대상자의 기본자원 및 현재 이용하고 있는 외부자원에 대한 정보 수집 • 계획 수행을 도울 수 있는 가족이나 그 외 사회적 지지체계에 대한 정보 수집 • ISP 수립 템 상 욕구사정 도구를 이용하여 욕구사정 및 심각도 측정
개입	[직접적 개입] • 위기개입 • 개별상담 • 가족상담 및 지원 • 지역자원 연계(공공기관 및 지역사회기관 연계 등) • 주치의와의 정기적 교류 유지 • 자립 지원 • 질환별 개별교육 • 주간재활(사회통합) 프로그램 참여 유도 [간접적 개입] • 센터에서 주최하거나 참여하는 각종 행사 및 체육대회, 송년회 등
점검	• 사례관리 계획에 따른 이행이 잘 되어가고 있는지에 대한 지속적인 평가 • 수행이 어려운 일에 대한 계획 및 전략 수정 • 갈등의 중재자 역할 수행 • 치료계획 회의, 사례검토회의를 통한 점검 • 슈퍼비전 내용 적용 및 기록
평가	• 정기적 평가 수행 • 평가 시 대상자와 가족 참여 • 재사정과 재평가의 결과는 향후 대상자에 대한 개입계획에 반영 - 평가를 통해 재사정 실시 및 기록

7. 퇴록

- ▶ 퇴록은 사망하거나 타 지역으로 전출한 경우를 말한다.
- ▶ 타 지역으로 전출한 경우 동의를 얻어 해당 지역 중독관리통합지원센터 또는 정신건강복지센터로 연계한다.
- ▶ 해당 지역 중독관리통합지원센터 또는 정신건강복지센터로 연계한다.
- ▶ 다음과 같은 경우 정신건강의학과 전문의가 포함된 사례회의를 통해 퇴록을 결정할 수 있다.
 - ISP(개별서비스계획)에 의해 수립한 치료 계획에 근거해 제공된 서비스가 충족되어져 안정적으로 지내는 경우
 - 증상 안정 또는 정신재활시설 등에서 주된 재활서비스가 제공되어 사례관리 책임이 이관된 경우
 - 3~6개월 이상 연락이 닿지 않는 경우
- ▶ 다음과 같은 경우 정신건강의학과 전문의가 포함된 사례회의를 통해 서비스 제공을 일정 기간 유예할 수 있다.
 - 대상자 및 보호자가 서비스를 강력히 거부하는 경우(단, 이 경우는 증상, 위험도에 따른 사례관리 필요성에 따라 신중히 결정)
 - 증상으로 인한 것이 아닌 위험한 행동(예를 들어, 폭력적인 언행이나 행동, 타해의 위험성이 명백한 경우, 성추행)을 보이거나 사례관리자가 주관적으로 위험감을 느끼는 경우





IV

부 록

1. 중독의 이해
2. 중독의 특징
3. 정신심리·사회문화적 원인과 정신사회적 치료
4. 단기개입
(SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)
5. 중독관련 정신건강 검진도구 및 사용
6. 중독 정신건강 사업 수행기관
7. 사례관리 서비스 모니터링 체계 및 슈퍼비전
8. 사례관리 윤리와 대상자 관리

IV 부록



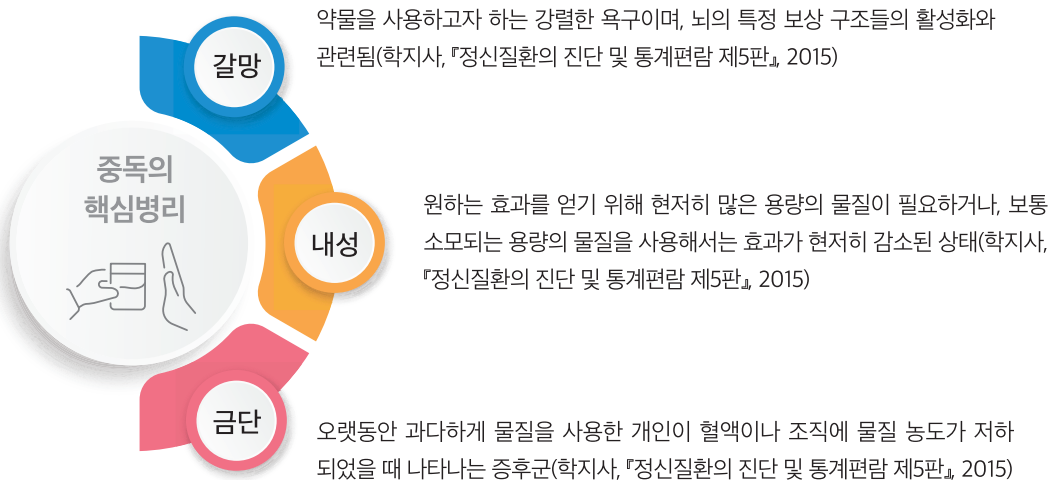
1. 중독의 이해

가. 중독이란

- ▶ 알코올, 일부 약물, 니코틴, 도박, 온라인게임 등은 우리 두뇌의 쾌락중추에 작용하여 도파민을 분비시켜, 강한 쾌감을 유발, 이러한 물질, 행위가 주는 보상효과에 과도하게 집착함으로써, 다른 일상적 보상에 둔해지고, 결국 일상생활의 의미있는 수행이 어려워지는 상태를 중독이라고 한다.

(중독포럼, 『중독에 대한 100가지 오해와진실』, 2017)

나. 중독의 핵심병리



다. 중독변화의 5단계

단계	정의	목표
인식전	• 변화에 대한 의지 없음 • 부정하거나 저항을 보임	• 문제에 대한 의심과 인식을 증진
인식	• 문제를 알아차림 • 변화에 대한 양가감정	• 결정저울
준비	• 변화결단 • 최선의 방법은 혼동	• 최선의 방법 결정
실천	• 실제적인 행동 변화 • 치료	• 협력적이고, 현실적인 목표 적용
유지	• 변화행동	• 새로운 삶의 방식 발견 • 재발 방지

(광주광역시건강복지센터·중독포럼, 「중독문제에 대한 선별과 1회기 단기개입 매뉴얼」 2018)

2. 중독의 특징

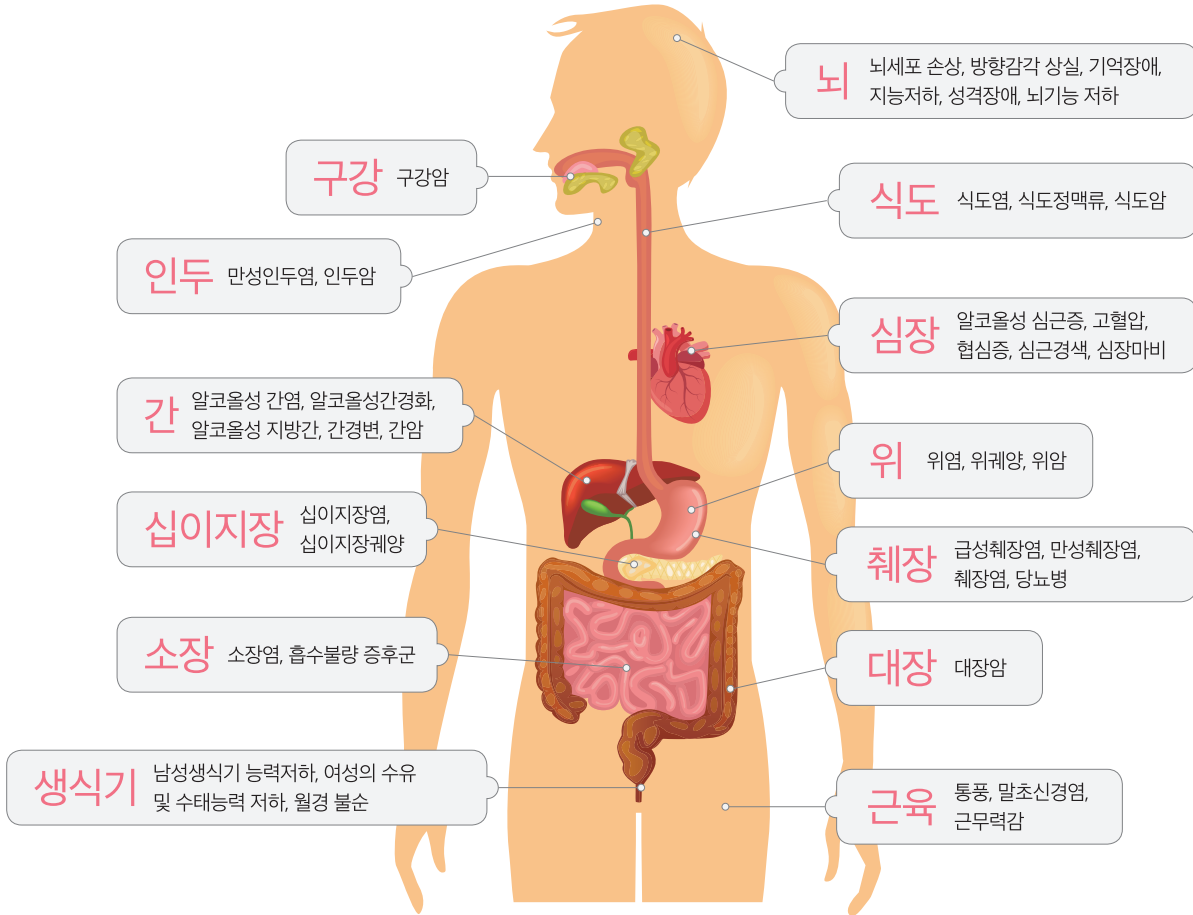
가. 알코올 중독

1) 알코올의 작용

- ▶ 뇌 기능을 억제시켜 대담하고 편안한 느낌으로 기분을 좋게 함
- ▶ 구강점막, 식도, 위로 흡수되어 혈액으로 들어가 각 장기와 조직에 머물면서 해를 줌
- ▶ 우리 몸 세포의 산소 신진대사와 영양물질의 흡수를 방해하여 영양장애를 초래함
- ▶ 꿈꾸는 시간을 감소시켜 숙면을 방해하고 수면장애를 일으킴
- ▶ 알코올은 내성이 있어 마실수록 주량이 점점 증가하고 안 마시면 금단증상이 나타남

2) 음주로 인한 부정적 결과

▶ 음주의 신체적 피해



▶ 음주의 사회적 피해

- 성적행동, 폭력행위, 가정 불화와 폭력, 자살 및 타살, 대인관계 장애

▶ 혈중 알코올 농도별 증상

혈중농도(g/dL)	효과
0.05%	• 사고력, 판단력, 절제력이 약화
0.10%	• 몸이 흐트러지고 동작이 서툴러짐 • 이 상태에서 운전을 하면 면허가 취소
0.20%	• 소리를 지르고 행동이 거칠어지고 비틀거리게 됨
0.30%	• 행동이 더 흐트러지고 이해력이 떨어짐
0.40%	• 무의식, 혼수 상태에 빠짐
0.50% 이상	• 체온조절능력, 호흡과 심장 기능의 장애로 사망하게 됨

3) 알코올 관련 중독 진단별 증상

▶ 알코올 사용장애(Alcohol Use Disorder)

- 알코올에 대한 갈망과 지속적인 사용
- 음주에 대한 조절 능력 상실
- 음주로 인한 사회적, 직업적 문제(예: 가족 갈등, 직장 내 문제)
- 음주를 계속하기 위해 알코올의 양을 늘리는 내성 발생
- 금주 또는 음주를 줄이려는 시도 실패
- 음주와 관련된 위험한 상황을 경험하는데도 불구하고 음주 지속



▶ 알코올 중독(Alcohol Intoxication)

- 우리가 흔히 말하는 '술에 취한 상태'
- 불분명한 언어와 불안정한 보행, 운동실조, 불안정한 판단력, 기억력 손상(단기 기억 상실), 구역질, 구토 및 혼미 상태, 기분 변화나 과민 반응, 신경학적 증상(운동실조, 협조 불능)
- 동일량을 음주할 때 여성의 혈중 알코올 농도가 남성보다 더 높게 나타나는데 이는 여성이 남성에 비해 신체 수분량이 적고 위장에 알코올 탈수소 효소 활성이 더 낮기 때문

▶ 알코올 금단(Alcohol Withdrawal)

- 손 떨림 증가, 불안과 불면증, 환각, 오심과 구토, 과민성과 기억력 문제, 진전 섬망
- 알코올 사용 중단 혹은 감소 6~48시간에 시작, 대략 2~7일간 지속
- 지연 금단 증후군: 상당 기간이 지난 후 금단증상이 나타나기도 함

▶ 정신병적 장애(Psychotic Disorders)

- 급성중독이나 금단 상태에서 환각이나 편집망상 등의 정신병적 증상이 나타날 수 있음
- 알코올 금단에서 나타나는 환청은 일반적으로 단기간 내에 회복됨, 환각은 장기적일 경우 다른 정신병적 상태의 징후일 수 있으므로 검토가 필요

▶ 우울장애(Depressive Disorders)

- 과음 후 우울감을 경험
- 주요 우울장애에 해당하는 경우도 있으며, 금주 후 급속히 회복될 수 있음
- 과도한 음주와 연관된 우울증상은 인지 행동 치료를 통해 해결할 수 있으며, 필요시 약물 치료가 추가될 수 있음

▶ 불안장애(Anxiety Disorders)

- 급성 금단기 동안 공황발작이나 불안 증상이 나타날 수 있음
- 광장공포증과 같은 불안 장애의 증상을 호소하기도 하는데, 불안의 증상이 급성중독이나 금단 상황에 국한한 것이라면 자발적인 회복을 기대할 수 있음

나. 기타물질 중독

1) 아편계 관련장애

- ▶ 아편은 설익은 양귀비 열매에 상처를 내어 흘러내리는 추출물로 만들어진 것, 아편유사제는 아편과 기능적으로 연관성을 지닌 천연 및 합성화학물을 통칭
- ▶ 증상: 급격한 쾌감과 함께 피부가 따듯하게 달아오르는 느낌, 입이 마르고, 사지가 무겁게 느껴지고, 구역질 및 구토, 피부 가려움, 의식 혼미, 사망
- ▶ 급성: 불안, 초조, 근육 및 뼈의 통증, 불면, 설사, 구토, 발한, 하품, 눈물/콧물, 발열, 동공산대

2) 자극제 관련장애

- ▶ 암페타민과 암페타민의 유도체인 메쓰암페타민 및 코카인이 전세계적으로 가장 많이 남용되는 대표적인 정신자극제
- ▶ 급성: 에너지 및 성욕의 증가, 피로 및 식욕의 감소, 빈맥, 혈압상승, 불면, 불안, 이자극성, 혼미, 편집증, 공황 발작 및 환각, 과대망상, 공격성, 고열, 과반사, 떨림, 발한, 과호흡 및 혈압상승
- ▶ 금단: 불쾌한 기분과 함께 피로, 생생하고도 기분 나쁜 꿈, 불면(또는 과수면), 식욕 증가, 정신 운동 지연(또는 초조)

3) 대마 관련장애

- ▶ 대마(삼)작물(마리화나 등)
- ▶ 증상: 쾌감과 안락함, 기분이 들뜸, 쉽게 웃고, 말이 많아지고 졸리거나 시간이 흘러가는 것이 왜곡되게 느껴지고 외부자극에 민감해짐, 식욕의 증가, 입 마름, 빈맥과 혈압의 상승 및 기관지 확장
- ▶ 급성: 불쾌감 불안, 공황 상태, 편집증, 환청, 피해망상, 단기 기억·집중력·판단력·운동 협조 능력·복잡한 정신적 과제들의 수행·반응 시간 등에 장애 유발
- ▶ 금단: 이자극성, 불면, 불쾌감, 식욕감퇴, 우울, 불안, 복통, 떨림, 발한, 열, 두통, 오한

4) 환각제 관련장애

- ▶ 자신 및 현실에 대한 지각, 감각, 사고, 감정 등을 심각하게 변화시키는 능력을 지닌 다양한 화학적 물질들
- ▶ 펜시클리딘: (저용량) 해리증상, (고용량) 편집증, 공격성, 광범위한 심혈관계 및 신경계(경련, 근육긴장이상, 고체온증 등) 독성 초래하여 심한 경우 혼미, 혼수를 유발하여 사망
- ▶ 엑스터시: 구역감, 갑작스런 변의, 주변의 사람들은 물론 전 우주와도 강력한 힘으로 연결된 느낌이 들며 타인에 대한 친밀도가 급격히 상승, 정신행동 초조이상, 이갈이, 발한, 홍조, 떨림, 졸음, 의욕의 감소, 무기력감, 우울 및 피로감
- ▶ Lysergic acid diethylamide(LSD): 감각을 강렬하게 느끼게 하고 환각을 형성하거나 기분의 변화, 시간에 대한 느낌 변화, 초조, 급격한 불안감, 때로는 우울감 유발
- ▶ 신종합성마약: 적은 용량에도 강한 쾌감들을 유발하며 고용량 혹은 만성적으로 투여하였을 경우 정신증, 공격 행동, 빈맥, 고열 및 사망에 이르게 할 수 있음

5) 니코틴 관련장애

- ▶ 20초 만에 뇌에 도달하여 기분이 좋아짐을 느끼게 됨
- ▶ 흡연은 식후나 배변 등 특정 행위와 함께 하는 경향이 많으며, 이러한 중립적인 자극들은 반복적인 흡연을 통해 연합 학습되어 흡연 갈망 유발 자극이 됨
- ▶ 금단: 짜증, 집중력 저하, (만성적인 흡연) 과거에 기쁨이 되었던 일상생활에서의 보상에 대한 반응성 저하

6) 흡입제 관련장애

- ▶ 본드, 부탄가스, 구두 광택제, 스프레이 페인트, 페인트 시너, 가솔린, 아세톤, 벤젠, 에어로졸 스프레이 등
- ▶ 주로 청소년, 위기청소년이 사용, 빠르게 효과 나타나고 가격이 저렴하여 접근성 높음
- ▶ 증상: 어지럽거나 어눌한 발음, 협동 운동 실조, 다행감, 흥분, 유쾌한 기분, 무기력감, 감각과 운동이 느려짐
- ▶ 급성: 방향감각 상실, 자아통제 상실, 무의식, 발작, 공포감, 환각 및 혼수상태
- ▶ 장기간: 자극과민성, 감정적 불안정성, 기억력 장애 및 지속적인 정신질환 유발

7) 진정, 수면, 항불안제 관련 장애

- ▶ 벤조디아제핀계 약물(옥사제팜, 로라제팜, 아티반 등), 졸피뎀
- ▶ 진정, 수면, 항불안제는 긴장완화, 불면감소, 수면 유도등의 목적으로 사용되나 내성과 의존을 빨리 일으킴
- ▶ 바르비탈류: 동작이 둔해지며 사고력과 기억력의 장애가 오며 이해력, 판단력, 집중력이 떨어짐
- ▶ 벤조디아제핀류: 적대적이고 공격적인 행동 유발, 알코올과 비슷하게 평안과 이완을 가져옴
- ▶ 졸피뎀: 비정상적인 사고 및 행동의 변화, 항불안 효과뿐아니라 수면 운전과 같은 행동을 하고 기억을 못하는 경우나 음식을 먹거나 전화 또는 성관계에 이르기까지 다양한 복합수면행동을 유발, 기괴한 행동, 초조, 환각, 이인증

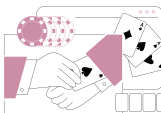


다. 행위 중독

1) 도박장애

- ▶ 지속적이고 반복적인 부적응적 도박행위로, 심각한 개인적·사회적·직업적 손상을 초래하는 정신질환

▶ 도박의 종류

구 분	합법 사행산업	불법도박		기 타
		불법 사행산업	불법 사행산업 외 도박	
도박유형	· 카지노 · 경마 · 경륜 · 경정 · 복권 · 체육진흥투표권 · 소싸움 	· 사설도박 · 불법사행성게임장 · 불법온라인도박 	· 불법하우스도박 · 기타 	· 주식 · 가상자산 · 확률형아이템 · 기타 

▶ 도박을 하게 되는 동기

금전동기	· 쉽게 큰돈을 따고 싶거나 잃은 돈을 만회하고 싶은 욕구
흥분동기	· 스릴과 흥분, 짜릿함, 쾌감과 즐거움을 느끼고 싶은 욕구
회피동기	· 현실문제의 압박감, 우울감, 스트레스를 잊고 싶은 욕구
사교동기	· 직장 동료나 친구들과 놀이 및 친목의 욕구

▶ 도박의 진행과정

- 따는 단계: 초기에 큰돈을 따면서 돈을 딸 때 경험한 황홀감 혹은 쾌감이 기억으로 남게 됨
- 잃는 단계: 점점 금액이 커지고, 혼자서 도박을 하러 다님, 거짓말 증가
- 절박/절망 단계: 경제적 파탄, 불법행위, 우울증, 자살사고 등으로 이어짐

▶ 도박중독자의 행동

- 거짓말과 변명이 늘어남
- 도박을 조절하거나, 줄이거나, 중지하려는 노력을 반복적으로 실패함
- 도박으로 돈을 잃은 후, 그 돈을 만회하기 위하여 다시 도박을 함(추격매수)
- 도박으로 야기된 경제적 문제 해결을 위하여 다른 사람에게 의존함
- 도박자금 조달을 위하여 지폐 위조, 사기, 도둑질, 횡령과 같은 불법행위를 저지름
- 공과금·관리비 미납이 잦아짐

- 도박으로 인하여 의식주 등 기초생활과 관련된 부분에 문제가 생김
- 가족의 중요한 기념일과 일정을 놓침
- 도박 때문에 학교나 직장애 소홀해짐
- 도박이나 돈 문제로 가족이나 친구와 다툼
- 도박 때문에 다른 사람으로부터 비난을 들음

▶ 도박중독자의 정서

- 도박을 못하면 안절부절 못하거나 불안해함
- 도박을 하지 않을 때 상실감이나 공허감을 느낌
- 도박의 결과로 매우 극단적인 감정변화(예, 천국과 지옥을 오가는 감정변화)를 경험
- 분노, 불안, 우울 등 부정적인 감정이나 개인적인 문제에서 벗어나기 위해 도박을 함
- 도박 행동이나 도박으로 인한 결과 때문에 죄책감, 수치심을 느낌

▶ 도박중독자의 사고

확률에 대한 잘못된 이해	• 도박을 해서 쉽게 돈을 벌 수 있음 • 많이 잃었으니 이제 딸 때가 되었음 • 이번에는 지난번과 달리 이길 것임
운과 미신	• 따고 싶다고 기원했거나 이길 것이라고 생각했기 때문에 이겼음 • 결국에는 따게 될 것임 • 이번에 거의 딸 뻔했으니까 다시 하면 반드시 따게 될 것임 • 행운을 가져오는 부적을 갖고 있어서(행운의 옷을 입어서, 행운의 자리에 앉아서) 딴 것임 • 승리를 가져오는 나만의 특유한 행동(징크스)이 있음
도박 기술에 대한 과신	• 나는 이기는 방법을 알고 있음 • 다른 사람들보다 내가 실력이 좋아서 딴 것임
선택적 회상	• (실제로 잃은 적이 더 많았음에도) 나는 잃을 때보다 딸 때가 더 많음
기타 생각	• 나와 맞는 기계가 있고, 나와 맞지 않는 기계가 있음 • 이 기계는 어제 내가 잃은 돈을 가지고 있기 때문에 나는 되찾을 수 있음 • 도박으로 돈만 딴다면 지금 내가 처한 모든 문제가 해결될 것임

2) 인터넷 및 스마트 기기 중독

- ▶ 인터넷에 대한 인식은 인터넷 과다 사용과 연관이 됨(또한 인터넷을 계속 사용하게 하는 강화 인자, 성격 관련 요인, 신경생물학적 취약성 및 공존질환도 관련 있음)
- ▶ 인터넷 중독 취약성과 연관된 미시적 환경 요인

위험요소군	위험요소	설 명
주변환경관련 요인	도래문화	• 도래문화의 특성상 특정 친구나 교우관계 등에 의해 인터넷에 빠져들게 되는 상황
	접근용이성증가	• 컴퓨터 구입, 인터넷 전용선 설치, 자기 방에 컴퓨터가 설치된 경우 등 인터넷에 대한 접근 환경이 달라진 경우
	고위험상황	• 집에 혼자 있거나 방학이나 휴일 등 인터넷 의존의 위험이 증대되는 상황
	인터넷매개학습	• 인터넷을 통해 숙제를 하려다가 웹 강의를 듣는 등 인터넷 매개 학습의 경우
	가족문제	• 가족사의 부정적인 문제나 가족들이 스트레스원이 되어 인터넷상에서 도피처를 찾는 경우
인터넷 관련요인	콘텐츠자체의 매력	• 재미나 흥미, 호기심 등을 채워 주는 게임이나 각종 콘텐츠의 매력
	컴퓨터 관련 취미	• 홈페이지 만들기, 프로그래밍 등 컴퓨터나 인터넷 관련 취미 등
	다른 취미생활 통로	• 홈페이지를 통해 취미생활을 할 수 있는 경우, 예를 들어 연예인 팬클럽이나 축구 마니아 등
개인요인	성격적 특성	• 몰입하는 성격 등 개인의 성격적 측면
	대인관계문제	• 대인관계 실패나 문제 등
	보상경험	• 스트레스 해소, 현실도피, 재미없는 일상탈출 등이 인터넷에 빠져들게 만드는 경우

- ▶ 인터넷의 과다한 사용과 함께 나타나는 흔한 증상
 - 과도한 사용과 사용에 대한 집착
 - 시간 왜곡 경험, 1분만 더 증후군
 - 인터넷 활동에 대한 미련, 생각, 백일몽에 빠지기
 - 인터넷 활동을 방해받을 때 나타나는 짜증, 공격성
 - 인터넷에 필요한 활동을 하기 위한 준비에 시간을 들이는 것
 - 인터넷 활동에 필요한 돈이나 장비, 관련 물품을 과도하게 사들이는 것
 - 가족이나 친구들과의 만남을 줄이고, 외출을 꺼리기 시작하는 것
 - 인터넷 활동이 뜻대로 되지 않을 때 분노를 표출하고, 화풀이하는 것
 - 은어나 욕설의 사용이 늘고, 주변과 대화가 불편해진다고 느끼는 것
 - 인터넷에서 알게 된 사람 혹은 관계를 맺은 사람과 과도한 친분을 느끼는 것

- 본인 자신에 대하여 거짓말을 하거나 과장되어 표현하는 습관이 생기는 것
- 현실에서의 활동이 거추장스럽고 불편하다고 느끼는 것
- 속임수 거짓말 -> 도둑질, 지각, 결석 -> 과다한 사용 -> 반항, 불복종 -> 폭력, 욕설 -> 장기간의 가출, 장기간의 침거 -> 아이템 사기, 아이템 거래 -> 폐인, 통제 불가능 -> 죽음, 살인

▶ 온라인 게임 재미의 요인 구조

요인		문항
1차적 재미	현실감	1. 게임 속 상황이나 그래픽, 음향 등이 마치 게임 속에 들어와 있는 듯 생생한 느낌이 듦
		2. 이 게임은 캐릭터, 배경을 포함한 게임 화면의 움직임이 자연스러움
	조작 편리감	3. 나는 이 게임을 진행할 때 게임 조작과 관련되는 어려움이 적음
		4. 나는 이 게임과 관련된 규칙들을 쉽게 찾아낼 수 있음
		5. 다른 사람과 의견 교환을 할 수 있는 적절한 방법을 제공해 줌
2차적 재미	성취감	6. 게임에서 내가 새롭게 경험해 볼 것들이 많음
		7. 게임에서 주어지는 퀘스트를 꼭 해결하고 싶음
		8. 캐릭터, 아이템을 이용하여 내 마음에 맞는 다양한 전략을 사용할 수 있음
		9. 게임 내에서 내 레벨보다 높은 수준의 몹을 사냥하고 나면, 내가 최고가 된 느낌이 듦
3차적 재미	친밀감	10. 나는 이 집단에 속한 것이 자랑스러움
		11. 나는 이 집단 사람들과 헤어지고 싶지 않음
		12. 우리는 서로의 능력과 역할을 존중함
	공동체감	13. 우리는 공동의 적이 있음
		14. 우리는 남들과 분명히 다름
		15. 우리는 공동의 목표가 있음
	카타르시스적 재미	16. 초보들을 괴롭히는 것은 재미있음
		17. 이벤트 때나 공성 때는 놓치지 않고 먹자하러 감
		18. 필요하다면 먹자를 하거나 사기를 쳐도 됨
		19. 돈을 벌기 위해서는 구걸 같은 비굴한 행동을 할 수도 있음

- ▶ 인터넷 중독과 공존질환: 주의력결핍 과잉행동장애와 우울증이며, 이외에도 사회공포증이나 강박증 등도 언급되고 있음

- ▶ 과다한 스마트폰 사용자의 특징

- 인터넷 중독과 달리 남성보다는 여성에게 많은 것으로 나타나며, 여성들은 주로 social media 사용에 대한 문제가 있는 반면, 남성들은 스마트폰으로 게임을 하는 것이 더 심각한 것으로 널리 알려져 있음, 인터넷과 마찬가지로 여러 연령대에서 문제가 있지만 10대에서 주로 문제를 보이고 있음
- 어플리케이션을 이용 하여 측정한 결과 반복적으로 짧은 시간 동안 스마트폰을 사용하는(frequent shortperiod use) 스마트폰 중독군의 특성
- 여성, 낮은 연령대, 자기 조절 능력의 저하, 높은 충동성, 우울과 불안 증상 등

한국중독정신의학회, 『중독정신의학 2nd EDITION』, 2019)

(광주광역정신건강복지센터·중독포럼, 『중독문제에 대한 선별과 1회기 단기개입 매뉴얼』, 2018)

(한국도박문제예방치유원, 『도박문제 선별안내서(성인)』, 2023)

3. 정신심리·사회문화적 원인과 정신사회적 치료

가. 학습이론 모델

1) 고전적 조건화

- ▶ 최초에는 (반응과 무관했던) 중립적 자극이 짝지어 존재했던 (훈련과 관련 없이 반응을 유발하는) 무조건 자극과 궁극적으로 동일한 반응을 만들어내는 것
- ▶ 파블로(Ivan Pavlov)의 실험: 처음에는 개가 (무조건 자극인) 음식을 볼때만 (무조건 반응으로) 침을 흘림, 하지만 과정이 반복되면서 개는 (중립적 자극인) 종소리에 침을 흘리기 시작함, 이 경우에 (중립적 자극인) 종소리를 조건 자극이라 부르며 종소리에 침을 흘리는 반응을 조건 반응이라고 부름
- ▶ (불안이나 우울과 같은) 내적인 단서들과 (술병이나 주류 광고와 같은) 환경의 외적인 단서들이 고전적 조건화에 의하여 조건 자극으로 작용하여 경미한 물질 유발 효과들을 일으켜서 '갈망'이나 '금단 증상'을 유도한다는 것
- ▶ 특정 장소, 시간, 사람, 물건 등 중립 자극이 약물과 반복적으로 연합되면, 이후 조건 자극만으로도 갈망, 불안, 자극 등에 대한 생리적 반응이 유발

2) 조작적 조건화

- ▶ 스키너(Burrhus Skinner)에 의해 발전된 이론으로, 긍정적인 결과를 가져오는 행동은 계속 수행하고, 부정적 결과를 낳는 행동은 회피하도록 학습될 때 이루어짐

• 그는 지렛대를 누르면 먹이가 나오도록 고안된 스키너 상자를 이용하여 조작적 조건화의 효과를 입증함, 스키너 상자 안의 쥐는 우연히 지렛대를 누른 후 먹이(보상)가 나오는 것을 보고 지렛대를 누르는 행동을 자주 하게 됨, 이런 과정이 반복되면서 쥐는 지렛대를 누르면 먹이가 나온다는 사실을 학습하게 됨

- ▶ 강화의 유형:

• 긍정적 강화: 약물 복용 후 기분이 좋아지는 경험 -> 복용 행동 증가
 • 부정적 강화: 금단증상을 없애기 위해 약물을 사용 -> 사용 행동 강화

- ▶ 중독 환자가 중독 때문에 발생한 신체적 및 사회적 문제들을 깨닫고 후회하면서 앞으로는 단주 혹은 단약을 하겠다고 맹세하더라도 물질사용을 유발시키는 (예를 들어 친구와 만남, 가족과 다툼 등 같은) 단서에 노출되면 다시 술을 마시거나 약물을 사용하게 될 가능성은 매우 높아짐

3) 사회학습이론

- ▶ 자극과 강화인에 의한 조건화를 통해서 기대와 각종 인지들이 발생하며, 반대로 이런 기대와 각종 인지들은 자극에 대한 반응, 행동, 결과에 영향을 미친다는 것이 사회학습 이론의 기본적 전제
- ▶ 모델링을 통해 학습이 이루어지며, 자극이나 강화인에 의한 학습이 개인의 인지적 통제 아래에서 이루어진다는 점을 강조
- ▶ 자극이나 (정적 및 부정) 강화인에 대한 반응은 인지에 의해서 매개 되며, 인지의 변화에 의해서 수정될 수 있다는 것
- ▶ 인식하고 행동하는 개인을 주변 환경의 피동적 희생자가 아니라 학습과정의 능동적 참여자라고 보는 것
- ▶ 알코올중독자가 심한 음주 갈망을 거부할 수 없는 '압도적 요구'로 받아들이는 대신에 스쳐가는 '파도의 최고점'이라고 인지를 변화시킴으로써 시간이 흐르면 사라질 것이라는 기대를 가질 수 있다는 것
- ▶ 자기관찰과 자기-평가, 자기보상과 자기-처벌, 책임과 통제에 대한 지각, 기대 등과 같은 인지적 요소들이 중독의 발생과 치료에 미치는 영향을 강조
- ▶ 어떤 결정적 사건에 의해서 활성화된 핵심적 믿음(core belief)은 예기 믿음(anticipatory belief)을 만들고, 이것은 다시 갈망(craving)을 만들, 갈망은 중독자에게 허용 믿음(permissive belief)을 활성화시켜서 탐닉(indulge)에 빠져들게 하고, 이런 과정이 중독 행위를 유도

• (통제력을 잃었다고 믿는) 학습된 무기력이나 (재발되어서 모든 것이 수포로 돌아갔다고 생각하는) 단주위반 효과도 인지적 개념에서 도입

나. 정신역동 이론

- ▶ 정신역동 이론은 프로이트(Sigmund Freud)의 정신분석 이론을 근간으로 함
- ▶ 프로이트의 초기 이론에서는 신체 성감대가 자극되거나 외부 성적 자극에 의해 생기는 성적 욕동을 강조, 성적 욕동이 강력한 추진력으로 작동하여 성적 소망을 달성하려고 하며 이를 제어하는 것이 심리구조의 주된 기능이라고 봄
- ▶ 한편 성적 욕동(리비도(libido))과 이를 제어하려는 힘들은 자신이 모르는 상태에서 작동되는 경우가 많은데, 이런 현상을 프로이트는 무의식 상태에서 일어나기 때문이라고 설명
- ▶ 마음을 현재 의식해서 알고 있는 '의식계'와 주의집중을 하면 알 수 있는 '전의식계', 아무리 의식으로 알아내려고 해도 알 수 없는 '무의식계'로 구분
 - '무의식계'는 현실적 논리와 상관없이 본능적 욕구를 충족시키려는 '쾌락원칙'에 따라 작동하는 반면, '전의식계'와 '의식계'는 현실을 고려하여 논리적으로 판단하는 '현실원칙'에 따라 작동한다고 주장
- ▶ 무의식적 갈등이나 죄책감을 설명하기 위하여 '자아(ego)', '초자아(superego)', '이드(id)'라는 심리적 구조물을 제안, 여기에서 '자아'는 각종 방어기제를 포함하여 심리현상을 종합하는 기관이며, 증상은 이들 세 기관 사이의 타협형성이라고 보았음
- ▶ 마음은 태어나 성장하는 동안에 신체적 성감대를 중심으로 전오이디푸스기(preoedipal phase)와 오이디푸스기(oedipal phase)의 여러 발달단계를 거치면서 발달
- ▶ 이 과정에서 각각의 발달단계를 적절하게 보내지 못했을 경우에는 성적 욕동이 그 단계에 그대로 머무르는 고착(fixation)이 일어난다고 주장
 - 출생 직후부터 1년 반까지의 전오이디푸스기를 '구강기'라고 하는데, 프로이트는 이 시기에 고착되면 음주나 흡연에 대한 갈망을 일으킨다고 봄
- ▶ 중독이나 알코올중독은 병적인 습관이며, 중독에 대한 진정한 치유는 불가능하다고 주장함
- ▶ 근래에 들어 중독에 대한 정신분석적 이해가 진전되면서 중독은 주로 자아 기능의 문제 때문에 발생하며 정신분석적 치료를 고려할만한 상태라는 관점으로 시각이 현저히 변화

다. 동기강화 치료

- ▶ 저항을 느끼지 않게 하고 어려움을 공감해 주며 그들 자신의 자존심을 유지 하면서 적극적인 참여가 유도되는 좀 더 자발적이고 허용적인 치료 프로그램 개발의 필요성이 생겼고, 바로 이런 필요성에 의해 개발된 것
- ▶ 동기강화치료는 물질사용장애 환자들에게 변화를 일으키는 체계적인 치료적 개입 접근법
- ▶ 동기강화심리학의 원칙에 기초하며 환자에게 신속하고 내적으로 동기부여된 변화를 스스로 만들어 내도록 고안
- ▶ 이런 치료 전략은 조금씩 치료와 회복 과정을 통하여 환자가 치료자에 의해 지도되고 훈련되도록 하는 것이 아니라 그 대신, 환자 내부의 변화 가능한 잠재 자원이 스스로 발휘되도록 하는 특별한 치료적 동기유발 전략

- ▶ 동기강화치료는 치료과정에서 과도한 개입을 하지 않으며 치료자의 개입은 최소한으로 제한
- ▶ 변화의 단계

- 문제행동의 변화를 고려하지 않는 사람들을 심사숙고 전의 사람들(Precontemplators)
- 심사숙고(Contemplation) 단계는 개인이 그들이 문제가 있음과 그 행동 변화의 가능성과 비용을 모두 고려하기 시작함을 의미
- 변화의 진행에 따라 행동을 취하고 변화를 시도하는 결정(Determination) 단계
- 일단 개인이 문제행동에서 변화하기 시작하면, 정상적으로 3개월 내지 6개월 동안 지속되는 행동(Action) 단계
- 성공적으로 행동 단계에 진입한 후, 개인은 유지(Maintenance) 혹은 지속적인 변화 단계
- 이런 노력이 실패하면, 재발(Relapse)이 일어나고 그 사람은 다시 처음부터 순환을 시작

- ▶ 밀러(Miller)와 롤닉(Rollnick)의 치료적 접근에 기초한 다섯 가지의 기본적인 동기유발의 원칙



라. 인지행동 치료

- ▶ 사람의 생각과 행동에 중점을 두는 정신치료
- ▶ 생각, 즉 인지과정을 주로 다루는 것도 있고 행동과정에 주된 관심을 두는 것도 있으며 인지와 행동 두 과정에 똑같이 관심을 두는 것도 있음
- ▶ 치료자가 적극적이고, 대상자와의 상호협력을 중요하게 생각하며, 치료 형식이 구조화되어 있으며, 현재 중심적이며, 특정 의제를 집중적으로 다루는 치료 방법
- ▶ 물질 사용 장애에 대한 정신치료 방법 중의 하나로 다음과 같은 특징이 있음

첫째	알코올, 코카인 등의 정신자극제, 마리화나, 아편계 약물 등 다양한 물질의 사용 장애에 적용할 수가 있음
둘째	인지행동적인 접근방식은 인간행동에 대한 확립된 이론과 원칙을 바탕으로 발달하여 왔음
셋째	이러한 접근방식은 다양한 임상적인 상황에서 적용할 수 있고, 또한 약물치료와 병행가능하며, 많은 경우에서 약물에 대한 순응과 효과를 향상 시킴
인지행동치료는 비교적 단기간에, 물질 사용과 이와 관련된 문제에 대한 변화를 강조하는 집중적인 접근방식	

1) 행동학습이론

- ▶ 행동학습이론에 의하면 특정 행동에 대한 정교한 보상경험을 통하여 인간의 행동이 학습되고 형성될 뿐만 아니라 또한 문제가 되는 행동을 학습을 통하여 개선할 수도 있음
- ▶ 물질사용의 행동학습이론에 따르면 물질사용을 학습하고 문제성 물질사용 행동을 형성하는 직접적, 간접적인 다양한 방법이 있음을 암시함
- ▶ 치료의 일차적인 목표는 낱고 부적응적인 행동을 탈학습화하고 보다 적응적인 행동을 배우도록 환자를 돕는 것

2) 인지치료이론

- ▶ 물질사용이 주로 그 물질과 관련된 자동사고(automatic thought), 물질과 관련된 촉진믿음(facilitating belief), 그리고 핵심믿음(core belief)에 의한, 다양하고 복잡한 행동을 포함한다는 전제를 기초로 함
- ▶ 복잡한 행동에는 물질을 손에 넣어 사용하는 행동뿐만 아니라 물질 사용으로 인한 부정적인 결과를 피하기 위한 행동도 포함
- ▶ 물질과 관련된 믿음은 지속적인 금단의 결과에 대한 부정적인 믿음뿐만 아니라 물질의 효과에 대한 긍정적인(기대하는) 믿음도 있음
- ▶ 자동사고란 마음속에 의식적인 노력 없이 자동적으로 떠오르는 한 순간의 짧은 생각, 마치 영화의 한 장면처럼 선명한 시각적인 모습으로 나타나기도 함
- ▶ 촉진 믿음이란 금단을 결심한 후에 다시 물질을 하도록 허용해 주는 믿음을 말함
- ▶ 인지 치료에 의하면 물질사용은 물질에 대한 충동을 활성화시키는 자극에 의하여 유발(활성화 시키는 자극은 내적 자극과 외적 자극으로 분류)

- 내적인 단서는 부정적인 감정(예, 불안, 지겨움), 긍정적인 감정(예, 즐거움, 흥분), 과거의 중요한 기억(예, 학대받던 상황에 대한 회상) 그리고 생리적 감각(예, 신체 통증, 금단증상) 등
- 외적인 단서의 예는 대인관계 갈등, 시각 및 청각(예, 맥주캔을 따는 것을 보거나 그 소리를 들음), 다른 물질남용자, 직장과 학교에서의 문제, 축하시간(예, 기념일, 생일) 등

마. 마인드풀니스(Mindfulness)치료

- ▶ 마인드풀니스(Mindfulness)는 팔리어(Pali)의 사띠(sati)를 영문으로 번역한 단어인데, 그것은 자각(awareness), 주의(attention), 그리고 기억하기(remembering)라는 의미를 내포
- ▶ 그것은 주의를 기울이고 자각하는 것을 계속해서 기억하는 것을 의미, 이를 우리말로로는 주로 '마음챙김'이라고 번역
- ▶ 가장 널리 사용되는 정의는 '순간순간의 경험에 대해, 의도적으로, 비 판단적으로 주의를 기울임으로써 나타나는 자각(알아차림)'
- ▶ 의도하지 않을 때 우리의 주의를 자동적, 무의식적, 반사적으로, 내부와 외부의 유쾌하거나 좋아하는 대상으로 끌려가고, 불쾌하거나 혐오하는 대상에서 달아남 -> 자동조종반응(automatic pilot) 이라고 함
- ▶ 마인드풀니스는 매순간 어떠한 대상에 대해서 든지 그것을 좋아하거나 싫어하는 것으로 구별하여 판단하지 않고(nonjudgmentally) 의식적으로 주의를 기울여서 수용하면서 자각하는 것

(한국중독정신의학회, 『중독정신의학 2nd EDITION』, 2019)



4. 단기개입 (SBIRT: Screening Brief Intervention Referral Treatment)

가. 성인

1) 담배·알코올 및 약물

▶ 담배·알코올 및 약물사용의 선별 및 단기개입 개념

- 일차의료 시스템의 보건의료 실무자, 지역사회 센터 실무자 등이 담배·알코올 및 약물사용 문제를 가진 대상자를 조기선별하고 단기개입 기능을 수행하도록 하기 위해 개발
- 음주, 흡연, 약물 사용의 선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문치료 연결의 일련의 과정
- 수행하는데 대략 30~40분 정도 걸림
- 일반상담, 과거력, 병력 조사와 병행해서 시행가능

▶ 담배·알코올 및 약물사용의 선별 및 단기개입은 어디서, 누가 해야 하는가?

일반적 원칙		구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 센터 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의료 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자

▶ 담배·알코올 및 약물사용의 선별 및 단기개입의 대상자

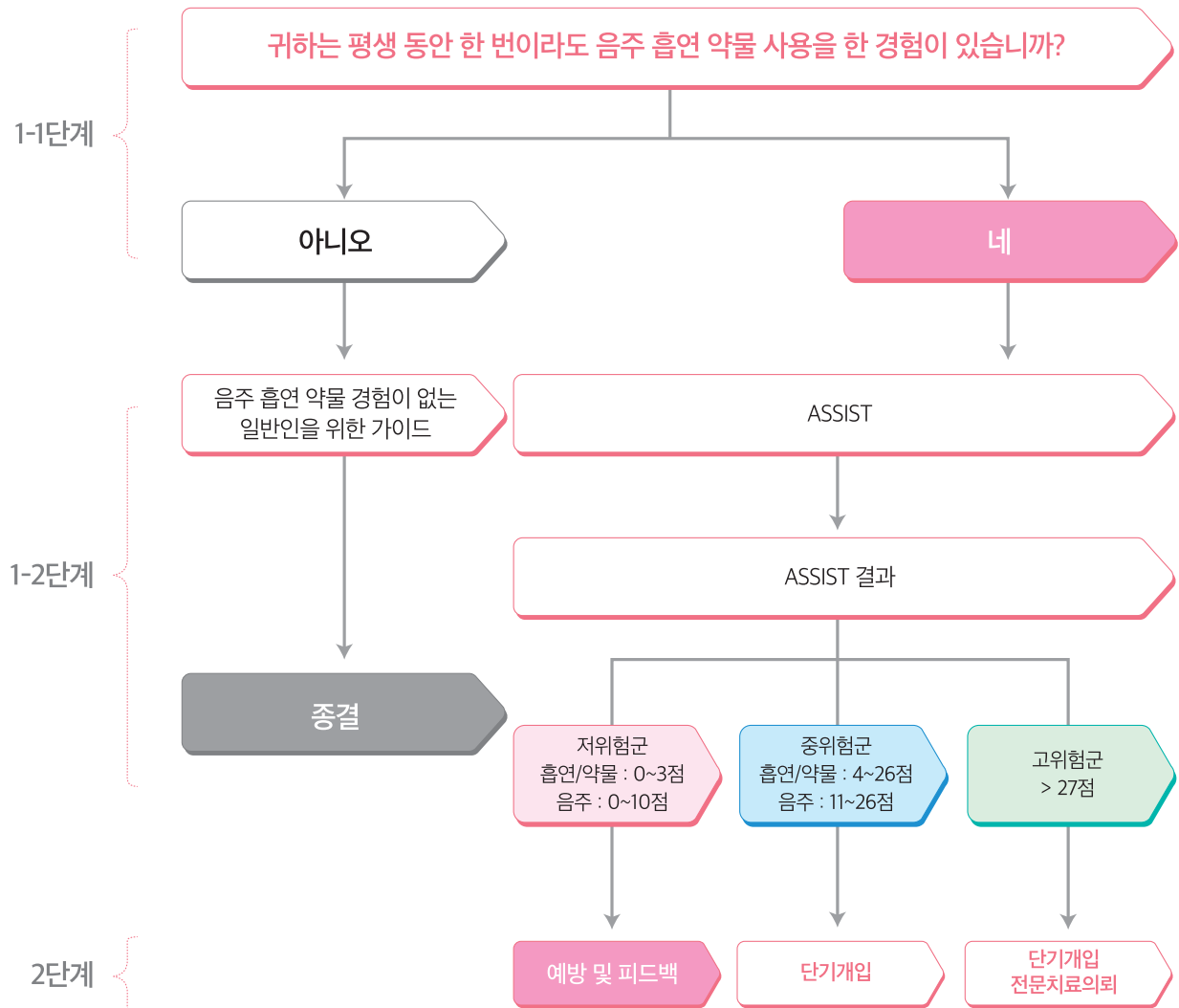
- 18세 이상의 모든 성인
- 음주 흡연 약물사용의 가능성이나 위험성이 있을 수 있는 대상 -> 대학생, 직장인, 일반인, 임산부 등
- 음주 흡연 약물사용 문제에 대해 상담을 원하는 사람 모두
- 교정시설 혹은 보호관찰소의 알코올 및 약물 관련 범죄자
- 약물에 취해 있지 않아야 하며 응급상황 및 금단증상 기간이 지난 대상자

▶ 담배·알코올 및 약물사용의 선별 및 단기개입의 대상약물

- 알코올, 담배, 대마초, 코카인, 암페타민(필로폰), 진정수면제, 환각제, 흡입제, 아편제제 등이며 이 외 기타 습관성 약물 또한 포함



담배·알코올 및 약물사용의 선별 및 단기개입 전체과정 한 눈에 보기



2) 음주

▶ 문제성 음주의 선별 및 단기개입 개념

- 일차의료 시스템의 보건의료 종사자들과 조기선별·개입기능을 수행하는 중독관련 전문기관을 위해 개발
- 문제성 음주의 선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문치료 연결의 일련의 과정
- 수행하는데 대략 10~20분(초단기개입) 부터 30~40분(단기개입) 정도 소요

▶ 문제성 음주의 선별 및 단기개입은 어디서, 누가 해야 하는가?

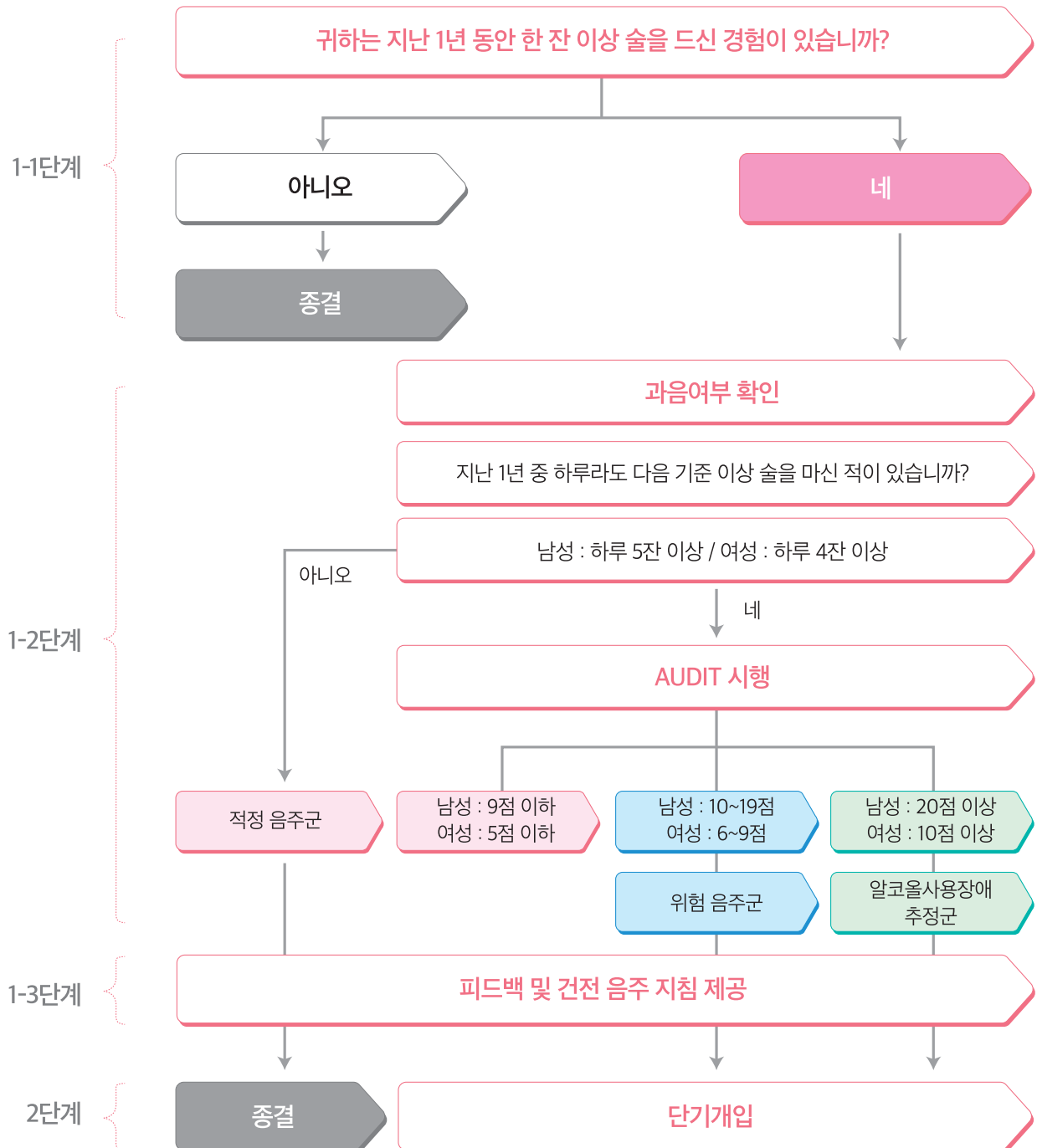
일반적 원칙		구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 센터 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의료 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자

▶ 문제성 음주의 선별 및 단기개입의 대상자

- 18세 이상의 모든 성인
- 음주 행동의 가능성이나 위험성이 있을 수 있는 대상 모두(대학생, 직장인, 일반인 등)
- 음주 문제에 대해 상담을 원하는 사람 모두



문제성 음주의 선별 및 단기개입 전체과정 한 눈에 보기



3) 문제성 도박

▶ 문제성 도박의 선별 및 단기개입 개념

- 일차의료 시스템의 보건의로 실무자, 지역사회 센터 실무자 등이 도박문제를 가진 대상자를 조기선별하고 단기개입 기능을 수행하도록 하기 위해 개발
- 문제성 도박의 선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문치료 연결의 일련의 과정
- 수행하는데 대략 30~40분 정도 소요

▶ 문제성 도박의 선별 및 단기개입은 어디서, 누가 해야 하는가?

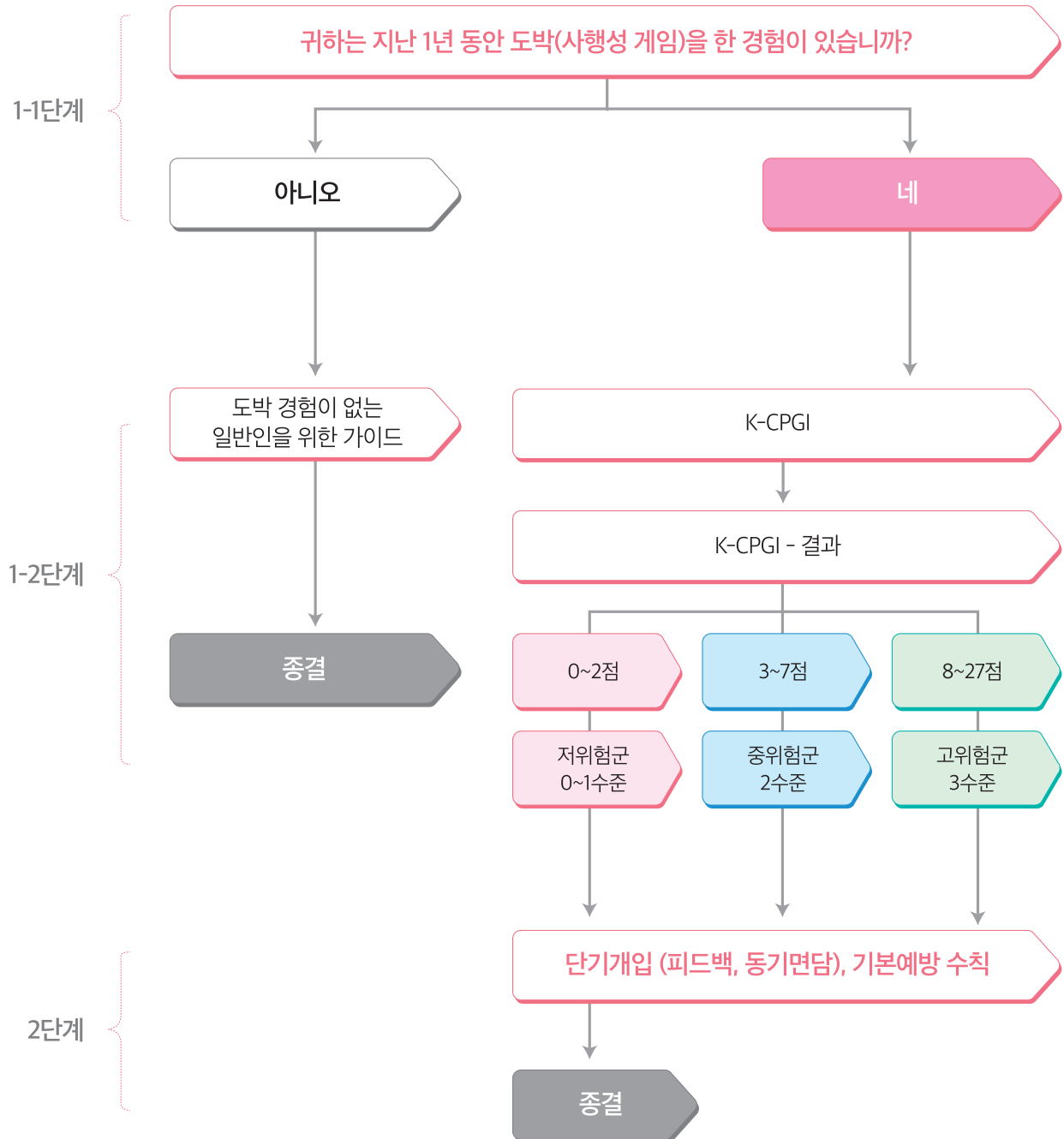
	일반적 원칙	구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 센터 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의로 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자

▶ 문제성 도박의 선별 및 단기개입의 대상자

- 18세 이상의 모든 성인
- 도박 행동의 가능성이나 위험성이 있을 수 있는 대상 모두 -> 대학생, 직장인, 일반인 등
- 도박 문제에 대해 상담을 원하는 사람 모두



문제성 도박의 선별 및 단기개입 전체과정 한 눈에 보기



나. 청소년

1) 음주

▶ 청소년 음주의 선별 및 단기개입 개념

- 일차의료 시스템의 보건의료 실무자, 지역사회 센터 실무자 등이 음주문제를 가진 청소년을 조기선별하고 단기개입 기능을 수행하도록 하기 위해 개발
- 알코올 사용 위험 청소년군에 대한 조기 개입 및 치료제공을 위한 종합적인 접근방법
- 청소년 문제성 음주의 선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문치료 연결의 일련의 과정
- 수행하는데 대략 30~40분 정도 소요됨

▶ 청소년 음주의 선별 및 단기개입은 어디서, 누가 해야 하는가?

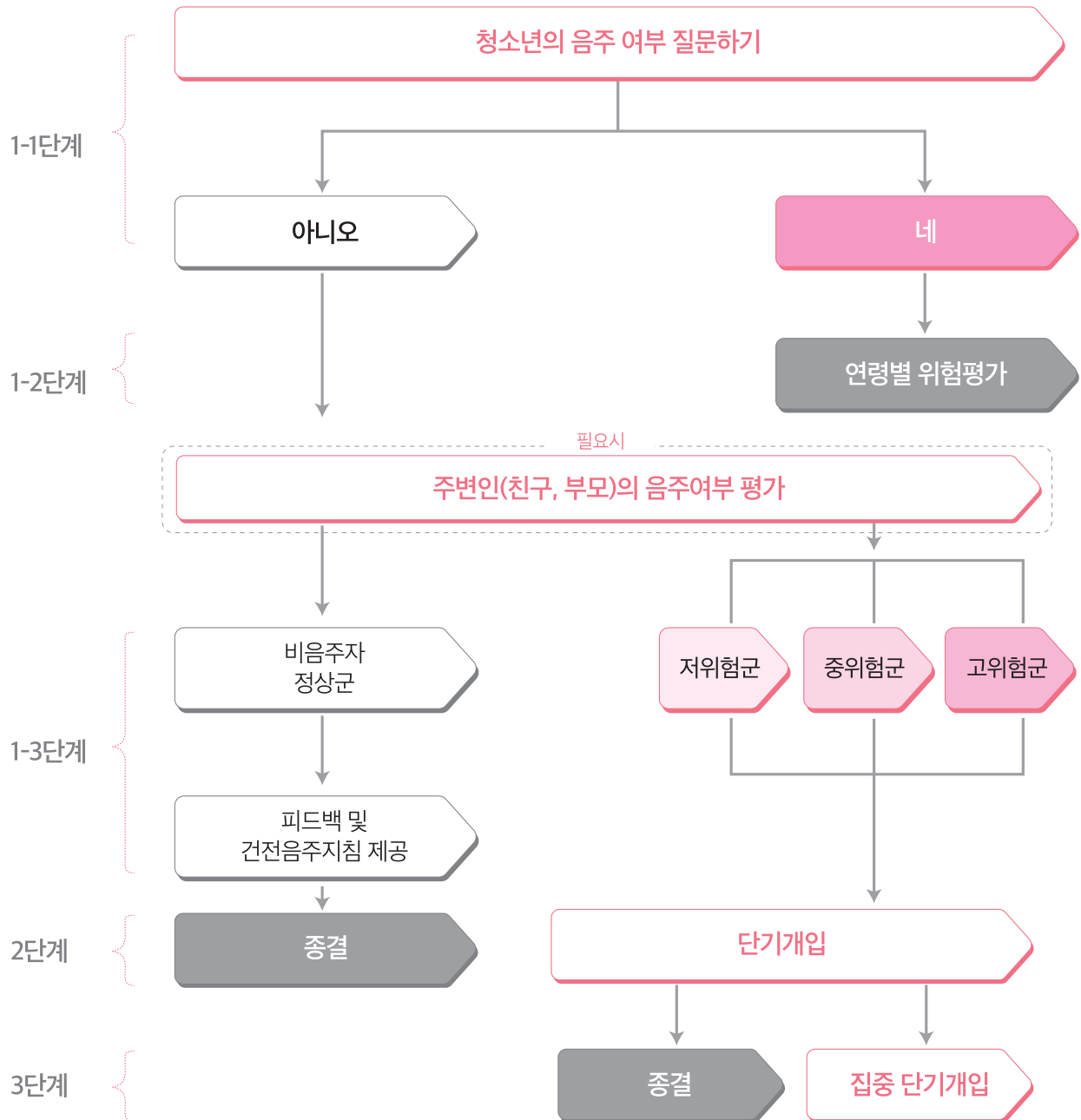
	일반적 원칙	구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 센터 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의료 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자

▶ 청소년 음주의 선별 및 단기개입의 대상자

- 음주 행동의 가능성이나 위험성이 있을 수 있는 청소년 모두 -> 초, 중, 고등학생
- 음주 문제에 대해 상담을 원하는 청소년 모두



청소년 문제성 음주의 선별 및 단기개입 전체과정 한 눈에 보기



2) 인터넷/게임중독

▶ 인터넷/게임중독 고위험군 선별 및 단기개입 개념

- 일차의료 시스템의 보건의료 실무자, 지역사회 센터 실무자 등이 인터넷/게임중독 문제를 가진 청소년을 조기선별하고 단기개입 기능을 수행하도록 하기 위해 개발
- 인터넷/게임중독 고위험군의 선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문치료 연결의 일련의 과정
- 수행하는데 대략 20~50분정도 걸림

▶ 인터넷/게임중독 고위험군 선별 및 단기개입은 어디서, 누가 해야 하는가?

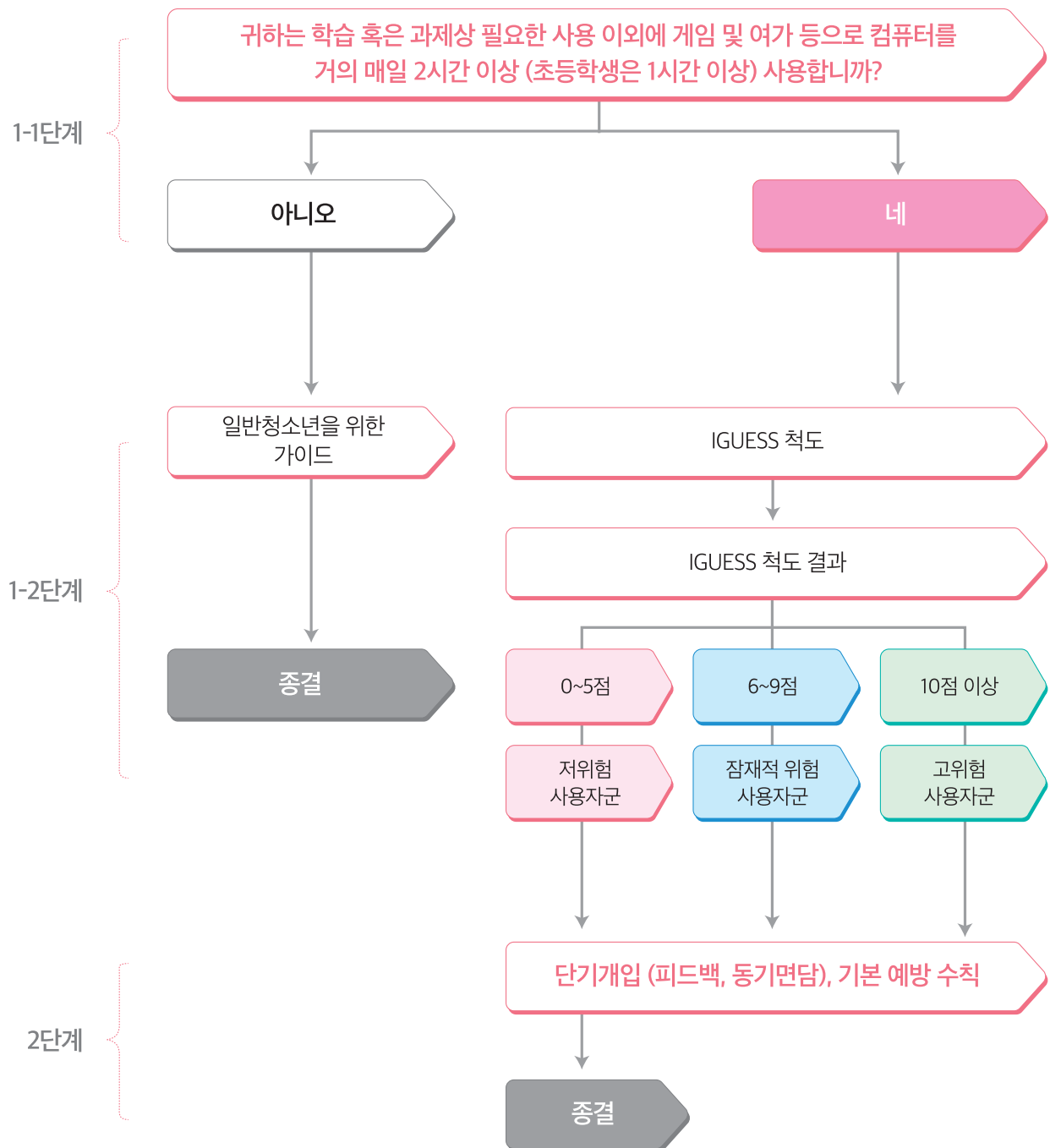
	일반적 원칙	구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 센터 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의료 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자

▶ 인터넷/게임중독 고위험군 선별 및 단기개입의 대상자

- 인터넷/게임 중독의 가능성이나 위험성이 있을 수 있는 청소년(만10~19세)
- 인터넷/게임 문제에 대해 상담을 원하는 사람 모두



인터넷/게임중독 고위험군 선별 및 단기개입 전체과정 한 눈에 보기



3) 도박

▶ K-SBIRT-AG의 개념

(Korean-Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment-Adolescent Online Gambling)

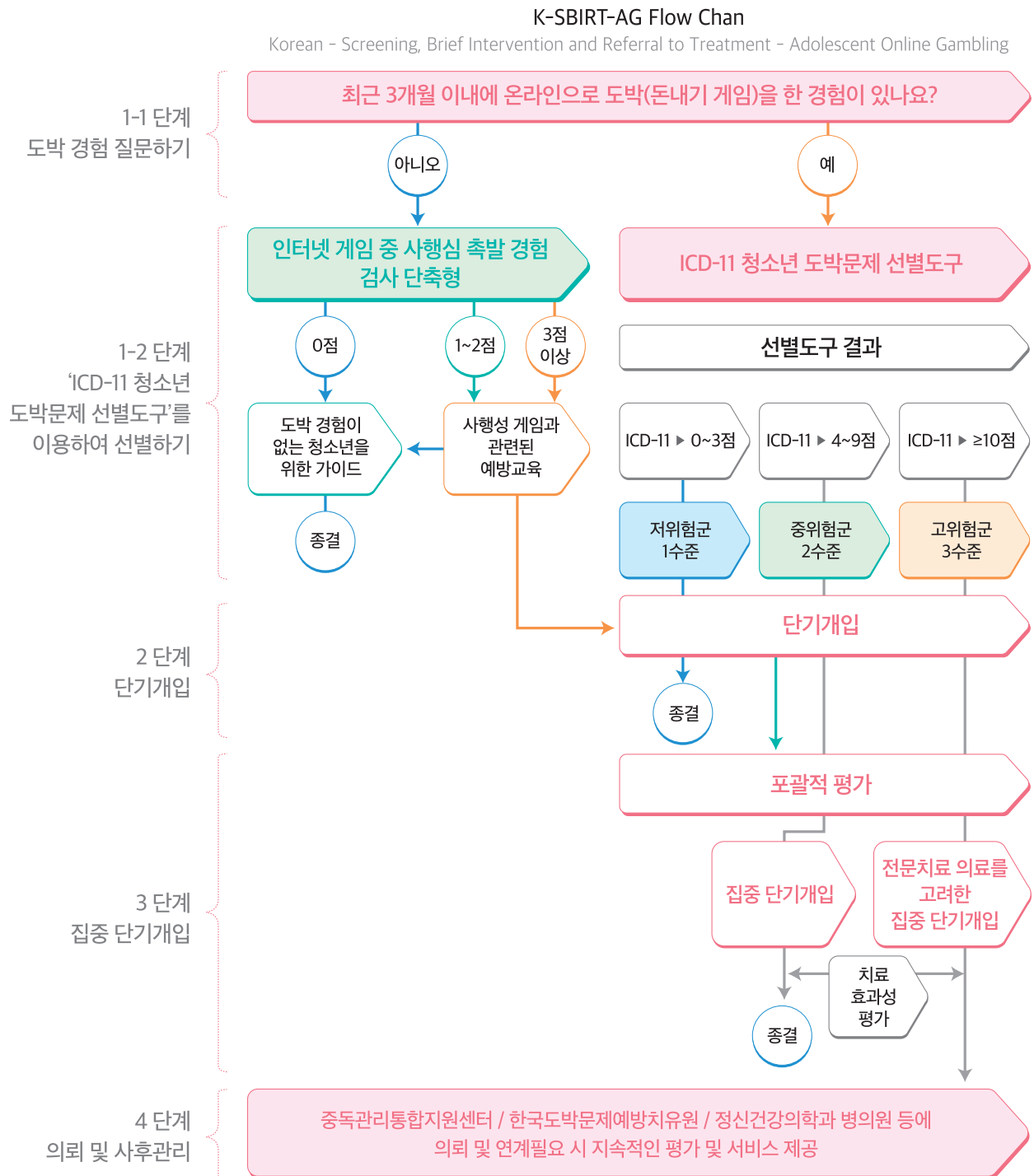
- 청소년 온라인 도박 위험군의 조기개입 및 치료 서비스를 제공하는 포괄적이고 통합적인 공중보건 접근방법
- 청소년 온라인 도박 문제에 대한 '선별 -> 단기개입 -> 의뢰 -> 전문 치료 연결'의 일련의 과정
- 청소년 중독문제의 조기 선별과 개입기능을 수행하는 일차보건의료 종사자 및 중독관련 전문기관 실무자를 위해 개발
- 수행 시간은 개입 종류에 따라 약 10~20분(초단기개입) 부터 30~40분(단기개입) 정도 소요
- 일반상담, 과거력, 병력 조사를 병행하여 시행 가능

▶ K-SBIRT-AG를 어디서, 누가, 누구에게 해야 하는가?(K-SBIRT-AG의 수행 원칙)

일반적 원칙		구체적 수행원칙
어디서	어디서나	일차 의료기관 지역사회 서비스 기관 아웃리치
누가	기본적인 교육을 받은 실무자	일차 보건의료 실무자 지역사회 실무자 중독관련 실무자
대상자	18세 이하의 모든 청소년	온라인 도박 가능성/위험성이 있는 모든 청소년 온라인 도박 문제에 대해 상담을 원하는 청소년



K-SBIRT-AG의 전체과정 한 눈에 보기



(광주광역시정신건강복지센터·중독포럼, 『중독문제에 대한 선별과 1회기 단기개입 매뉴얼』, 2018)

(국립정신건강센터, 『한국형-청소년 온라인 도박의 선별과 단기개입』, 2024)

5. 중독관련 정신건강 검진도구 및 사용

가. 중독관련 검진도구

1) 한국어판 위험 음주자 선별도구 (AUDIT-K)

한국어판 위험 음주자 선별도구 (AUDIT-K)

이름(성별)		생년월일		실시일	
--------	--	------	--	-----	--

다음의 각 문장을 읽고, 자신에게 알맞은 답변에 체크표시 ✓해 주시기 바랍니다.

문 항		0점	1점	2점	3점	4점
1	술을 얼마나 자주 마십니까?	전혀 마시지 않는다	한달에 한번 미만	한달에 2~4회	1주일에 2~3회	1주일에 4회 이상
2	평소 술을 마시는 날 몇잔 정도나 마십니까?	1~2잔	3~4잔	5~6잔	7~9잔	10잔 이상
3	한번 술을 마실 때 소주 1병 또는 맥주 4병 이상의 음주는 얼마나 자주 하십니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
4	지난 1년간 술을 한번 마시기 시작하면 멈출 수 없다는 것을 안 때가 얼마나 자주 있었습니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
5	지난 1년간 당신은 평소 같으면 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
6	지난 1년간 술을 마신 다음날 아침에 일 나가기 위해 다시 해장술을 필요했던 적이 얼마나 자주 있었습니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
7	지난 1년간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
8	지난 1년간 음주 때문에 전날 밤에 있었던 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까?	전혀 없다	한달에 1번 미만	한달에 한번	일주일에 한번	매일같이
9	음주로 인해 자신이나 다른 사람이 다친 적이 있었습니까?	없었다	있지만, 지난 1년간에는 없었다 (2점)		지난 1년간 있었다 (4점)	
10	친척이나 친구, 또는 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 술꾼기를 권유한 적이 있습니까?	전혀 없다	있지만, 지난 1년간에는 없었다 (2점)		지난 1년간 있었다 (4점)	
각 칸별로 점수를 더해주세요						
총점						

척도명	Alcohol Use Disorder Identification Test-Korean : AUDIT-K																										
출처	조근호, 채숙희, 박애란, 이해국, 신임희, 민성호(2009). 위험 음주자의 선별을 위한 한국어판 Alcohol Use Disorders Identification Test(AUDIT-K)의 최적 절단값. J. Korean Academy of Addiction Psychiatry, 13(1), 34-40																										
결과해석	<table border="1"> <thead> <tr> <th>성 별</th><th>점 수</th><th>분 류</th><th>설명예시</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">남</td><td>0-9</td><td>정상음주</td><td>'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음</td></tr> <tr> <td>10-19</td><td>위험음주</td><td>'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요</td></tr> <tr> <td>20 이상</td><td>알코올 사용 장애</td><td>알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요</td></tr> <tr> <td rowspan="3">여</td><td>0-5</td><td>정상음주</td><td>'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음</td></tr> <tr> <td>6-9</td><td>위험음주</td><td>'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요</td></tr> <tr> <td>10 이상</td><td>알코올 사용 장애</td><td>알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요</td></tr> </tbody> </table>			성 별	점 수	분 류	설명예시	남	0-9	정상음주	'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음	10-19	위험음주	'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요	20 이상	알코올 사용 장애	알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요	여	0-5	정상음주	'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음	6-9	위험음주	'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요	10 이상	알코올 사용 장애	알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요
성 별	점 수	분 류	설명예시																								
남	0-9	정상음주	'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음																								
	10-19	위험음주	'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요																								
	20 이상	알코올 사용 장애	알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요																								
여	0-5	정상음주	'정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있음																								
	6-9	위험음주	'위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요																								
	10 이상	알코올 사용 장애	알코올 사용 장애 진단척도 결과, '사용 장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요																								
저작권	• 저작권: Thomas Babor & WHO • 2차: 조근호																										

2) 인터넷게임중독선별도구(IGUESS)

인터넷게임중독선별도구 (IGUESS)

성 별	남 여	연 령		실시일	
-----	----------	-----	--	-----	--

지난 12개월 동안, 인터넷게임과 관련하여 아래의 증상을 얼마나 경험하였습니까?

문 항		전혀 아님	가끔	자주	항상
1	이전에 했던 인터넷게임에 대해 계속 생각하거나, 인터넷게임을 할 생각에 몰두했다.	0	1	2	3
2	인터넷게임을 하지 않을 때에는 초조하거나 불안하거나 슬프다.	0	1	2	3
3	인터넷게임에 쓰는 시간이 점점 길어진다.	0	1	2	3
4	인터넷게임을 하는 것을 조절하려고 해보았지만 성공하지 못했다.	0	1	2	3
5	인터넷게임으로 인해 예전의 다른 취미 생활이나 오락 활동에 대한 흥미가 줄어들었다.	0	1	2	3
6	사회적, 심리적 문제에도 불구하고 계속해서 인터넷게임을 과하게 한다.	0	1	2	3
7	가족이나 치료자, 또는 그 외의 사람에게 인터넷게임을 하는 데 사용한 시간을 속인 적이 있다.	0	1	2	3
8	부정적인 감정을 해소하거나 회피하기 위해 인터넷게임을 한다.	0	1	2	3
9	과도한 인터넷게임으로 인해 중요한 인간관계, 일, 교육이나 경력상의 기회를 위태롭게 하거나 잃은 적이 있다.	0	1	2	3
각 칸별로 점수를 더해주세요					
총점					

척도명	Internet Gaming Use-Elicited Symptom Screen (IGUESS)						
출처	조선진, 이해국, 임현우, 조근호, 최삼욱, 오홍석. 중독 선별검사 도구 및 사용지침 개발. 2013, 가톨릭대학교, 한국건강증진재단.						
결과해석	- IGUESS는 지역사회 및 일차의료기관에서 인터넷게임 사용과 관련된 장애를 선별하기 위해, DSM-5의 진단 준거를 근거로 국내에서 개발된 도구 10점 이상이면 인터넷·게임 사용관련 장애의 가능성이 있음을 의미 <table border="1"> <thead> <tr> <th>점 수</th><th>설 명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~9</td><td>인터넷게임 사용 관련 장애가 있을 가능성이 낮음. 계속하여 건강한 습관을 영위할 것</td></tr> <tr> <td>10~27</td><td>선별검사 결과 양성이라고 하여 모두 인터넷게임 사용 관련 장애가 있는 것을 뜻하는 것은 아니나, 추가적인 검사를 통해 인터넷게임 사용관련 장애가 있는지를 확인해 보아야 함을 의미</td></tr> </tbody> </table> - 추가적인 검사로 KS-A와 KS-II를 사용하여 개입 여부 및 유형 결정 - 보다 정확한 진단을 위해 인터넷, 게임, SNS 중독 면담(Diagnostic Interview for Internet, game, SNS, and etc., Addiction 2.0: 이하 DIA 2.0)도구가 있음, DIA 2.0은 DSM-5 진단 기준에 '갈망'을 추가하여 구성, 보호자와 대상자 면접을 통해 중독 여부 진단, 실시를 위해서는 일정훈련이 요구됨, DIA 2.0에 대한 자세한 정보는 가톨릭대학교 산학협력단과 보건복지부가 개발한 [인터넷·게임·스마트폰중독(사용문제)에 대한 예방/치료/사후관리 서비스 제공 안내서 2015] 참조	점 수	설 명	0~9	인터넷게임 사용 관련 장애가 있을 가능성이 낮음. 계속하여 건강한 습관을 영위할 것	10~27	선별검사 결과 양성이라고 하여 모두 인터넷게임 사용 관련 장애가 있는 것을 뜻하는 것은 아니나, 추가적인 검사를 통해 인터넷게임 사용관련 장애가 있는지를 확인해 보아야 함을 의미
점 수	설 명						
0~9	인터넷게임 사용 관련 장애가 있을 가능성이 낮음. 계속하여 건강한 습관을 영위할 것						
10~27	선별검사 결과 양성이라고 하여 모두 인터넷게임 사용 관련 장애가 있는 것을 뜻하는 것은 아니나, 추가적인 검사를 통해 인터넷게임 사용관련 장애가 있는지를 확인해 보아야 함을 의미						
저작권	- 개발자 : 조선진, 이해국 등 - 저작권 : 조선진, 이해국 등/한국건강증진개발원						

3) 스마트폰 과의존 성인·고령층 척도

스마트폰 과의존 성인·고령층

성 별	남	여	연 령		실시일			
문 항					전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1	스마트폰 이용시간을 줄이려 할 때마다 실패한다.				1	2	3	4
2	스마트폰 이용시간을 조절 하는 것이 어렵다.				1	2	3	4
3	적절한 스마트폰 이용시간을 지키는 것이 어렵다.				1	2	3	4
4	스마트폰이 옆에 있으면 다른 일에 집중하기 어렵다.				1	2	3	4
5	스마트폰 생각이 머리에서 떠나지 않는다.				1	2	3	4
6	스마트폰을 이용하고 싶은 충동을 강하게 느낀다.				1	2	3	4
7	스마트폰 이용 때문에 건강에 문제가 생긴 적이 있다.				1	2	3	4
8	스마트폰 이용 때문에 가족과 심하게 다툰 적이 있다.				1	2	3	4
9	스마트폰 이용 때문에 친구 혹은 동료, 사회적 관계에서 심한 갈등을 경험한 적이 있다.				1	2	3	4
10	스마트폰 때문에 업무(학업 혹은 직업 등) 수행에 어려움이 있다.				1	2	3	4
각 칸별로 점수를 더해주세요								
총점								

척도명	스마트폰 과의존 성인·고령층 척도			
출처	한국정보화진흥원(2016), 2016년 인터넷 과의존 실태조사 최종보고서			
결과해석	채점 방법	[1단계] 문항별	전혀 그렇지 않다: 1점, 그렇지 않다: 2점, 그렇다: 3점, 매우, 그렇다: 4점	
		[2단계] 총점	문항 1~10번 합계	
		[참고] 요인별	1 요인 조절실패: 문항 1~3번 합계 2 요인 현저성: 문항 4~6번 합계 3 요인 문제적 결과: 문항 7~10번 합계	
	결과 및 해석	과의존 위험군	고위험 사용자군	총점 · (성인 만20세~59세) 29점 이상 · (고령층 만60세 이상) 28점 이상 스마트폰 사용에 대한 통제력을 상실한 상태로 일상생활의 상당시간을 스마트폰 사용에 소비하고 있으며 그로 인해 대인관계 갈등이나 일상의 역할 문제, 건강 문제 등이 심각하게 발생한 상태로 ICT 역량 발달을 지체시킬 위험성이 높은 상태 · 스마트폰 과의존 경향성이 매우 높으므로 관련 기관의 전문적인 지원과 도움이 요청
			잠재적위험 사용자군	총점 · (성인 만20세~59세) 28점 이하~24점 이상 · (고령층 만60세 이상) 27점 이하~24점 이상 스마트폰 사용에 대한 조절력이 약화된 상태이며 그로 인해 이용시간이 증가하여 대인관계 갈등이나 일상의 역할에 문제가 발생하기 시작한 단계로 ICT 역량 발달에 부정적 영향을 미칠 위험성이 존재하는 상태 · 스마트폰 과의존 위험을 깨닫고 스스로 조절하고 계획적으로 사용하도록 노력, 스마트폰 과의존에 대한 주의가 요망
		일반사용자군	총점 · (성인 만20세~59세) 23점 이하 · (고령층 만60세 이상) 23점 이하 스마트폰을 조절된 형태로 사용하고 있어서 일상생활의 주요 활동이 스마트폰으로 인해 훼손되는 문제가 발생하지 않는 상태로 ICT 역량 발달 및 발휘를 위한 기본 조건을 충족시키고 있는 상태 · 스마트폰을 건전하게 활용하기 위해 지속적으로 자기 점검	
	저작권	· 한국지능정보사회진흥원		

4) 스마트폰 과의존 청소년 척도

스마트폰 과의존 청소년

성 별	남	여	연 령	실시일				
문 항					전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1	스마트폰 이용시간을 줄이려 할 때마다 실패한다.				1	2	3	4
2	스마트폰 이용시간을 조절 하는 것이 어렵다.				1	2	3	4
3	적절한 스마트폰 이용시간을 지키는 것이 어렵다.				1	2	3	4
4	스마트폰이 옆에 있으면 다른 일에 집중하기 어렵다.				1	2	3	4
5	스마트폰 생각이 머리에서 떠나지 않는다.				1	2	3	4
6	스마트폰을 이용하고 싶은 충동을 강하게 느낀다.				1	2	3	4
7	스마트폰 이용 때문에 건강에 문제가 생긴 적이 있다.				1	2	3	4
8	스마트폰 이용 때문에 가족과 심하게 다툰 적이 있다.				1	2	3	4
9	스마트폰 이용 때문에 친구 혹은 동료, 사회적 관계에서 심한 갈등을 경험한 적이 있다.				1	2	3	4
10	스마트폰 때문에 업무(학업 혹은 직업 등) 수행에 어려움이 있다.				1	2	3	4
각 칸별로 점수를 더해주세요								
총점								

척도명	스마트폰 과의존 청소년 척도																									
출처	한국정보화진흥원(2016), 2016년 인터넷 과의존 실태조사 최종보고서																									
결과해석	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">채점 방법</td><td colspan="2">[1단계] 문항별</td><td>전혀 그렇지 않다: 1점, 그렇지 않다: 2점, 그렇다: 3점, 매우, 그렇다: 4점</td></tr> <tr> <td colspan="2">[2단계] 총점</td><td>문항 1~10번 합계</td></tr> <tr> <td colspan="2">[참고] 요인별</td><td>1 요인 조절실패: 문항 1~3번 합계 2 요인 현저성: 문항 4~6번 합계 3 요인 문제적 결과: 문항 7~10번 합계</td></tr> <tr> <td rowspan="5">결과 및 해석</td><td rowspan="2">과의존 위험군</td><td>고위험 사용자군</td><td>총점 • 31점 이상 스마트폰 사용에 대한 통제력을 상실한 상태로 일상생활의 상당시간을 스마트폰 사용에 소비하고 있으며 그로 인해 대인관계 갈등이나 일상의 역할 문제, 건강 문제 등이 심각하게 발생한 상태로 ICT 역량 발달을 지체시킬 위험성이 높은 상태 • 스마트폰 과의존 경향성이 매우 높으므로 관련 기관의 전문적인 지원과 도움이 요망</td></tr> <tr> <td>잠재적위험 사용자군</td><td>총점 • 30점 이하 ~ 23점 이상 스마트폰 사용에 대한 조절력이 약화된 상태이며 그로 인해 이용시간이 증가하여 대인관계 갈등이나 일상의 역할에 문제가 발생하기 시작한 단계로 ICT 역량 발달에 부정적 영향을 미칠 위험성이 존재하는 상태 • 스마트폰 과의존 위험을 깨닫고 스스로 조절하고 계획적으로 사용하도록 노력, 스마트폰 과의존에 대한 주의가 요망</td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2">일반사용자군</td><td>총점 • 22점 이하</td></tr> <tr> <td>스마트폰을 조절된 형태로 사용하고 있어서 일상생활의 주요 활동이 스마트폰으로 인해 훼손되는 문제가 발생하지 않는 상태로 ICT 역량 발달 및 발휘를 위한 기본 조건을 충족시키고 있는 상태 • 스마트폰을 건전하게 활용하기 위해 지속적으로 자기 점검</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td></tr> </table>			채점 방법	[1단계] 문항별		전혀 그렇지 않다: 1점, 그렇지 않다: 2점, 그렇다: 3점, 매우, 그렇다: 4점	[2단계] 총점		문항 1~10번 합계	[참고] 요인별		1 요인 조절실패: 문항 1~3번 합계 2 요인 현저성: 문항 4~6번 합계 3 요인 문제적 결과: 문항 7~10번 합계	결과 및 해석	과의존 위험군	고위험 사용자군	총점 • 31점 이상 스마트폰 사용에 대한 통제력을 상실한 상태로 일상생활의 상당시간을 스마트폰 사용에 소비하고 있으며 그로 인해 대인관계 갈등이나 일상의 역할 문제, 건강 문제 등이 심각하게 발생한 상태로 ICT 역량 발달을 지체시킬 위험성이 높은 상태 • 스마트폰 과의존 경향성이 매우 높으므로 관련 기관의 전문적인 지원과 도움이 요망	잠재적위험 사용자군	총점 • 30점 이하 ~ 23점 이상 스마트폰 사용에 대한 조절력이 약화된 상태이며 그로 인해 이용시간이 증가하여 대인관계 갈등이나 일상의 역할에 문제가 발생하기 시작한 단계로 ICT 역량 발달에 부정적 영향을 미칠 위험성이 존재하는 상태 • 스마트폰 과의존 위험을 깨닫고 스스로 조절하고 계획적으로 사용하도록 노력, 스마트폰 과의존에 대한 주의가 요망	일반사용자군		총점 • 22점 이하	스마트폰을 조절된 형태로 사용하고 있어서 일상생활의 주요 활동이 스마트폰으로 인해 훼손되는 문제가 발생하지 않는 상태로 ICT 역량 발달 및 발휘를 위한 기본 조건을 충족시키고 있는 상태 • 스마트폰을 건전하게 활용하기 위해 지속적으로 자기 점검			
채점 방법	[1단계] 문항별		전혀 그렇지 않다: 1점, 그렇지 않다: 2점, 그렇다: 3점, 매우, 그렇다: 4점																							
	[2단계] 총점		문항 1~10번 합계																							
	[참고] 요인별		1 요인 조절실패: 문항 1~3번 합계 2 요인 현저성: 문항 4~6번 합계 3 요인 문제적 결과: 문항 7~10번 합계																							
결과 및 해석	과의존 위험군	고위험 사용자군	총점 • 31점 이상 스마트폰 사용에 대한 통제력을 상실한 상태로 일상생활의 상당시간을 스마트폰 사용에 소비하고 있으며 그로 인해 대인관계 갈등이나 일상의 역할 문제, 건강 문제 등이 심각하게 발생한 상태로 ICT 역량 발달을 지체시킬 위험성이 높은 상태 • 스마트폰 과의존 경향성이 매우 높으므로 관련 기관의 전문적인 지원과 도움이 요망																							
		잠재적위험 사용자군	총점 • 30점 이하 ~ 23점 이상 스마트폰 사용에 대한 조절력이 약화된 상태이며 그로 인해 이용시간이 증가하여 대인관계 갈등이나 일상의 역할에 문제가 발생하기 시작한 단계로 ICT 역량 발달에 부정적 영향을 미칠 위험성이 존재하는 상태 • 스마트폰 과의존 위험을 깨닫고 스스로 조절하고 계획적으로 사용하도록 노력, 스마트폰 과의존에 대한 주의가 요망																							
	일반사용자군		총점 • 22점 이하																							
			스마트폰을 조절된 형태로 사용하고 있어서 일상생활의 주요 활동이 스마트폰으로 인해 훼손되는 문제가 발생하지 않는 상태로 ICT 역량 발달 및 발휘를 위한 기본 조건을 충족시키고 있는 상태 • 스마트폰을 건전하게 활용하기 위해 지속적으로 자기 점검																							
저작권	• 한국지능정보사회진흥원																									

5) 성인 도박문제 선별검사 (CPGI)

성인 도박문제 선별검사 (CPGI)

성 별	남	여	연 령	실시일
-----	---	---	-----	-----

각 문항들에 대해 귀하가 지난 1년간 도박(사행성 게임)과 관련하여 경험하신 것을 솔직하게 응답해 주시기 바랍니다.

지난 1년간, 각 문항이 자신에게 해당되는 정도를 나타내는 숫자에 체크표시 ✓해 주십시오.

	문 항	전혀 없다	간혹 그렇다	대체로 그렇다	전혀 그렇지 않다
1	귀하는 도박에서 잃어도 크게 상관 없는 금액 이상으로 도박을 한 적이 있습니까?	0	1	2	3
2	귀하는 도박에서 이전과 같은 흥분감을 느끼기 위해 더 많은 돈을 걸어야 했던 적이 있습니까?	0	1	2	3
3	귀하는 도박으로 잃은 돈을 만회하기 위해 다른 날 다시 도박을 하신 적이 있습니까?	0	1	2	3
4	귀하는 도박자금을 마련하기 위해 돈을 빌리거나 무엇인가를 판 적이 있습니까?	0	1	2	3
5	귀하는 자신의 도박행위가 문제가 될 만한 수준이라고 느낀 적이 있습니까?	0	1	2	3
6	귀하는 도박으로 인해 스트레스나 불안 등을 포함한 어떤 건강상의 문제를 겪은 적이 있습니까?	0	1	2	3
7	귀하는 사실여부에 상관없이 다른 사람들로부터 도박행위를 비난 받거나 도박문제가 있다는 얘기를 들은 적이 있습니까?	0	1	2	3
8	귀하의 도박행위로 인해 본인이나 가정에 재정적인 문제가 발생한 적이 있습니까?	0	1	2	3
9	귀하는 자신의 도박하는 방식이나 도박을 해서 발생한 일에 대해 죄책감을 느낀 적이 있습니까?	0	1	2	3
각 칸별로 점수를 더해주세요					
총점					

척도명	성인 도박문제 선별검사(CPGI)		
출처	한국도박문제예방치유원(2023), 도박문제 선별안내서(성인)		
결과해석	선별검사 결과 합계 점수가 0점이면 비문제 도박, 1~2점이면 저위험 도박, 3~7점이면 중위험 도박, 8~27점이면 문제 도박에 해당하는 것으로 볼 수 있음		
	구분	점수	결과내용
	비문제 도박	0	도박으로 인한 어떤 문제도 없음
	저위험 도박	1~2	- 재미나 사교 목적의 도박, 금액과 시간 조절 가능, 일상생활과 역할에 지장이 없음 - 그러나 도박을 자주 한다면 도박으로 인한 문제가 생길 가능성을 인지해야 함
	중위험 도박	3~7	도박에 사용하는 금액과 시간이 증가하고, 도박행동 및 결과를 숨기며, 조절 능력을 일부 상실하여 일상생활과 역할에 피해가 발생
	문제 도박	8~27	도박행동을 조절하는 능력이 심각하게 상실되어 일상생활과 역할에 심각한 손상을 경험함, 점수가 높을수록 문제의 정도는 더욱 심각함
저작권	한국도박문제예방치유원		

6) 청소년 도박문제 자가검점

청소년 도박문제 자가검점

성 별	남	여	연 령	실시일	
아래 문항은 지난 3개월 동안 자신이 이런 경험들을 겪었는지 겪었다면 얼마나 자주 겪었는지 해당하는 보기 번호에 체크표시 ✓해 주세요.					
문 항		없다	가끔 있다	자주 있다	거의 항상 있다
1	돈내기 게임 때문에 단체 활동이나 연습에 빠진 적이 있나요?	0	1	2	3
2	돈내기 게임을 같이하는 친구들과 어울리느라 다른 친구들과의 약속을 어긴 적 있나요?	0	1	2	3
3	돈내기 게임을 위해 계획을 세운 적이 있나요?	0	1	2	3
4	돈내기 게임 때문에 기분이 나빴던 적이 있나요?	0	1	2	3
5	전에 잃은 돈을 되찾기 위해 다시 돈내기 게임을 한 적이 있나요?	0	1	2	3
6	돈내기 게임 하는 것을 부모나 가족 또는 선생님에게 숨긴 적이 있나요?	0	1	2	3
7	귀하는 사실여부에 상관없이 다른 사람들로부터 도박행위를 비난 받거나 도박문제가 있다는 얘기를 들은 적이 있습니까?	0	1	2	3
아래 두 문항은 응답 보기가 위와 다릅니다.		없다	1~3회 있다	4~6회 있다	7회 이상 있다
8	밥이나 옷, 영화표 구입 등에 써야 할 용돈을 돈내기 게임에 쓴 적이 있나요?	0	1	2	3
9	돈내기 게임을 위해 남의 돈이나 돈이 될 만한 물건을 몰래 가져온 적이 있나요?	0	1	2	3
각 칸별로 점수를 더해주세요					
총점					

척도명	청소년 도박문제 자가점검																
출처	한국도박문제예방치유원(2024), 청소년 도박문제 선별안내서																
결과해석	- 캐나다 청소년 도박 척도(Canadian Adolescent Gambling Inventory, CAGI)는 도박으로 인해 발생할 수 있는 피해나 폐해를 중심으로 13세에서 17세 청소년들의 도박문제를 측정하기 위해 Tremblay, Stinchfield, Wiebe 및 Wynne(2010)이 개발한 자기 보고식 측정도구 - 도박 활동 유형, 각 도박 활동에 대한 참여 횟수, 각 도박 활동에 투자된 시간, 도박에 투자된 총금액, 도박의 폐해 및 심각성에 대한 5개의 영역을 24개의 항목으로 측정함, 이 중 도박문제 심각성 하위척도(Gambling Problems Severity Scale, GPSS; 9항목) 활용																
	<table><tr><th colspan="3">문제수준</th><th>해석 및 특징</th></tr><tr><td>1수준</td><td>비문제 수준</td><td>Green (0~1점)</td><td> - 지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 없거나 돈내기 게임으로 인한 피해나 폐해가 전혀 발생하지 않은 상태로, 만약 돈내기 게임 경험이 있다면 여가 목적으로 조절할 수 있는 수준에서 도박을 하는 상태 </td></tr><tr><td>2수준</td><td>위험 수준</td><td>Yellow (2~5점)</td><td> - 지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 있으며, 경미한(Low) 수준에서 중증도(Moderate) 수준의 조절 실패와 그로 인해 심리/사회/경제적 폐해 등이 발생한 상태로, 문제 수준으로 진행하고 있을 가능성이 의심되는 상태 </td></tr><tr><td>3수준</td><td>문제 수준</td><td>Red (6점이상)</td><td> - 지난 3개월간 반복적인 돈내기 게임 경험이 있으며, 심각한 수준의 조절 실패와 그로 인한 심리/사회/경제적 폐해 역시 심각한 수준으로 진행한 상태로, 도박중독 위험성이 높은 상태 </td></tr></table>	문제수준			해석 및 특징	1수준	비문제 수준	Green (0~1점)	지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 없거나 돈내기 게임으로 인한 피해나 폐해가 전혀 발생하지 않은 상태로, 만약 돈내기 게임 경험이 있다면 여가 목적으로 조절할 수 있는 수준에서 도박을 하는 상태	2수준	위험 수준	Yellow (2~5점)	지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 있으며, 경미한(Low) 수준에서 중증도(Moderate) 수준의 조절 실패와 그로 인해 심리/사회/경제적 폐해 등이 발생한 상태로, 문제 수준으로 진행하고 있을 가능성이 의심되는 상태	3수준	문제 수준	Red (6점이상)	지난 3개월간 반복적인 돈내기 게임 경험이 있으며, 심각한 수준의 조절 실패와 그로 인한 심리/사회/경제적 폐해 역시 심각한 수준으로 진행한 상태로, 도박중독 위험성이 높은 상태
	문제수준			해석 및 특징													
	1수준	비문제 수준	Green (0~1점)	지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 없거나 돈내기 게임으로 인한 피해나 폐해가 전혀 발생하지 않은 상태로, 만약 돈내기 게임 경험이 있다면 여가 목적으로 조절할 수 있는 수준에서 도박을 하는 상태													
2수준	위험 수준	Yellow (2~5점)	지난 3개월간 돈내기 게임 경험이 있으며, 경미한(Low) 수준에서 중증도(Moderate) 수준의 조절 실패와 그로 인해 심리/사회/경제적 폐해 등이 발생한 상태로, 문제 수준으로 진행하고 있을 가능성이 의심되는 상태														
3수준	문제 수준	Red (6점이상)	지난 3개월간 반복적인 돈내기 게임 경험이 있으며, 심각한 수준의 조절 실패와 그로 인한 심리/사회/경제적 폐해 역시 심각한 수준으로 진행한 상태로, 도박중독 위험성이 높은 상태														
저작권	한국도박문제예방치유원																

나. 정신건강사례관리시스템(MHIS)내 검진도구 활용

- ▶ 신규 등록회원과 기존회원의 병력, 기능, 증상과 관련한 상태를 사정(Assessment)을 위해 표준화된 도구를 사용하였을때 입력하는 화면이다. 대상자가 등록 했을 때 평가도구 활용하여 평가 실시하고 그 이후에는 6개월 이내 1회 이상 실시하여야 한다.
- ▶ 정신건강사례관리시스템에 평가도구는 저작권 허용을 받은 표준화된 도구가 탑재되어 있으며 대상자에게 적절한 평가도구를 자율적으로 선택하여 활용할 수 있다. (52~53p 참고)

메뉴위치 사례관리 ▶ 등록회원 ▶ 평가도구

The screenshot displays the '평가도구' (Assessment Tool) interface within the MHIS system. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** Includes a search bar with fields for '회원등록번호' (Member Registration Number), '이름' (Name), '성별' (Gender), '연령' (Age), '직업' (Occupation), and '진단명' (Diagnosis Name). There is also a '조회' (Search) button.
- Table Section:** A table listing assessment tools. The table has columns for '회원등록번호', '이름', '성별', '연령', '진단명', '평가도구명' (Assessment Tool Name), '평가도구' (Assessment Tool), '평가도구' (Assessment Tool), '평가도구' (Assessment Tool), and '평가도구' (Assessment Tool). A red box labeled '3' highlights the '조회 데이터' (Search Data) area.
- Navigation Section:** A horizontal menu with tabs: '전체' (All), '중증정신질환' (Severe Mental Illness), '아동청소년' (Children and Adolescents), '차별예방' (Prevention of Discrimination), and '중독관리' (Addiction Management). A red box labeled '7' highlights the '중독관리' (Addiction Management) tab.
- Target Information Section:** A table with columns for '대상자 정보' (Target Information), including '회원등록번호', '이름', '연락처', '사실관계', '관리구분', '보호대상', '최종관리자', and '진단명'.
- Assessment Tool List Section:** A table with columns: 'No', '평가일' (Evaluation Date), '사실관계' (Facts), '평가도구' (Assessment Tool), '평가일수' (Evaluation Period), '평가결과요약' (Summary of Evaluation Results), '평가자' (Evaluator), and '평가기관' (Evaluation Institution). A red box labeled '4' highlights this section.
- Assessment Tool Detail Section:** A detailed view of a selected assessment tool. It includes fields for '평가일' (Evaluation Date), '평가도구' (Assessment Tool), and '평가일수' (Evaluation Period). A red box labeled '6' highlights this section.

At the bottom, there is a note: '※ CAGE, ESI, K-ASRS, SBQ-R 는 평가일수를 입력해 주세요.' (Please enter the evaluation period for CAGE, ESI, K-ASRS, SBQ-R).

평가도구	[표준화된 도구를 활용해 대상자의 기능, 증상 평가 시 기록] • 조회방법 ① 검색조건을 입력한 후 조회버튼을 클릭한다. ② 조회조건에 해당하는 대상자의 현황이 표출된다. ※ 조회조건에 '전체'선택 시 해당센터 전체 회원의 리스트 표출 ③ 조회데이터에서 해당 대상자를 클릭하면 ④에 기본정보와 평가도구 이력이 표출된다. • 처리방법 ④ 평가도구 이력화면을 클릭하면 ⑥번 화면이 나타난다. ⑤ 신규버튼을 클릭하여 입력창을 활성화한다. ⑥ 평가일, 평가도구를 선택하고 평가결과를 기록한다 ⑦ '저장'버튼을 클릭하여 입력을 완료한다. tip • 사업 영역별로 평가도구를 선택하여 조회 또는 신규생성이 가능 • 유족의 경우 PHQ-9, WHOQOL-B, SBQ-R, K-HGRC 4개 척도 등 사용 권장 • 메뉴에 있는 평가도구는 정신건강사례관리시스템을 통해 사용이 가능한 저작권을 승인 받은 도구임. 각 기관에서는 '정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침'을 통해 복사 및 출력 후 사용한 후 시스템에 결과입력 가능. • 단, 각 기관 홈페이지에 게시 또는 책자에 실을 경우 기관에서 해당하는 저작권을 받아야함.
평가일	• 신규버튼 클릭 시 자동 표출, 수정 가능함.
평가도구	• 척도의 저작권 승인 범위에 따라 문항이 있는 척도와 없는 척도로 구분됨. * 저작권 승인을 받지 못한 경우는 탑재 불가 * 참조사항(평가도구) 표 참조 tip • 평가도구 선택화면에서 도구 앞 자만 입력해도 검색가능 예시) CES-D 검색 → 검색창에 'c'라고 입력하면 빠르게 검색가능
평가점수	• 직접입력(평가문항이 있는 평가도구는 문항별 입력하면 평가점수가 자동 입력됨)
평가결과요약	• 평가점수에 대한 소견을 기술(전반적인 결과, 의미 있는 세부항목 입력 등)
평가자, 평가기관	• 신규버튼 입력 시 평가도구 이력사항에 자동표출 됨.

(국립정신건강센터, 『정신건강사례관리시스템(MHIS) 매뉴얼』, 2024)

6. 중독 정신건강 사업 수행기관

중독대상	관할 부처	사업 수행 기구
알코올	보건복지부	- 정신건강복지센터 - 중독관리통합지원센터 - 기초정신건강복지센터 - 한국건강증진개발원 - 정신건강의학과병(의)원 - 정신재활시설(중독자재활시설)
마약	보건복지부	- 중독관리통합지원센터 - 정신건강의학과병(의)원 - 치료보호기관 - 정신재활시설(중독자재활시설)
	식품의약품안전처	- 마약퇴치운동본부 - 마약퇴치운동본부 및 지부 - 함께한걸음센터
도박	보건복지부	- 정신건강복지센터 - 중독관리통합지원센터 - 기초정신건강복지센터 - 정신건강의학과병(의)원
	사행산업통합감독위원회	- 한국도박문제예방치유원 - 도박문제예방치유센터 - 도박중독 재활시설 - 민간전문상담기관 - 사행산업체 운영 상담기관 - 강원랜드 중독관리센터 - 한국마사회 유캔센터 - 국민체육진흥공단 희망길벗 경륜경정중독예방치유센터 - 동행복권 동행클린센터
인터넷·게임	보건복지부	- 정신건강복지센터 - 중독관리통합지원센터 - 기초정신건강복지센터 - 정신건강의학과병(의)원
	과학기술정보통신부	- 한국지능정보사회진흥원 - 스마트쉼센터
	여성가족부	- 한국청소년상담복지개발원 - 청소년상담복지센터 - 국립청소년인터넷드림마을 - 국립대구청소년상담센터
	교육부	- 위(wee)프로젝트 - 한국교육환경보호원 - 학생정신건강지원센터
	문화체육관광부	- 게임문화재단 - 게임과몰입힐링센터
	서울특별시	- 서울시인터넷중독예방상담센터 - I WILL CENTER

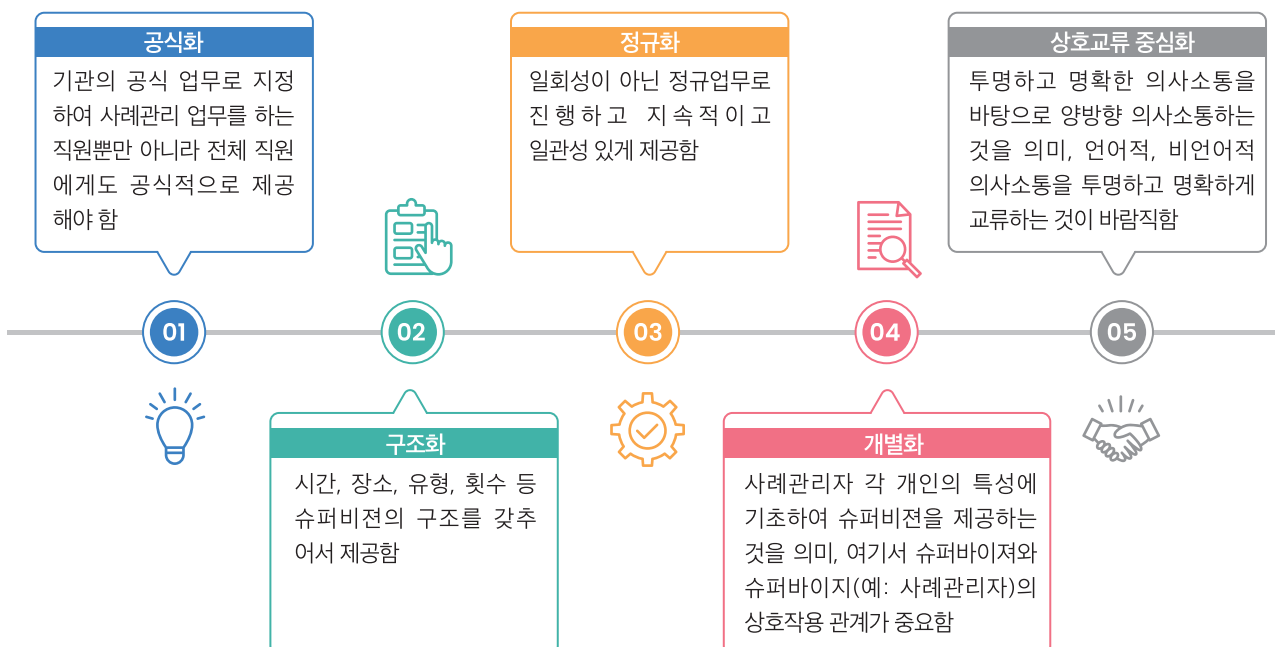
(국립정신건강센터, 『4대중독 기관 현황집』, 2022)

7. 사례관리 서비스 모니터링 체계 및 슈퍼비전

가. 목적 및 필요성

- ▶ 슈퍼비전은 사례관리 서비스 질 향상, 대상자의 문제 해결 지원, 사례관리자의 전문적 성장을 위한 인적 자원 개발방법 중 하나이다.
- ▶ 사례관리 서비스의 강도, 질, 직·간접 서비스의 비중이나 중요도는 사례관리자의 권한과 자율성에 따라 편차가 크므로 높은 수준의 지속적인 슈퍼비전이 필요하다.
- ▶ 슈퍼비전의 궁극적인 목적은 효과적이고 효율적인 사례관리 서비스의 제공이다.
 - 사례관리 서비스의 질 향상
 - 대상자의 문제해결
 - 슈퍼바이저(supervisor)의 전문적 성장
 - 슈퍼바이저(supervisor)의 동기부여
- ▶ 슈퍼비전을 통해 교육과 훈련, 소진 예방, 정체성 확립 등을 제공하여야 한다.

나. 슈퍼비전의 원칙



다. 슈퍼바이저의 자격 및 역할

슈퍼바이저 자격	• 각 기관의 센터장 또는 부센터장 • 사례관리 현장에서 5년 이상의 경력자 또는 팀장급 이상
슈퍼바이저 역량	• 중독 정신건강 서비스 체계에 대한 이해 • 사례관리서비스 업무에 대한 전반적인 이해 • 사례관리서비스 개입 및 평가 방법에 대한 지식 • 개별 또는 그룹 프로그램 계획, 실행, 효과성 평가 제반 지식 • 슈퍼비전 및 리더십 관련 지식
슈퍼바이저와 사례관리자와의 관계	• 신뢰 형성, 상호 존중 및 이해 • 긍정적 의사소통
조직	• 사례관리 업무가 조직 운영체계를 기반으로 운영되는 것과 같이 슈퍼비전도 조직의 공정하고 명문화된 규정과 절차를 마련하여 진행

라. 슈퍼비전 내용

- ▶ Kadushin(1974)는 사례관리 업무수행에 있어서 지지, 조정, 강화, 평가하도록 권위를 받은 슈퍼바이저는 서로의 긍정적인 관계 속에서 상호작용함으로써 교육적, 행정적, 지지적 슈퍼비전 기능을 수행해야 한다고 하였다.

행정적 슈퍼비전	조직의 업무환경을 조성, 조직구조에서 슈퍼바이저를 도울 수 있는 기관 자원에 대한 접근과 효율적 이용을 돕는 것을 말함	• 관리 및 조정: 사례관리자 배치, 업무분장, 조정 및 평가 • 의사소통: 소통, 정보처리 • 변화: 사례관리 운영체계를 위한 변화매개, 지역사회연계 • 옹호: 내적 옹호, 외적 옹호, 행정적 완충
교육적 슈퍼비전	사례관리 역량강화를 위한 지식, 훈련 제공은 다음 내용에 초점을 둠	• 위기개입 • 다양한 증상과 욕구를 가진 대상자에 대한 사정과 개입 • 국가 정신건강정책 • 지역사회 보건복지 자원 이해와 활용 • 문제 사례에 대한 사례관리 수행 • 사례관리자 안전 및 윤리 관련 • 타 직역에 대한 이해 및 협력
지지적 슈퍼비전	사례관리는 사례관리자 개인의 도구적 측면이 강조되기 때문에 업무 수행과정에서 발생하는 업무 긴장, 갈등, 소진을 조정하기 위해 필요, 이를 위하여 다음과 같은 내용을 다루어야 함	• 긴장 관리 • 피드백 • 상호존중: 신뢰, 배려, 개방성

8. 사례관리 윤리와 대상자 권리

사례관리는 전문지식, 기술, 가치에 기반하며, 윤리는 첫 번째 요소이다.
따라서 사례관리자는 윤리적 이슈 관련 질문을 늘 제기하여야 하며, 민감하게 반응하여야 한다.

가. 대상자 동의에 기반한 사례관리 제공(클라이언트의 자기결정)

- ▶ 사례관리에서 대상자는 궁극적으로 자기결정권을 존중받을 권리가 있다 그러므로 사례관리는 대상자의 동의를 기반으로 제공되어야 하고 동의서는 문서화되어야 한다.
- ▶ 만일 대상자가 동의하지 않는 경우 정신과적 증상의 심각성이 대상자 자기결정권보다 우선한다고 판단되고, 가족이 사례관리에 동의할 경우 가족의 동의하에 사례관리를 제공한다.
- ▶ 사례관리 활동내용으로 개별서비스 계획, 경과기록 등은 기록 및 보관되어야 한다.
- ▶ 사례관리 활동내용은 사례관리자와 대상자의 협의를 통해 합의된 장기 목적에 대해 논리적이면서도 명확하게 관련되어 있어야 한다.

나. 개별 사례관리 계획(ISP) 수립 과정에 참여할 권리

- ▶ 대상자는 치료받을 권리와 더불어 자신의 치료 계획에 참여하고, 사례관리 서비스 제공에 사례관리자와 함께 참여할 수 있는 권리도 있다.
- ▶ 따라서 사례관리자는 대상자의 자기 원조의 힘을 인정, 그들의 능력을 강화할 수 있는 서비스를 찾고 이용하도록 도우면서 사례관리 활동에 대한 참여를 격려해야 한다.
- ▶ 대상자의 기대와 욕구를 정기적으로 사정하여 그들의 참여 과정을 계속적으로 보장해야 한다.

다. 비밀보장

- ▶ 사례관리자는 사례관리 대상자들과 관련된 정보에 대한 비밀을 보장해 주어야 한다.
- ▶ 사례관리자는 서비스를 제공하는 과정에서 대상자에 대한 정보를 다른 사람들과 불필요하게 공유하지 않아야 한다.
- ▶ 사례관리자는 필요한 정보만을 모으는 데에 중점을 두어야 한다.
- ▶ 다음과 같은 사항을 사례관리자와 대상자 모두 이해하고 있는지에 대해 명확하게 인식해야 한다.
 - 어떠한 정보를 왜 알아야만 하는지
 - 어떠한 내용이 철저히 비밀에 부쳐져야 하는지
 - 그 정보가 어떻게 이용될 것인지
 - 대상자는 말하지 않을 권리가 있음

- ▶ 대상자 관련 정보를 다른 기관으로부터 가져와야 할 경우, 사례관리자는 대상자에게 정보가 왜 필요한지를 설명한 후 동의를 얻어야 한다.
- ▶ 사례관리자는 사례관리 초기에 회원들에게 비밀보장이 제한될 경우가 생길 수 있음을 설명해야 한다.
- ▶ 즉, 비록 비밀보장이 원칙이지만 완전한 비밀보장의 한계에 대해 대상자와 정직하게 의사소통하는 것이 중요하다.
- ▶ 사례관리자가 팀원 및 가족과 정보를 공유할 경우 대상자에게 어떤 정보를 줄 것인지에 대해 미리 알리고 동의를 구하도록 한다.
- ▶ 사례관리자는 비밀보장에 관한 문제와 이슈에 관해 슈퍼바이저와 항상 상의해야 한다.
- ▶ 다음의 경우에 한하여 비밀보장 원칙에 예외를 둘 수 있다.
 - 등록대상자가 자·타해의 위험이 있을 때
 - 성인 혹은 아동에 대한 학대, 방임, 착취의 가능성이 있을 때
 - 기관 및 지역평가를 위한 익명화 평가자료 제출 시
 - 슈퍼비전을 목적으로 슈퍼바이저와 대상자에 대해 상의할 때

라. 사례관리 내용 및 사례관리자에 대한 선택의 자유

- ▶ 대상자는 자신에게 제공되는 사례관리 내용에 대한 의사 표현을 자유롭게 할 수 있어야 한다.
- ▶ 사례관리는 기본적으로 행정구역에 기반하여 사례관리자가 배정되지만, 대상자는 담당 사례관리자를 직접 선택할 수 있는 자유도 있다.
- ▶ 대상자가 담당 사례관리자의 변경을 희망하는 경우, 팀 회의를 통해 사례관리자의 변경이 대상자의 사례관리에 유익을 주는 것으로 판단되면 사례관리자를 변경하도록 한다.
- ▶ 이 과정에서 사례관리자는 대상자가 자기 결정권을 올바르게 행사할 수 있도록 돕고, 자신의 선택에 대한 최대한의 자기책임성을 성취 하도록 해야 한다.

마. 다양성과 포용성에 기반한 서비스 제공

- ▶ 사례관리자는 대상자의 성별, 연령, 장애, 인종, 문화, 신조 및 지향하는 성에 관한 편견과 차별을 반영하는 언행을 해서는 안 되고, 다른 문화를 가지고 있는 대상자의 개별성과 독립성을 존중해야 한다.
- ▶ 대상자가 가지고 있는 문제는 대상자와 그들의 가족, 그들의 문화속에서 보아야 함을 인식해야 한다.
- ▶ 따라서 의도된 목표에 도달하기 위해서는 대상자의 문화를 고려한 문제해결 방법과 행동을 설정해야 한다.
- ▶ 사례관리자는 자신이 가진 편견, 고정관념, 선입견을 인식하고 있어야 한다.
- ▶ 사례관리자는 대상자들의 권리 존중과 공정한 대우를 위해 그들을 대변하고 옹호해주어야 한다.
- ▶ 또한, 사례관리자는 낙인감소와 사회통합을 위해 노력해야 한다.

바. 이중관계

- ▶ 사례관리자는 대상자들과 건강한 관계를 유지하도록 노력해야 한다.
- ▶ 혼란스럽고 다중적인 관계, 사례관리를 위한 관계의 한계를 초과하는 개입, 경제적, 이성 관계 등의 상황이 발생해서는 안 된다.

가. 의사결정과정

- ▶ 때로는 대상자들의 의사를 존중하고 그들에게 결정권을 주는 것에 딜레마가 생길 수 있다.
- ▶ 대상자가 선택한 대안이 문제해결에 최선이 아닐 경우이거나, 대상자들이 자신의 안정과 욕구충족을 위하여 규범이나 법을 어기는 경우 등에 그에게 결정권을 맡기기가 어려운 경우가 생긴다.
- ▶ 이러한 문제를 해결하기 위해서, 사례관리자는 무엇이 대상자에게 가장 도움이 되는지, 무엇이 가장 윤리적으로 옳은 것인지 그리고 자기가 속한 기관의 지침을 잘 따르고 있는지를 끊임없이 생각해 보아야 할 것이다.

V 참고문헌

- ▶ 학지사, 『정신질환의 진단 및 통계편람 제5판』, 2015
- ▶ 중독포럼, 『중독에대한 100가지 오해와진실』, 2017
- ▶ 광주광역정신건강복지센터·중독포럼, 『중독문제에 대한 선별과 1회기 단기개입 매뉴얼』, 2018
- ▶ 한국중독정신의학회, 『중독정신의학 2nd EDITION』, 2019
- ▶ 국립정신건강센터, 『4대중독 기관 현황집』, 2022
- ▶ 한국사회보장정보원, 『통합사례관리 실천가이드』, 2023
- ▶ 한국도박문제예방치유원, 『도박문제 선별안내서(성인)』, 2023
- ▶ 국립정신건강센터, 『정신건강사례관리시스템(MHIS) 매뉴얼』, 2024
- ▶ 국립정신건강센터, 『한국형-청소년 온라인 도박의 선별과 단기개입』, 2024
- ▶ 보건복지부, 『정신건강사업 안내』, 2025
- ▶ 국립정신건강센터, 『2025 정신건강복지법에 따른 입·퇴원절차 안내』, 2025

MEMO



중독 정신건강 표준 사례관리 매뉴얼

(2025년 개정판)

발행일 : 2025.6.

발행인 : 광영숙

발행처 : 보건복지부 국립정신건강센터

주 소 : (04933) 서울 광진구 용마산로 127

대표전화 : (02) 2204-0114

팩 스 : (02) 2204-0383

홈페이지 : <http://www.ncmh.go.kr>

I S B N : 979-11-94525-32-5



비매품



중독 정신건강 표준 사례관리 매뉴얼

(2025년 개정판)

비매 품



9 791194 525325
ISBN 979-11-94525-32-5